

Buku Referensi

ASUHAN KEPERAWATAN TRANSKULTURAL

dalam Masyarakat Multikultural Indonesia

Nimsi Melati • Tri Mustikowati • Sudarso
Natalia Elisa Rakinaung • Putro Simeulu • Nunuk Sri Purwanti



BUKU REFERENSI: ASUHAN KEPERAWATAN TRANSKULTURAL DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL INDONESIA

Penulis:

Nimsi Melati, S.Kep., Ns., MAN.

Tri Mustikowati, SKp., M.Kep.

Sudarso, S.Kep., Ns., M.Kep.

Natalia Elisa Rakinaung, S.Kep., Ns., MNS.

Ns. Putro Simeulu, S.Kep., M.Kep.

Dr. Nunuk Sri Purwanti, S.Kp., M.Kes.



**Optimal
Untuk
Negeri**

Buku Referensi: Asuhan Keperawatan Transkultural dalam Masyarakat Multikultural Indonesia

Penulis:

Nimsi Melati, S.Kep., Ns., MAN.
Tri Mustikowati, SKp., M.Kep.
Sudarso, S.Kep., Ns., M.Kep.
Natalia Elisa Rakinaung, S.Kep., Ns., MNS.
Ns. Putro Simeulu, S.Kep., M.Kep.
Dr. Nunuk Sri Purwanti, S.Kp., M.Kes.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Helmi Syaukani, S.Pd.

ISBN: 978-634-7556-93-6

Cetakan Pertama: Mei, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2026

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

PENERBIT:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025



PRAKATA



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya buku referensi *Asuhan Keperawatan Transkultural dalam Masyarakat Multikultural Indonesia* ini dapat disusun sebagai salah satu sumber pembelajaran dan rujukan bagi mahasiswa keperawatan, perawat, pendidik, peneliti, serta praktisi kesehatan yang berhadapan langsung dengan keberagaman budaya masyarakat Indonesia.

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan budaya, bahasa, adat istiadat, agama, sistem kepercayaan, serta praktik kesehatan tradisional yang sangat beragam. Keberagaman ini menjadi kekuatan bangsa, tetapi juga menghadirkan tantangan tersendiri dalam pelayanan kesehatan, khususnya dalam praktik keperawatan. Perawat tidak hanya dituntut memiliki kompetensi klinis, tetapi juga kepekaan budaya, kemampuan komunikasi lintas budaya, serta pemahaman terhadap nilai, keyakinan, dan kebiasaan pasien dalam memaknai sehat, sakit, pengobatan, dan proses penyembuhan.

Buku ini hadir untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai pentingnya asuhan keperawatan transkultural dalam konteks masyarakat multikultural Indonesia. Pembahasan diawali dengan teori keperawatan transkultural sebagai dasar konseptual dalam memahami hubungan antara budaya dan praktik keperawatan. Selanjutnya, buku ini menguraikan keanekaragaman budaya dan sistem kepercayaan di Indonesia yang memengaruhi cara masyarakat memandang kesehatan, penyakit, perawatan, serta pengambilan keputusan dalam keluarga dan komunitas.

Salah satu aspek penting yang dibahas dalam buku ini adalah persepsi sakit dan perilaku mencari pengobatan. Dalam masyarakat Indonesia, keputusan untuk mencari pertolongan kesehatan sering kali dipengaruhi oleh faktor budaya, agama, pengalaman keluarga, status sosial ekonomi, serta kepercayaan terhadap pengobatan tradisional maupun modern. Oleh karena itu, perawat perlu memahami latar belakang pasien secara utuh agar dapat memberikan asuhan yang aman, efektif, dan menghormati nilai-nilai budaya pasien.

Buku ini juga membahas integrasi praktik tradisional dalam asuhan keperawatan. Praktik tradisional yang masih hidup di tengah masyarakat tidak selalu harus dipandang sebagai hambatan, melainkan dapat menjadi bagian dari pendekatan holistik selama tidak bertentangan dengan prinsip keselamatan pasien dan etika profesi. Perawat diharapkan mampu melakukan pengkajian budaya, memberikan edukasi yang tepat, serta menjembatani kebutuhan pasien dengan standar pelayanan kesehatan yang berbasis bukti.

Selain itu, pembahasan mengenai komunikasi terapeutik lintas budaya menjadi bagian penting dalam buku ini. Komunikasi yang sensitif terhadap budaya dapat membangun kepercayaan, mengurangi kesalahpahaman, serta meningkatkan keterlibatan pasien dan keluarga dalam proses perawatan. Kemampuan memahami bahasa verbal dan nonverbal, nilai kesopanan, peran keluarga, serta norma budaya tertentu menjadi kompetensi penting bagi perawat dalam memberikan pelayanan yang manusiawi dan bermakna.

Pada bagian akhir, buku ini menawarkan pemikiran mengenai model asuhan transkultural berbasis konteks Indonesia. Model ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam mengembangkan praktik keperawatan yang tidak hanya berorientasi pada aspek biologis, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial, budaya, spiritual, dan komunitas. Dengan demikian, asuhan keperawatan dapat diberikan secara lebih adaptif, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang majemuk.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan di masa mendatang. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk pengembangan keilmuan keperawatan transkultural di Indonesia. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pendidikan, penelitian, dan praktik keperawatan, serta menjadi kontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang berkeadilan, berbudaya, dan berpusat pada pasien.

Mei 2026

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 TEORI KEPERAWATAN TRANSKULTURAL.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Pengertian Teori Keperawatan Transkultural	2
C. Sejarah Tokoh dan Teori	3
D. Konsep Dasar Keperawatan Transkultural	4
E. Model Sunrise Leininger	5
F. Penerapan Dalam Asuhan Keperawatan	7
G. Kelebihan dan Keterbatasan Teori.....	12
H. Penutup.....	13
Referensi.....	14
 BAB 2 KEANEKARAGAMAN BUDAYA DAN SISTEM KEPERCAYAAN DI	
INDONESIA.....	15
A. Pendahuluan.....	15
B. Definisi Budaya.....	16
C. Wujud Kebudayaan.....	17
D. Unsur Kebudayaan	20
E. Kebudayaan dan Kesehatan	21
F. Sistem Kepercayaan di Indonesia.....	22
G. Pokok-pokok Ajaran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.....	22
H. Unsur-Unsur Kepercayaan.....	23
I. Bentuk-Bentuk Aliran Kepercayaan	23
J. Aliran Kepercayaan Terbesar di Indonesia.....	26
K. Kepercayaan dan Kesehatan	27
L. Penutup	29
Referensi.....	30
 BAB 3 PERSEPSI SAKIT DAN PERILAKU Mencari Pengobatan.....	32
A. Pendahuluan.....	32
B. Proses Persepsi.....	35
C. Syarat Terjadinya Persepsi	36
D. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi.....	37
E. Jenis Persepsi.....	42
F. Indikator Persepsi.....	42

G. Komponen Kunci Persepsi Sakit Health Belief Model.....	43
H. Perilaku Mencari Pengobatan Health Seeking Behavior.....	43
I. Hubungan Persepsi Sakit dan Pemanfaatan Layanan Kesehatan.....	45
J. Stigma Dan Persepsi Negatif.....	45
K. Studi Kasus.....	46
L. Self Care Inisiatif Mandiri Dalam Kesehatan	48
M. Persepsi Masyarakat Terhadap Sakit dan Penyakit.....	49
N. Perilaku Mencari Pengobatan Dalam Konteks Indonesia.....	50
O. Perjalanan Kesehatan.....	52
P. Menuju Kesehatan Yang Lebih Baik.....	53
Q. Penutup	53
Referensi.....	55
Glosarium	56

BAB 4 INTEGRASI PRAKTIK TRADITIONAL DALAM ASUHAN

KEPERAWATAN	58
A. Pendahuluan.....	58
B. Konsep Dasar Praktik Tradisional dalam Konteks Keperawatan.....	59
C. Jenis – Jenis Praktik Tradisional yang Relevan dalam Asuhan Keperawatan	61
D. Prinsip-Prinsip Integrasi Praktik Tradisional dalam Asuhan Keperawatan.....	66
E. Asesmen Keperawatan Berbasis Budaya.....	68
F. Implementasi Integrasi Praktik Tradisional dalam Proses Keperawatan	69
G. Tantangan dan Hambatan dalam Integrasi Praktik Tradisional	71
H. Implikasi bagi Pendidikan dan Pengembangan Profesional Keperawatan.....	73
I. Penutup	74
Referensi.....	76

BAB 5 KOMUNIKASI TERAPEUTIK LINTAS BUDAYA

A. Pendahuluan.....	79
B. Konsep Komunikasi Terapeutik dalam Keperawatan.....	79
C. Budaya dalam Konteks Pelayanan Kesehatan	80
D. Peran Perawat dalam Komunikasi Lintas Budaya	82
E. Penerapan Komunikasi Terapeutik pada Berbagai Konteks Budaya	83
F. Hambatan dalam Komunikasi Terapeutik Lintas Budaya	85
G. Strategi Praktis dalam Komunikasi Terapeutik Lintas Budaya.....	87
H. Aplikasi Komunikasi Terapeutik dalam Praktik Keperawatan.....	87
I. Penutup	89
Referensi.....	91
Glosarium	93

BAB 6	MODEL ASUHAN TRANSKULTURAL BERBASIS KONTEKS	
INDONESIA		96
A. Pendahuluan		96
B. Konsep Dasar Keperawatan Transkultural		97
C. Konteks Sosial Budaya Masyarakat Indonesia		99
D. Model Asuhan Transkultural Berbasis Konteks Indonesia		100
E. Implementasi Model Asuhan Transkultural dalam Praktik Keperawatan		103
F. Integrasi SDKI–SLKI–SIKI dalam Model Asuhan Transkultural Berbasis Konteks Indonesia		104
G. Studi Kasus Kontekstual Indonesia		106
H. Tantangan dan Strategi Pengembangan Model Asuhan Transkultural		110
I. Penutup		114
Referensi		116
Glosarium		118
PROFIL PENULIS		122

BAB 1

TEORI KEPERAWATAN TRANSKULTURAL

A. Pendahuluan

Teori keperawatan dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan intervensi asuhan keperawatan dengan mengintegrasikan teori, praktik, kebijakan, dan penelitian keperawatan (Mintz-Binder, 2019). Pelayanan keperawatan yang optimal harus bersifat holistik dengan memperhatikan aspek bio-psiko-sosio-kultural-spiritual. Salah satu teori yang mendukung pendekatan komprehensif tersebut adalah teori transcultural nursing yang dikembangkan oleh Madeleine Leininger, yang menekankan pentingnya kesesuaian budaya dalam pemberian asuhan keperawatan (Hardini et al., 2019).

Budaya dapat dipahami dari berbagai sudut pandang. Perilaku yang ditunjukkan oleh kelompok masyarakat di seluruh dunia memiliki perbedaan satu sama lain, dan dari kebiasaan-kebiasaan tersebut terbentuklah suatu budaya tertentu. Selain itu, respons masyarakat terhadap suatu peristiwa dalam kehidupan juga berbeda-beda, yang dipengaruhi oleh kebiasaan serta cara kelompok tersebut dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah (Pratiwi, 2010).

Meskipun setiap kelompok memiliki pola yang dapat diamati yang membedakannya dari kelompok lain, sebagian besar individu juga dapat menunjukkan keyakinan atau sifat yang tidak selalu sesuai dengan norma kelompoknya. Seseorang bisa saja memiliki pandangan yang sangat tradisional dalam harapan dan cara berpikirnya. Selain itu, terdapat variasi yang signifikan baik di dalam suatu kelompok maupun antar kelompok.

Pengetahuan tentang karakteristik kelompok memang bernilai dalam memberikan gambaran harapan yang realistis, namun hal tersebut tidak cukup. Pemahaman yang lebih mendalam hanya dapat diperoleh melalui pembelajaran terhadap individu atau keluarga yang sedang ditangani, sehingga tenaga kesehatan dapat memahami sejauh mana pola budaya kelompok tersebut benar-benar bermakna dalam konteks asuhan keperawatan (Leininger, 2000).

Salah satu tokoh penting yang akan dibahas adalah Madeleine M. Leininger, seorang pelopor dalam keperawatan yang mengembangkan teori berbasis keberagaman dan universalitas budaya. Pemikirannya memberikan kontribusi besar dalam memahami praktik keperawatan yang sensitif terhadap latar belakang budaya pasien.

Pemahaman mengenai budaya merupakan dasar penting sebelum mempelajari keperawatan transkultural. Konsep budaya mencakup gambaran perilaku dan sikap yang mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh suatu kelompok, yang dapat dipahami melalui kajian antropologi dan antropologi kesehatan.

Selain itu, dalam penerapan keperawatan transkultural, perawat juga perlu meninjau kembali paradigma keperawatan sebagai landasan dalam memberikan asuhan yang tepat dan sesuai dengan latar belakang budaya pasien.

Buku ini mengulas perjalanan hidup tokoh, konsep teoritis yang dikembangkan, serta penerapan teori keperawatan transkultural dalam praktik. Pembahasan tersebut dikaitkan dengan realitas model asuhan keperawatan yang terus berkembang hingga saat ini. Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat menjadi sarana refleksi kritis dalam menghadapi berbagai permasalahan kompleks dalam praktik keperawatan.

B. Pengertian Teori Keperawatan Transkultural

Transcultural Nursing, yang juga dikenal sebagai *Culture Care Theory*, merupakan konsep yang berasal dari perpaduan ilmu antropologi dan keperawatan. Leininger mendefinisikan keperawatan transkultural sebagai bidang utama dalam keperawatan yang berfokus pada studi perbandingan serta analisis berbagai budaya dan subkultur di seluruh dunia, dengan memperhatikan nilai, praktik, keyakinan terkait sehat-sakit, serta pola perilaku masyarakat.

Culture care merupakan teori keperawatan yang bersifat luas karena mencakup pandangan kehidupan manusia secara holistik serta mempertimbangkan keberadaannya sepanjang waktu. Teori ini meliputi berbagai faktor seperti struktur sosial, pandangan dunia, nilai-nilai dan sejarah budaya, konteks lingkungan (Leininger, 1981), bahasa, serta pola perilaku baik yang bersifat umum (generik) maupun profesional dalam perspektif budaya.

Keseluruhan aspek tersebut menjadi landasan penting dalam mengembangkan pengetahuan dasar tentang perawatan, yang merupakan inti dari praktik keperawatan dan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan klien serta mendukung praktik keperawatan yang bersifat terapeutik.

Teori keperawatan transkultural ini secara jelas berfokus pada penemuan asuhan berbasis budaya yang holistik dan komprehensif. Teori ini dapat diterapkan baik pada budaya Barat maupun non-Barat karena beberapa aspek holistik bersifat universal. Pendekatan ini bertujuan mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi perawatan manusia, seperti pandangan dunia, struktur sosial, bahasa, praktik perawatan tradisional dan profesional, etnohistory, serta konteks lingkungan.

Tujuan dari teori ini adalah untuk menemukan beragam cara dalam memberikan asuhan kepada klien yang bersifat universal, dengan mempertimbangkan pandangan hidup (*worldview*), struktur sosial, serta dimensi lainnya. Melalui pendekatan tersebut, perawat dapat menentukan cara yang paling tepat dan sesuai bagi individu dari latar budaya yang berbeda, baik dalam upaya menjaga kesehatan maupun dalam menghadapi kondisi terminal dengan pendekatan yang sensitif terhadap budaya.

Selain itu, teori ini memiliki tiga modalitas praktik sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan tindakan keperawatan yang selaras dengan budaya, guna mendukung kesehatan, kesejahteraan, dan kualitas hidup individu. Pada akhirnya, teori ini dirancang untuk mengungkap aspek-aspek perawatan yang bersifat beragam maupun universal, serta menekankan identifikasi praktik keperawatan transkultural yang mungkin berbeda atau bertentangan dengan konsep perawatan tertentu.

C. Sejarah Tokoh dan Teori

Madeleine M. Leininger merupakan seorang perawat yang memelopori keperawatan transkultural serta dikenal sebagai tokoh utama dalam pengembangan teori *human care*. Pada tahun 1950, ia meraih gelar sarjana di bidang biologi dari Benedictine College di Atchison, Kansas, tempat ia juga mempelajari dasar-dasar ilmu humaniora dan filsafat. Selanjutnya, ia melanjutkan pendidikan keperawatannya di Creighton University di Omaha, Nebraska (Leininger, 1995c, 1996b).

Pada tahun 1954, Madeleine M. Leininger memperoleh gelar magister dalam keperawatan jiwa dari Catholic University of America. Ia kemudian bekerja sebagai staf pengajar di fakultas kesehatan University of Cincinnati. Selain itu, ia melanjutkan studi doktoralnya di University of Washington. Sebagai mahasiswa doktoral, Leininger memusatkan penelitiannya pada masyarakat Gadsup di Dataran Tinggi Timur New Guinea. Ia tinggal bersama masyarakat setempat selama dua tahun dan melakukan studi etnografi serta etnonursing di dua desa (Leininger, 1995c, 1996b). Berdasarkan hasil penelitian dan observasi langsung tersebut, ia mengembangkan teori asuhan budaya yang dikenal sebagai *Culture Care Theory of Diversity and Universality* (teori *culture care*), serta metode etnonursing (Leininger, 1978, 1981, 1991b, 1995c).

Madeleine M. Leininger (1991b) mengembangkan *Culture Care Theory of Diversity and Universality* berdasarkan keyakinan bahwa individu dari latar budaya yang berbeda mampu menjelaskan serta membimbing tenaga profesional dalam memberikan perawatan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan mereka.

Madeleine M. Leininger meletakkan dasar bagi pengembangan keperawatan transkultural, teori *culture care*, serta pelayanan kesehatan berbasis budaya melalui bukunya yang berjudul *Nursing and Anthropology: Two Worlds to Blend* (1970). Mata kuliah *transcultural nursing* pertama kali ditawarkan pada tahun 1966 di University of Colorado, tempat Leininger menjabat sebagai profesor keperawatan dan antropologi. Pada tahun 1969, ia diangkat sebagai dekan sekaligus profesor keperawatan, serta dosen antropologi di University of Washington.

Teori asuhan budaya yang dikembangkan oleh Madeleine M. Leininger telah diterapkan secara luas di berbagai belahan dunia dan terus berkembang seiring dengan ditemukannya pengetahuan baru dari beragam budaya. Tujuan utama teori tersebut adalah untuk mengidentifikasi keragaman dan kesamaan (universalitas) dalam praktik asuhan manusia yang berkaitan dengan pandangan hidup, struktur sosial, serta dimensi lainnya. Selanjutnya, teori ini bertujuan menemukan cara memberikan perawatan yang selaras dengan nilai budaya, baik pada individu dengan latar budaya yang sama maupun berbeda, guna mempertahankan atau memulihkan kesehatan dan kesejahteraan mereka, serta membantu mereka menghadapi kematian dengan cara yang sesuai dengan budaya masing-masing (Leininger, 1985b, 1988b, 1988c, 1988d; dikutip dalam 1991b).

D. Konsep Dasar Keperawatan Transkultural

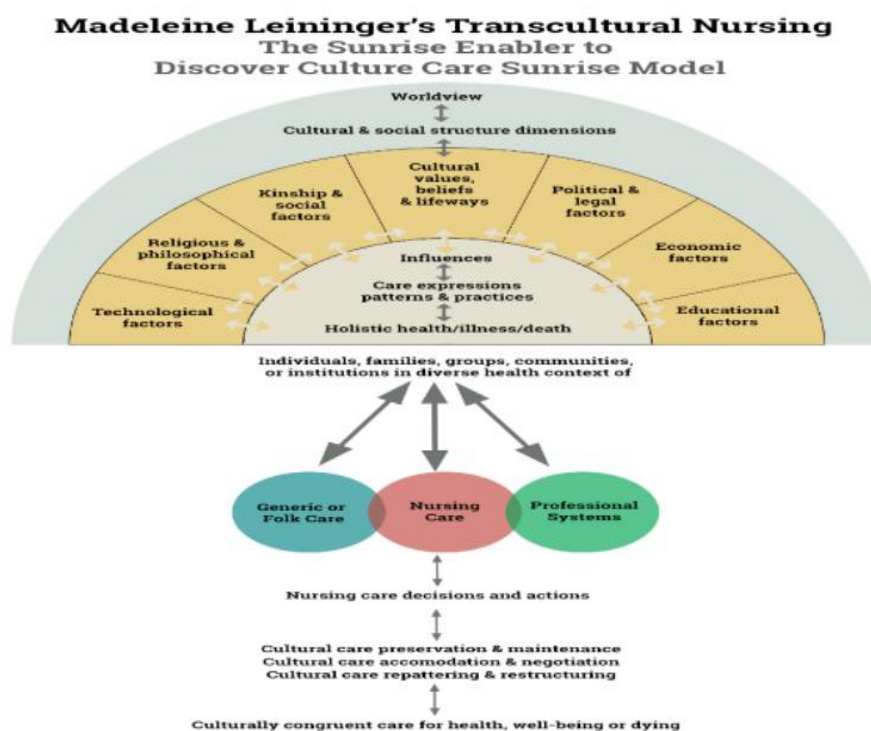
Keperawatan transkultural adalah istilah yang sering digunakan secara bergantian dengan keperawatan antarbudaya, interkultural, atau multikultural. Istilah ini merujuk pada suatu disiplin ilmu yang terstruktur sekaligus praktik pemberian asuhan keperawatan yang mempertimbangkan aspek budaya pada individu maupun kelompok dengan latar budaya tertentu (Brunner dan Suddart, 2007).

Dalam keperawatan transkultural, pemberian asuhan keperawatan diarahkan untuk memberikan pelayanan yang selaras dengan nilai budaya, keyakinan, dan praktik yang dianut pasien. Pemahaman terhadap budaya sangat penting bagi perawat dalam memberikan asuhan, karena membantu perawat mengenali bagaimana sistem kepercayaan dan budaya pasien menjadi sumber makna dalam menghadapi penyakit, penderitaan, bahkan kematian. Hal ini memungkinkan perawat untuk lebih memahami serta menghargai keberagaman yang dimiliki setiap pasien. Selain itu, pemahaman budaya juga memperkuat hubungan terapeutik antara perawat dan pasien dengan menekankan pandangan holistik terhadap individu, bukan hanya sebagai kumpulan gejala penyakit.

Penggunaan pengetahuan budaya juga membuka wawasan perawat terhadap berbagai bentuk pengobatan yang mungkin tidak termasuk dalam praktik medis

konvensional, seperti terapi spiritual, meditasi, atau praktik pengobatan tradisional lainnya. Oleh karena itu, perawat dituntut untuk peka terhadap latar belakang budaya pasien dalam menyusun rencana asuhan keperawatan. Hal ini penting karena budaya merupakan bagian integral dari identitas individu yang dapat memengaruhi kondisi kesehatan, serta respons terhadap penyakit dan terapi yang diberikan. Dengan memahami perbedaan budaya, perawat dapat merancang intervensi keperawatan yang lebih sesuai dan spesifik secara budaya. Melalui teori Leininger, perawat dapat mengkaji hubungan antara budaya dan kesehatan pasien untuk menyusun rencana perawatan yang efektif, mempercepat proses penyembuhan, serta tetap menghormati nilai budaya yang dimiliki pasien.

E. Model Sunrise Leininger



Gambar 1.1
Dimensi Keragaman Dan Universalitas Perawatan Budaya
Sumber: (Fraktur et al., 2024)

Teori ini terdapat 7 komponen ada pada Sunrise Model sebagai dasar pengkajian:

1. Faktor pendidikan (*educational factor*)

Latar belakang pendidikan pasien mencerminkan pengalaman formal yang telah ditempuh hingga jenjang tertinggi. Semakin tinggi tingkat pendidikan, umumnya keyakinan individu didasarkan pada bukti ilmiah yang rasional. Selain itu, individu juga lebih mampu beradaptasi dengan budaya yang sesuai dengan

kondisi kesehatannya (Leininger, 2002). Pada tahap ini, hal yang perlu dikaji meliputi tingkat pendidikan pasien dan keluarga, jenis pendidikan, serta kemampuan belajar mandiri terkait pengalaman sakit agar tidak terulang.

2. Faktor ekonomi (*economic factor*)

Ekonomi berkaitan dengan kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan material dari sumber yang terbatas, termasuk biaya pengobatan selama sakit. Dalam teori transcultural nursing, faktor ekonomi yang perlu dikaji meliputi pendapatan keluarga, sumber penghasilan lain, kepemilikan asuransi kesehatan, serta pengaruh kondisi ekonomi terhadap status kesehatan.

3. Faktor peraturan dan kebijakan (*political and legal factor*)

Dalam asuhan keperawatan transkultural, aktivitas individu dipengaruhi oleh aturan dan kebijakan yang berlaku di fasilitas kesehatan (Kemenkes, 2016). Kebijakan tersebut mencerminkan peran negara melalui regulasi yang menjadi dasar pelayanan kesehatan, sehingga perlu dikaji karena berdampak pada proses pemberian asuhan keperawatan lintas budaya.

4. Faktor nilai budaya, keyakinan dan gaya hidup (*cultural values, beliefs and life ways*)

Budaya merupakan norma dan perilaku yang dipelajari serta dibagikan dalam suatu kelompok, yang memandu cara berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan (Leininger, 2002). Nilai adalah konsep abstrak mengenai baik dan buruk yang dianut individu. Nilai budaya adalah standar baik dan buruk yang ditetapkan oleh suatu kelompok budaya (Subarkah, Nursalam, & Rachmawati, 2016). Perawat perlu mengkaji peran kepala keluarga, bahasa yang digunakan, kebiasaan kebersihan diri, pola makan, pantangan saat sakit, serta persepsi penyakit dalam kehidupan sehari-hari.

5. Faktor sosial dan keluarga (*kinship and social factor*)

Fungsi keluarga dan sosial berperan sebagai sistem pendukung bagi anggota dalam meningkatkan kesehatan dan proses adaptasi. Hal ini mencakup hubungan sosial dan kebiasaan yang berkembang di lingkungan klien. Perawat perlu mengkaji identitas klien, usia, jenis kelamin, status, tipe keluarga, pola pengambilan keputusan, hubungan dengan kepala keluarga, serta dukungan keluarga dalam bentuk waktu, perhatian, dan bantuan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial.

6. Faktor religiusitas/agama dan filosofi (*religious and philosophical factor*)

Agama dan filosofi hidup memberikan motivasi kuat dalam menentukan nilai kebenaran, bahkan melebihi kepentingan pribadi, serta membentuk sikap rendah hati dan keterbukaan. Aspek yang perlu dikaji meliputi agama yang dianut, pandangan terhadap penyakit dan pengobatan, praktik keagamaan,

makna hidup, kepercayaan, spiritualitas, nilai personal dan norma, hingga kebebasan berpikir dan berekspresi. Agama menjadi pedoman utama dalam menilai baik dan buruk serta benar dan salah dalam kehidupan klien.

7. Faktor teknologi (*technology factor*)

Teknologi berperan sebagai media penyebaran informasi yang memengaruhi perilaku individu dalam konteks budaya (Leininger, 2002). Informasi ini membantu mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam praktik perawatan budaya. Berdasarkan hal tersebut, perawat dapat menentukan tindakan keperawatan seperti mempertahankan, menyesuaikan, atau memodifikasi perawatan budaya. Oleh karena itu, perawat perlu mengkaji persepsi sehat-sakit, kebiasaan mencari pengobatan, alasan memilih layanan kesehatan atau alternatif, serta pandangan klien terhadap penggunaan teknologi dalam mengatasi masalah kesehatan.

Tindakan keperawatan yang diberikan kepada klien perlu mempertimbangkan tiga prinsip utama dalam asuhan keperawatan, yaitu:

1. *Culture care preservation/maintenance*, yaitu prinsip yang berfokus pada upaya membantu, memfasilitasi, serta mempertahankan nilai-nilai budaya yang dimiliki individu. Tujuannya adalah mendukung klien dalam menentukan tingkat kesehatan serta gaya hidup yang diinginkan sesuai dengan budayanya.
2. *Culture care accommodation/negotiation*, yaitu prinsip yang menekankan proses membantu dan memfasilitasi klien dalam beradaptasi atau melakukan negosiasi terhadap praktik budaya yang ada, dengan tetap mempertimbangkan kondisi kesehatan serta gaya hidup individu agar tercapai kesepakatan yang sesuai.
3. *Culture care repatterning/restructuring*, yaitu prinsip yang mengarah pada proses rekonstruksi atau perubahan pola hidup dan praktik budaya klien, dengan tujuan memperbaiki kondisi kesehatan serta mengarahkan gaya hidup ke arah yang lebih sehat dan adaptif.

F. Penerapan Dalam Asuhan Keperawatan

Keperawatan dipahami sebagai suatu ilmu sekaligus seni dalam memberikan asuhan kepada pasien, dengan menitikberatkan pada perilaku, fungsi, serta proses yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan kesehatan, dan membantu pemulihan dari penyakit. Dalam teori keperawatan transkultural, peran perawat adalah sebagai penghubung antara sistem perawatan tradisional yang berkembang di masyarakat dengan sistem perawatan profesional melalui pemberian asuhan keperawatan. Keberadaan peran ini digambarkan oleh Leininger melalui *Sunrise Model* (Gambar 1), yang menunjukkan hubungan berbagai faktor budaya dalam

praktik keperawatan. Oleh karena itu, perawat dituntut untuk mampu mengambil keputusan serta menyusun rencana tindakan keperawatan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Asmadi, 2008).

Dalam hal ini, konsep utama yang digunakan adalah model keperawatan dalam teori transcultural yang sebagai berikut:

1. *Culture care*

Nilai, keyakinan, norma, dan pandangan hidup yang diperoleh melalui proses pembelajaran serta diwariskan dari generasi ke generasi, diyakini mampu mendukung pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup individu.

2. *World view*

Cara individu atau kelompok memahami dan menilai kehidupan yang kemudian membentuk keyakinan serta sistem nilai yang mereka anut.

3. *Culture and Social Structure Dimention*

Dampak dari berbagai faktor budaya, termasuk subbudaya seperti aspek religius, kekeluargaan, politik dan hukum, ekonomi, pendidikan, teknologi, serta nilai-nilai budaya, yang saling berkaitan dan bersama-sama memengaruhi perilaku individu dalam berbagai konteks lingkungan.

4. *Genetic Care System*

Praktik budaya tradisional yang diwariskan secara turun-temurun untuk membantu dan mendukung individu dalam mencapai kondisi kesehatan, serta memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup, termasuk dalam menghadapi kecacatan maupun kematian.

5. *Profesional system*

Layanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional yang telah memperoleh pengetahuan melalui pendidikan formal dan menjalankan praktik pelayanan secara kompeten serta sesuai standar profesional.

6. *Culture Care Preservation*

Upaya untuk mendukung dan memfasilitasi tindakan profesional dalam pengambilan keputusan guna mempertahankan serta menjaga nilai-nilai pada individu maupun kelompok, sehingga kesejahteraan tetap terpelihara.

7. *Culture Care Acomodation*

Suatu teknik negosiasi yang digunakan untuk memfasilitasi individu atau kelompok dengan latar budaya tertentu dalam beradaptasi atau mencapai kesepakatan terkait tindakan serta pengambilan keputusan dalam bidang kesehatan.

8. *Cultural Care Repatterning*

Proses penataan ulang yang bertujuan untuk memfasilitasi tindakan serta pengambilan keputusan profesional sehingga dapat mendorong perubahan pola hidup seseorang.

9. *Culture Congruent / Nursing Care*

Suatu kesadaran untuk menyesuaikan nilai-nilai budaya / keyakinan dan cara hidup individu/ golongan atau institusi dalam upaya memberikan asuhan keperawatan yang bermanfaat.

Teori Madeleine Leininger dapat diterapkan dalam beberapa bidang berikut:

1. Riset: Teori Leininger telah banyak digunakan dalam penelitian lintas budaya di berbagai negara. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah teori etnonursing, yang menekankan pentingnya memahami latar belakang budaya pasien dalam memberikan pelayanan kesehatan.
2. Edukasi: Keberagaman budaya mulai diintegrasikan ke dalam kurikulum keperawatan, terutama sejak National League of Nursing (NLN) mengembangkan panduan yang menyoroti aspek sosiologi dan isu sosial dalam praktik keperawatan. Teori Leininger memberikan kontribusi besar dalam pengembangan pembelajaran keperawatan secara global.
3. Kolaborasi: Pemahaman terhadap budaya pasien menjadi dasar dalam menentukan strategi kolaboratif dalam proses asuhan keperawatan, sehingga pelayanan yang diberikan lebih sesuai dengan kebutuhan pasien.
4. Pemberi perawatan: Sebagai pemberi asuhan, perawat perlu memahami konsep keperawatan transkultural. Jika diabaikan, dapat terjadi *cultural shock* pada pasien atau *culture imposition*, yaitu kecenderungan tenaga kesehatan memaksakan nilai dan keyakinan budayanya kepada pasien.
5. Manajemen: Dalam praktik manajemen pelayanan kesehatan, penggunaan bahasa daerah pasien saat berinteraksi dapat meningkatkan kenyamanan dan kedekatan pasien dengan tenaga kesehatan, sehingga kualitas pelayanan menjadi lebih baik.

Penerapan Kasus

Berikut adalah contoh penerapan kasus keperawatan transkultural:

Ny. S berusia 55 tahun, tinggal di daerah pedesaan di Jawa Tengah bersama suami dan anak bungsunya. Ny. S tidak menempuh pendidikan formal hingga jenjang tinggi, hanya lulus Sekolah Dasar. Ia bekerja sebagai petani kecil di ladang keluarga, sedangkan suaminya bekerja sebagai buruh harian.

Masyarakat di lingkungan Ny. S masih cukup kuat memegang tradisi pengobatan herbal dan kepercayaan terhadap “dukun pijat” untuk mengatasi nyeri dan penyakit tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, Ny. S juga aktif mengikuti kegiatan pengajian dan sangat mempercayai bahwa kesehatan dan penyakit merupakan bagian dari kehendak Tuhan. Suatu hari, Ny. S mengalami luka pada kaki akibat terpeleset saat bekerja di sawah. Luka tersebut awalnya kecil, namun semakin lama menjadi merah, bengkak, dan mengeluarkan nanah. Ny. S tidak segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan karena menganggap luka tersebut hanya “masuk angin” dan dapat sembuh dengan ramuan tradisional serta pijatan dari dukun setempat.

Setelah beberapa hari, kondisi luka semakin parah disertai demam dan nyeri hebat. Keluarga kemudian membawa Ny. S ke puskesmas. Petugas kesehatan menemukan adanya infeksi luka yang sudah meluas dan berisiko komplikasi. Ny. S kemudian diberikan pengobatan medis serta edukasi mengenai perawatan luka yang benar. Namun, dalam proses perawatan di rumah, keluarga masih mengombinasikan obat medis dengan ramuan tradisional karena keyakinan bahwa pengobatan tradisional lebih “alami” dan aman.

Pengkajian

1. Faktor Teknologi: Pemanfaatan layanan kesehatan modern baru dilakukan setelah kondisi memburuk. Pada awalnya, keluarga lebih memilih pengobatan tradisional seperti ramuan herbal dan pijat dukun dibandingkan fasilitas kesehatan formal.
2. Faktor Kepercayaan: Ny. S memiliki keyakinan yang kuat bahwa sakit merupakan bagian dari kehendak Tuhan. Hal ini membuat pasien lebih pasrah dan cenderung tidak segera mencari pengobatan medis.
3. Faktor Kekeluargaan dan Sosial: Ny. S, perempuan berusia 55 tahun, berstatus dewasa, bekerja sebagai petani dengan pendidikan terakhir Sekolah Dasar. Ia merupakan anggota keluarga inti yang tinggal bersama suami dan anak bungsu. Pengambil keputusan dalam keluarga adalah suami sebagai kepala keluarga. Dalam kebiasaan sehari-hari, keluarga cenderung menggunakan pengobatan tradisional seperti ramuan herbal dan dukun pijat ketika mengalami sakit, karena masih mempercayai metode tersebut lebih aman dibandingkan pengobatan medis.
4. Nilai-nilai Budaya, Kepercayaan, dan Gaya Hidup: Faktor ini terlihat dari kuatnya budaya lokal dalam keluarga Ny. S yang masih mengandalkan pengobatan tradisional. Saat Ny. S mengalami luka kaki, keluarga tidak segera membawa ke fasilitas kesehatan karena menganggap kondisi tersebut masih dapat sembuh

dengan cara tradisional. Hal ini menunjukkan adanya persepsi penyakit yang tidak sesuai dengan konsep kesehatan modern, di mana sakit seharusnya dipahami sebagai gangguan fungsi biologis, psikologis, sosial, dan spiritual yang memerlukan penanganan medis yang tepat.

5. Faktor Kebijakan dan Peraturan: Faktor ini dapat dilihat dari ketersediaan fasilitas kesehatan di lingkungan sekitar seperti puskesmas. Meskipun layanan kesehatan tersedia, keluarga tetap mengikuti kebiasaan dan kepercayaan lokal terlebih dahulu sebelum memanfaatkan layanan formal.
6. Faktor Ekonomi: Kondisi ekonomi keluarga Ny. S tergolong rendah hingga cukup, dengan pekerjaan sebagai petani dan buruh harian. Meskipun biaya menjadi pertimbangan, faktor ekonomi bukan hambatan utama, namun lebih dipengaruhi oleh kebiasaan dan kepercayaan dalam pengambilan keputusan kesehatan.
7. Faktor Pendidikan: Tingkat pendidikan Ny. S dan keluarga yang rendah (Sekolah Dasar) memengaruhi kurangnya pemahaman mengenai tanda bahaya infeksi dan pentingnya penanganan medis dini. Hal ini berdampak pada keterlambatan dalam mencari pelayanan kesehatan dan masih kuatnya kepercayaan terhadap pengobatan tradisional.

Asuhan Keperawatan

1. Diagnosa Keperawatan

- a. Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan (D.0116) berhubungan dengan kuatnya kepercayaan terhadap pengobatan tradisional dan rendahnya pemahaman tentang penyakit, ditandai dengan keterlambatan membawa pasien ke fasilitas kesehatan.
- b. Defisit pengetahuan (*deficient knowledge*) (D.0111) tentang proses penyakit dan perawatan luka berhubungan dengan tingkat pendidikan rendah dan dominasi budaya pengobatan tradisional.
- c. Risiko infeksi (*risk for infection*) (D.0142) berhubungan dengan penanganan luka yang tidak adekuat dan keterlambatan mendapatkan perawatan medis.

2. Intervensi Keperawatan

- a. *Culture Care Preservation/Maintenance* (Mempertahankan budaya yang positif)
Perawat mempertahankan nilai positif dalam keluarga Ny. S seperti keyakinan religius dan dukungan keluarga yang kuat. Perawat dapat mendorong pasien untuk tetap berdoa atau melakukan aktivitas spiritual sesuai keyakinan tanpa mengganggu proses pengobatan medis.
- b. *Culture Care Accommodation/Negotiation* (Akomodasi/negosiasi budaya)

Perawat melakukan pendekatan dengan menghargai kepercayaan keluarga terhadap pengobatan tradisional. Misalnya, mengizinkan penggunaan ramuan herbal yang tidak berbahaya sebagai terapi pendamping, dengan syarat tetap melanjutkan pengobatan medis dan perawatan luka sesuai standar kesehatan. Perawat juga memberikan edukasi dengan bahasa sederhana mengenai tanda bahaya infeksi dan pentingnya kontrol rutin ke fasilitas kesehatan.

c. *Culture Care Repatterning/Restructuring* (Restrukturisasi budaya)

Perawat membantu keluarga mengubah pola pikir tentang penyakit yang sebelumnya hanya dianggap sebagai “masuk angin” atau hal tradisional menjadi pemahaman medis bahwa luka dapat menyebabkan infeksi serius. Perawat memberikan edukasi mengenai perawatan luka yang benar, pentingnya kebersihan, serta penggunaan terapi kompres hangat sesuai anjuran medis, sekaligus meluruskan kepercayaan yang salah tanpa menyinggung budaya keluarga.

3. Evaluasi

Setelah intervensi, diharapkan keluarga mulai memahami pentingnya pengobatan medis, mampu mengombinasikan budaya yang tidak merugikan dengan terapi kesehatan modern, serta meningkatkan kepatuhan dalam perawatan luka Ny. S untuk mencegah komplikasi.

G. Kelebihan dan Keterbatasan Teori

Menurut Alligood (2017), teori keperawatan transkultural memiliki beberapa keunggulan, yaitu membantu perawat dalam mengorganisasi dan memahami fenomena yang terjadi dalam praktik keperawatan, menganalisis kondisi pasien secara kritis guna menentukan keputusan klinis, merencanakan asuhan serta menentukan intervensi yang sesuai, serta memperkirakan hasil perawatan dan menilai efektivitas tindakan yang telah diberikan.

Dengan banyaknya keragaman suku dan ras di dunia, teori Leininger dinilai efektif dalam membantu pengambilan keputusan serta tindakan keperawatan, khususnya untuk mengidentifikasi bentuk perawatan yang bersifat universal di masyarakat luas. Teori ini menegaskan bahwa perawat tidak dapat memisahkan aspek sosial dari keyakinan maupun praktik budaya terkait kesehatan, penyakit, dan perawatan, karena semuanya saling berkaitan erat.

Selain itu, teori ini juga menyoroti bahwa faktor budaya dan struktur sosial—seperti teknologi, agama, keluarga dan sistem kekerabatan, politik, nilai dan praktik budaya, ekonomi, kondisi lingkungan fisik, serta faktor biologis—memiliki pengaruh besar terhadap pola perawatan serta tingkat kesehatan dan kesejahteraan individu (Khoiriyah, 2024).

Proses keperawatan transkultural dapat diterapkan pada pasien di berbagai tatanan pelayanan kesehatan. Penerapan ini mencakup lingkungan rumah sakit, seperti keperawatan medikal bedah, keperawatan anak, keperawatan maternitas, dan keperawatan jiwa, serta juga pada tatanan komunitas melalui keperawatan komunitas. Dengan demikian, pendekatan transkultural memungkinkan perawat memberikan asuhan yang sesuai dengan latar belakang budaya pasien di setiap bidang pelayanan keperawatan.

Keterbatasan lain dari teori ini adalah belum mampu sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas dalam pengaturan praktik keperawatan. Selain itu, perawat dihadapkan pada jumlah data atau informasi yang sangat besar dan terus berkembang, sehingga mereka dituntut untuk menganalisis berbagai informasi pasien secara menyeluruh dan menentukan tindakan yang paling tepat.

Selain itu, penerapan proses asuhan keperawatan transkultural memerlukan tenaga kesehatan, khususnya perawat profesional yang kompeten. Sumber daya manusia (SDM) keperawatan yang dibutuhkan harus mampu bersaing di era globalisasi, yaitu perawat yang memiliki kualifikasi Registered Nurse (RN), yakni lulusan program profesi ners dari jenjang sarjana keperawatan (Pratiwi, 2010).

H. Penutup

Keperawatan transkultural yang diperkenalkan oleh Madeleine M. Leininger memberikan landasan penting bagi perawat dalam memahami bahwa setiap individu memiliki latar belakang budaya yang memengaruhi cara pandang terhadap kesehatan, penyakit, serta proses perawatan. Oleh karena itu, penerapan asuhan keperawatan tidak dapat dilepaskan dari pemahaman budaya agar pelayanan yang diberikan menjadi lebih tepat, efektif, dan bermakna bagi klien.

Buku ini telah membahas konsep dasar budaya dalam keperawatan transkultural, peran perawat, model teori *Sunrise*, serta tiga prinsip utama dalam asuhan keperawatan transkultural, yaitu *culture care preservation/maintenance*, *culture care accommodation/negotiation*, dan *culture care repatterning/restructuring*. Seluruh pembahasan tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas praktik keperawatan yang sensitif budaya.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan pengembangan di masa yang akan datang.

Referensi

- Alligood, M. R. (2017). *Pakar Teori Keperawatan* (S. Tharmapalan, Ed.; 8th ed.). Elsevier Inc.
- Asmadi. (2008). *Konsep Dasar Keperawatan* (E. A. Mardella, Ed.). EGC.
- Fraktur, D., Setyawati, A., Nursanti, I., & Jakarta, M. (2024). *Nusantara Hasana Journal*. 3(8), 178–191.
- Khoiriyah, & N. I. (2024). Analisa Teori Transcultural Nursing Madeleine Leininger. *Nusantara Hasana Journal*, 3(8), 192–202. <https://www.nusantarahasanajournal.com/index.php/nhj/article/view/1072/878>
- Pratiwi, A. (2010). *Buku Ajar Keperawatan Transkultural* (1st ed.). Penerbit Gosyen Publishing.

BAB 2

KEANEKARAGAMAN BUDAYA DAN SISTEM KEPERCAYAAN DI INDONESIA

A. Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keanekaragaman budaya yang sangat kaya. Hal ini tidak terlepas dari kondisi geografisnya sebagai negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau, yang dihuni oleh ratusan suku bangsa dengan bahasa, adat istiadat dan tradisi yang berbeda-beda. Data terakhir dari Badan Informasi Geospasial (BIG) jumlah pulau di Indonesia tercatat sebanyak 17.380 pulau, dengan 1.340 suku bangsa dan 718 bahasa daerah (Kemendikbud). Keanekaragaman ini tercermin dalam beragamnya tradisi, seni, upacara, serta pola hidup masyarakat yang ada di seluruh pelosok negeri. Setiap daerah di Indonesia memiliki karakteristik budaya yang unik, yang saling berinteraksi dan menciptakan mozaik budaya yang luar biasa.

Indonesia juga memiliki sistem kepercayaan yang sangat beragam, yang berkembang sejak zaman kuno hingga masa kini. Agama-agama besar yang diakui di Indonesia: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu hidup berdampingan dengan berbagai kepercayaan lokal yang masih dilestarikan hingga sekarang. Masyarakat Indonesia tidak hanya menghayati agama mereka secara formal, tetapi juga menggabungkan unsur-unsur kepercayaan tradisional yang telah lama ada. Kepercayaan-kepercayaan tersebut seperti animisme, dinamisme dan sistem kepercayaan lain yang bersifat lokal, tetap menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat di beberapa daerah.

Perpaduan antara keanekaragaman budaya dan sistem kepercayaan yang ada di Indonesia menciptakan sebuah keharmonisan yang mencerminkan toleransi dan saling menghormati antar kelompok. Meskipun ada tantangan dalam menjaga kerukunan di tengah perbedaan, masyarakat Indonesia telah menunjukkan kemampuan untuk merayakan keberagaman ini sebagai kekuatan. Keanekaragaman ini bukan hanya sebagai sebuah warisan budaya, tetapi juga menjadi fondasi yang memungkinkan Indonesia untuk berkembang sebagai negara pluralistik yang penuh dengan potensi.

Dalam perspektif kesehatan, keanekaragaman budaya dan sistem kepercayaan di Indonesia memiliki kaitan yang erat dengan praktik dan pemahaman tentang kesehatan masyarakat. Nilai-nilai budaya dan keyakinan

tertentu sering memengaruhi cara individu memandang penyakit, penyebabnya serta metode pengobatan yang dipilih, baik melalui layanan medis modern maupun pengobatan tradisional seperti jamu atau praktek penyembuhan berbasis spiritual. Di beberapa daerah kepercayaan local masih menjadi rujukan utama dalam menjaga keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan lingkungan, sehingga pendekatan kesehatan tidak hanya bersifat fisik tetapi juga holistic. Oleh karena itu pemahaman terhadap latar belakang budaya dan sistem kepercayaan sangat penting dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan, agar lebih efektif, diterima oleh masyarakat, dan mampu menjangkau berbagai lapisan sosial secara menyeluruh.

B. Definisi Budaya

Budaya atau Kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta "*buddhayah*", yang merupakan bentuk jamak dari kata '*buddhi*' yang diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan akal budi manusia. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut sebagai "*culture*", yang berasal dari bahasa Latin "*colere*" yang berarti mengolah atau mengerjakan. Kosa kata "*culture*" ini banyak diasimilasikan ke dalam bahasa Indonesia sebagai "kultur".

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pikiran; akal budi; adat istiadat. Secara lebih rinci, KBBI merumuskan budaya sebagai sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar diubah, serta mencakup hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan yang sudah berkembang atau beradaptasi.

Budaya dapat dipahami sebagai keseluruhan kompleks kehidupan manusia yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, dan adat istiadat yang diperoleh sebagai anggota masyarakat. Menurut Koentjaraningrat (1980), budaya merupakan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang diwariskan melalui proses belajar dari generasi ke generasi. Sementara itu menurut Ralph Linton (1945) menekankan bahwa budaya adalah pengetahuan, sikap dan pola perilaku yang hidup dalam pemikiran serta kebiasaan sehari-hari masyarakat. Clifford Geertz (1973) menambahkan dimensi makna, bahwa budaya merupakan sistem symbol-simbol yang menjadi "kacamata" bagi manusia untuk memberi arah dan memahami realitas. Karlina Supelli (2005), menegaskan bahwa budaya bukanlah warisan yang statis, melainkan proses terus menerus di mana manusia memberi makna pada dunia. Dengan demikian, budaya mencakup aspek material dan immaterial sebagai hasil karya, rasa dan cipta masyarakat yang berfungsi sebagai pedoman hidup sekaligus identitas kolektif.

C. Wujud Kebudayaan

Kebudayaan sebagai sistem yang kompleks memiliki tiga wujud yang saling berkaitan. Koentjaraningrat (2015) menjelaskan bahwa wujud pertama adalah gagasan yang bersifat abstrak dan berada dalam alam pikiran warga masyarakat, meliputi nilai-nilai, norma, dan aturan yang mengatur perilaku. Contoh wujud budaya gagasan adalah filosofi *Rambu Solo'*, yang memandang kematian sebagai perjalanan menuju kehidupan abadi, sehingga upacara pemakaman diadakan secara besar-besaran sebagai bentuk penghargaan. Konsep Tri Hita Karana, gagasan filosofis untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama dan manusia dengan alam. Nilai-nilai unggah-ungguh (tata karma) pada masyarakat Jawa, mengatur sopan-santun dalam bicara dan berperilaku berdasarkan tingkatan sosial dan umur.

Wujud budaya gagasan ini dalam perspektif kesehatan akan membentuk pandangan masyarakat tentang kesehatan, penyakit, serta cara pencegahannya. Budaya ini mempengaruhi persepsi terhadap gejala sakit, metode pengobatan dan perilaku pencarian layanan kesehatan. Wujud budaya ini meliputi: 1) konsep sehat-sakit yang holistik dimana budaya sering mendefinisikan kesehatan sebagai keseimbangan antara fisik, spiritual, mental, dan emosional, bukan sekedar bebas dari penyakit; 2) Kepercayaan dan Norma Kesehatan, nilai-nilai budaya menentukan pandangan masyarakat tentang penyebab penyakit, misal penyakit kiriman, santet, atau penyakit medis; 3) Struktur Normatif, norma adat yang mengatur perilaku sehari-hari, misal pantangan makanan bagi ibu hamil atau cara perawatan ibu nifas; dan 4) pengetahuan local (local wisdom), penggunaan obat tradisional atau jamu yang diwariskan secara turun temurun.

Wujud kedua budaya adalah aktivitas atau tindakan yang berpola dari manusia dalam masyarakat, seperti upacara adat, gotong royong, dan pola interaksi sosial sehari-hari. Sistem sosial ini terdiri atas aktifitas-aktifitas manusia yang saling berinteraksi, bergaul dan berhubungan satu sama lain, dari waktu ke waktu yang membentuk pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata perilaku (Sunarno, 2012). Tradisi Tabuik di masyarakat Pariaman dilakukan untuk memperingati hari Asyura, menampilkan pembuatan dan arak-arakan tabuik (keranda). Di Jawa ada tradisi Kesada, ritual suku Tengger memberikan sesajen di kawah gunung Bromo. Upacara Ngaben di Bali, untuk mengkremsi jenazah umat Hindu yang bertujuan untuk memurnikan roh, dilakukan dengan perayaan yang meriah. Sementara itu di Kalimantan ada ritual Tiwah, upacara adat suku Dayak untuk mengantarkan roh leluhur menuju Lewun Tatau (langit).

Dalam perspektif kesehatan wujud budaya yang kedua ini adalah serangkaian tindakan, kebiasaan, dan pola perilaku sosial yang dilakukan secara rutin oleh individu atau komunitas yang berdampak langsung pada status kesehatan fisik, mental maupun sosial. Aktivitas ini dibentuk oleh budaya dan mencakup pola makan, perilaku pencegahan penyakit, penggunaan layanan kesehatan, serta interaksi sosial, yang bisa bersifat mendukung atau justru menghambat kesehatan (Salsabila, 2023). Contoh dari wujud budaya aktivitas ini dalam perspektif kesehatan adalah:

1. Aktivitas Budaya Pendukung Kesehatan (Positif)

Banyak aktivitas tradisional yang secara tidak langsung membentuk gaya hidup sehat dan diwariskan turun-temurun. Misalnya: 1) Pola Konsumsi Tradisional: Budaya memakan makanan organik, seperti lalapan, jamu, atau makanan fermentasi tradisional yang tinggi gizi dan probiotik. 2) Aktivitas Fisik Berbasis Komunitas: Gotong royong membersihkan lingkungan atau tradisi berjalan kaki yang masih kuat di perdesaan. 3) Pemanfaatan Pengobatan Tradisional: Penggunaan ramuan herbal (jamu) yang diolah secara turun-temurun untuk penyembuhan penyakit ringan. 4)

2. Aktivitas Budaya Penghambat Kesehatan (Negatif)

Beberapa aktivitas atau kepercayaan budaya dapat bertentangan dengan prinsip kesehatan modern: 1) Tabu Makanan (Food Taboos): Larangan mengonsumsi protein tertentu (seperti ikan atau telur) bagi ibu hamil atau anak-anak di daerah tertentu, yang berisiko menyebabkan malnutrisi. 2) Pengobatan alternatif yang terlambat: Lebih memilih dukun atau pengobatan tradisional daripada fasilitas kesehatan modern, bahkan dalam kasus gawat darurat, yang sering menyebabkan keterlambatan penanganan. Misalnya membawa pasien hernia ke tukang urut. 3) Norma sosial berisiko: tradisi merokok bersama atau konsumsi alkohol dalam upacara adat tertentu.

3. Dinamika Budaya Aktivitas dalam Pelayanan Kesehatan

Dalam konteks layanan kesehatan, budaya aktivitas memengaruhi interaksi antara pasien dan tenaga medis. 1) Perilaku mencari pengobatan (Health Seeking Behavior): Budaya mempengaruhi kapan dan bagaimana seseorang mencari bantuan medis. 2) Kepercayaan pada tenaga kesehatan: tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tenaga kesehatan sering dipengaruhi oleh sejauh mana tenaga kesehatan menghormati budaya lokal. 3) Adaptasi Budaya dalam kesehatan: keberhasilan promosi kesehatan seringkali bergantung pada integrasi pesan kesehatan dengan budaya setempat (Dumbaugh (2021)

Perspektif kesehatan memandang wujud budaya aktivitas bukan sekadar kebiasaan, melainkan perilaku sosial yang dinamis. Pemahaman terhadap budaya

aktivitas masyarakat setempat sangat penting bagi petugas kesehatan untuk memberikan intervensi yang tepat, menghormati nilai setempat, dan mempromosikan perilaku hidup sehat.

Wujud ketiga adalah artefak atau benda-benda hasil karya manusia yang bersifat konkret, meliputi teknologi, arsitektur, pakaian, dan kesenian (Koentjaraningrat, 2015). Contoh wujud budaya ini di Jawa adalah candi Borobudur, candi Prambanan, Rumah Joglo, baju Kebaya dan beskap dan alat musik Gamelan. Di Sumatera, ada situs gua Harimau, rumah Gadang, baju Batabue dan alat musik Gordang Sambilan.

Wujud ketiga budaya ini dalam perspektif kesehatan merujuk pada benda-benda fisik, material, atau karya nyata hasil perbuatan manusia yang berkaitan langsung dengan upaya menjaga kesehatan, penyembuhan penyakit, maupun memengaruhi status kesehatan individu atau komunitas. Artefak ini berbentuk fisik dan dapat dilihat, diraba, dan didokumentasikan.

Berikut adalah contoh dan peran wujud budaya artefak dalam kesehatan:

1. Artefak Kesehatan Tradisional

- a. Alat Penyembuhan Tradisional: Alat-alat yang digunakan oleh dukun, tabib, atau penyembuh tradisional, seperti keris, mangkuk pengobatan, atau alat pijat khusus.
- b. Ramuan dan Wadah Jamu: Ramuan herbal tradisional, tumbukan obat, serta wadah tempat meracik atau menyimpan bahan-bahan obat alami.
- c. Jimat atau Benda Magis: Benda-benda yang diyakini secara budaya memiliki kekuatan supranatural untuk melindungi diri dari penyakit atau menangkal energi negatif.

2. Artefak Kesehatan Modern dan Struktural

- a. Peralatan Medis Modern: Alat medis di rumah sakit, seperti stetoskop, jarum suntik, mesin X-ray, hingga alat pacu jantung.
- b. Infrastruktur Kesehatan: Bangunan rumah sakit, klinik, puskesmas, dan puskesmas pembantu.
- c. Alat Pelindung Diri (APD): Masker, pakaian pelindung, sarung tangan, dan alat keselamatan kerja lainnya yang digunakan untuk mencegah penularan penyakit.

3. Artefak Budaya Gaya Hidup Kesehatan

- a. Peralatan Makan dan Memasak: Alat masak tradisional (misalnya kukusan bambu) atau modern yang memengaruhi cara pengolahan makanan.
- b. Pakaian atau Seragam: Pakaian adat yang diyakini memberikan perlindungan fisik atau seragam tenaga kesehatan yang menjadi simbol profesionalisme.

- c. Sarana Sanitasi: Toilet, tempat penampungan air, dan tempat sampah yang mencerminkan budaya kebersihan masyarakat.
- d. Dalam perspektif kesehatan, artefak tidak hanya sekadar benda mati, tetapi merupakan perwujudan dari pengetahuan, kepercayaan, dan aktivitas manusia dalam merespons kesehatan. Artefak ini sering kali berinteraksi dengan perilaku kesehatan masyarakat dan menjadi bagian dari budaya kesehatan secara keseluruhan

Dalam perspektif kesehatan, artefak tidak hanya sekadar benda mati, tetapi merupakan perwujudan dari pengetahuan, kepercayaan, dan aktivitas manusia dalam merespons kesehatan. Artefak ini sering kali berinteraksi dengan perilaku kesehatan masyarakat dan menjadi bagian dari budaya kesehatan secara keseluruhan.

Pada akhirnya dapat kita simpulkan bahwa ketiga wujud budaya tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena gagasan akan melahirkan aktivitas, dan aktivitas menghasilkan artefak yang pada akhirnya memperkuat budaya yang hidup di masyarakat.

D. Unsur Kebudayaan

Menurut Koentjaraningrat (1980), unsur budaya adalah tujuh komponen universal yang ditemukan di semua kebudayaan di seluruh dunia, mencakup: bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, peralatan hidup/teknologi, mata pencaharian, religi, dan kesenian. Unsur-unsur ini mencakup wujud ideal (ide), kelakuan berpola (aktivitas), dan artefak (benda fisik).

Berikut adalah penjelasan detail 7 unsur kebudayaan universal menurut Koentjaraningrat: 1) Bahasa: Alat komunikasi utama, baik lisan maupun tulisan, yang digunakan manusia dalam berinteraksi. 2) Sistem Pengetahuan: Pengetahuan masyarakat tentang alam sekitar, manusia, binatang, tumbuhan, dan waktu yang membantu mereka bertahan hidup. 3) Sistem Organisasi Sosial: Kelompok-kelompok yang diciptakan untuk mengatur kehidupan bersama, seperti sistem kekerabatan, lembaga adat, dan kemasyarakatan. 4) Sistem Peralatan Hidup dan Teknologi: Alat-alat fisik yang digunakan manusia untuk memudahkan aktivitas, seperti pakaian, tempat tinggal, alat transportasi, dan senjata. 5) Sistem Mata Pencaharian Hidup: Usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, contohnya pertanian, berburu, peternakan, atau berdagang. 6) Sistem Religi (Agama): Kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan supranatural, Tuhan, atau hal-hal yang sakral, termasuk upacara adat dan keagamaan. 7) Kesenian: Hasil

keaktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan psikis akan keindahan, contohnya seni rupa, seni suara, tari, dan sastra.

E. Kebudayaan dan Kesehatan

Berbagai penelitian terbaru menunjukkan bahwa budaya dan sistem kepercayaan memiliki pengaruh kuat terhadap perilaku kesehatan masyarakat Indonesia. Anggriani (2021) dalam kajiannya menemukan bahwa budaya masih menjadi faktor determinan dalam pola makan masyarakat. Mitos dan pantangan makanan yang diwariskan secara turun-temurun, seperti larangan ibu hamil mengonsumsi nanas atau ikan tertentu, menyebabkan sebagian kelompok berisiko mengalami defisiensi gizi meskipun secara medis makanan tersebut aman dan bergizi. Hal ini membuktikan bahwa sistem nilai budaya dapat mengalahkan rasionalitas ilmiah dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan. Penelitian Nurdin (2021) juga menegaskan bahwa antropologi budaya sangat berguna untuk memahami perbedaan perilaku kesehatan antar suku bangsa. Dalam kehidupan sehari-hari, budaya memengaruhi cara masyarakat mengatasi masalah kesehatan, mulai dari pemilihan penolong persalinan antara dukun beranak dengan bidan, hingga penggunaan obat tradisional versus obat medis. Gizi dan kesehatan tidak dapat dilepaskan dari konteks status sosial, ekonomi, geografi, dan psikologi perkembangan yang semuanya dibentuk oleh budaya setempat. Dalam konteks sistem kepercayaan, studi oleh Milla (2021) yang dipublikasikan di Jurnal Psikologi Sosial UI menjelaskan bahwa sistem kepercayaan merupakan sekumpulan nilai yang berinteraksi memengaruhi bagaimana manusia menjalani hidup, termasuk cara memperlakukan tubuh dan mengatasi sakit. Sistem kepercayaan dapat berbasis agama, politik, ilmiah, atau pribadi, dan secara langsung membentuk persepsi terhadap sehat-sakit serta kepatuhan pada pengobatan. Temuan ini diperkuat oleh data nasional dari Survei Kesehatan Indonesia (2023) yang mengintegrasikan Riskesdas dan SSGI, bahwa capaian pembangunan kesehatan lima tahun terakhir sangat dipengaruhi oleh faktor sosial-budaya di tingkat kabupaten/kota, sehingga intervensi kesehatan perlu dirancang berbasis bukti dan peka budaya. Selain itu, aspek gender dan budaya juga berperan dalam perawatan kesehatan. Studi fenomenologi terhadap caregiver menantu perempuan bagi pengidap Demensia Parkinson dalam konteks budaya Tionghoa menunjukkan bahwa nilai bakti dan peran gender tradisional memengaruhi beban psikologis serta pola pengasuhan pasien di rumah. Hal ini mengindikasikan bahwa promosi kesehatan tidak cukup hanya menyampaikan informasi medis, tetapi harus mempertimbangkan sistem kepercayaan dan struktur nilai yang hidup di masyarakat.

F. Sistem Kepercayaan di Indonesia

Istilah kepercayaan menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata dasar 'percaya' yang berarti mengakui atau yakin bahwa sesuatu benar dan nyata. Kepercayaan juga diartikan sebagai anggapan, keyakinan, atau harapan akan kejujuran dan kebaikan orang lain, serta seringkali dikaitkan dengan iman dan pendirian. Jika dikaitkan dengan kepercayaan dalam konteks spiritual maka kepercayaan di sini dimaksudkan sebagai anggapan terhadap sesuatu yang diyakini, dan dimaknai dalam kehidupan seperti agama, kepercayaan tradisional atau ajaran.

Berdasarkan konteks kebijakan di Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007, maka 'kepercayaan' ini dimaknai sebagai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang didefinisikan sebagai pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia. Kearifan lokal disini adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari (UU 11 Tahun 2020 dan UU 32 Tahun 2009). Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2007 juga disebutkan bahwa 'Penghayat Kepercayaan', adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Poin-poin penting dalam pengertian kepercayaan ini meliputi: 1) Bukan Agama resmi: kepercayaan dalam konteks ini sering merujuk pada aliran kepercayaan atau kebatinan/kerohanian, yang berbeda dengan enam agama resmi di Indonesia, namun diakui negara. 2) Berbasis kearifan lokal: ajarannya berakar pada budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. 3) Aspek Batiniah: sikap batin seseorang atas kebenaran ajaran spiritual yang dianutnya. 4) Perilaku: kepercayaan ini dimaknai dalam bentuk perilaku ketaqwaan, peribadatan dan perilaku berbudi luhur (

G. Pokok-pokok Ajaran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Ajaran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa meliputi: 1) Kembali ke sumber hidup, menekankan pada kesadaran bahwa sejatinya keberadaan manusia berasal dari sumber hidup (Tuhan Yang Maha Esa). Kehidupan yang dijalani adalah proses pengejawantahan ketuhanan pada diri, sesama hidup, dan semesta, untuk mencapai tujuan akhir proses kehidupan yang dijalani yaitu kembali kepada Sumber Hidup. 2) Menyatu dengan sumber hidup, bahwa manusia mempunyai kewajiban untuk menjalani kehidupan sesuai dengan ketetapan dan kehendak dari Tuhan

Yang Maha Esa dengan cara senantiasa menjaga kebersihan dan kesucian hati. 3) Bermanfaat dalam Hidup, menegaskan kewajiban bagi penghayat kepercayaan untuk senantiasa mengupayakan perilaku hidup yang membawa keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semesta.

Pengamalan pokok-pokok ajaran tersebut hendaknya ditunjukkan dalam perilaku dan kepribadian para penghayat pada kehidupan sehari-hari (budi Luhur). Secara sosial hendaknya selalu menjaga kerukunan dan keharmonisan hidup, dengan menghindari perselisihan, permusuhan dan konflik dengan siapa pun. Dalam ruang ekologis, diwujudkan dalam tindakan menghargai dan menghormati hak hidup setiap makhluk (Mulyady, A. dkk. (2021).

H. Unsur-Unsur Kepercayaan

Unsur-unsur dasar kepercayaan adalah: 1) Tuhan dan kekuatan gaib (supranatural):kepercayaan pada entitas tertinggi atau roh-roh supranatural, termasuk arwah leluhur, roh penjaga tempat tertentu (pohon, sungai, danau, gunung), dan dewa-dewa local. 2) manusia (Umat/komunitas): manusia memandang dirinya sebagai bagian integral dari alam dan komunitas adat, bukan penguasa semesta. Terdapat kesadaran mendalam akan keterbatasan diri sehingga membutuhkan bantuan kekuatan gaib. 3) Semesta (Kosmologi): penjelasan mengenai asal-usul dunia, tempat dan benda-benda alam yang dianggap sacral atau memiliki roh atau jiwa (animism/dinamisme). 4) Ritual dan pemujaan: praktek ibadah atau serangkaian upacara (tari-tarian, sesaji, ritual adat) untuk berkomunikasi, memohon perlindungan, atau berterima kasih kepada kekuatan supranatural. 5) Aturan adat dan symbol: kumpulan pedoman hidup, tabu (pantangan) dan hokum adat yang mengatur hubungan sosial dan menjaga keseimbangan alam.

I. Bentuk-Bentuk Aliran Kepercayaan

Dalam penggolongannya maka aliran kepercayaan dibedakan menjadi:

1. Animisme

Berasal dari kata "anima" yang berarti nyawa. Kepercayaan ini meyakini bahwa segala benda, baik yang bernyawa maupun tidak, memiliki roh atau jiwa. Kepercayaan ini berfokus untuk menghormati roh nenek moyang atau makhluk halus yang mendiami benda alam seperti gunung, pohon, atau batu.

Animisme diartikan sebagai suatu rangkaian upacara-upacara, tanggapan-tanggapan dan sebagainya yang melukiskan adanya makhluk-makhluk halus

sakti yang mempunyai kepribadian. Contoh: Pemujaan roh leluhur, kepercayaan pada tempat keramat.

2. Dinamisme

Berasal dari bahasa Yunani “dynamos” yang artinya kekuatan. Dinamisme adalah aliran kepercayaan yang mempercayai adanya kekuatan dan kuasa dari benda-benda tertentu. Benda-benda tersebut diyakini mempunyai kekuatan ghaib yang misterius dan sakti. Benda dianggap memiliki daya magis yang dapat memengaruhi manusia, baik positif maupun negative. Contohnya adalah pemujaan terhadap keris, batu akik, jimat, patung yang dianggap keramat.

3. Politeisme

Adalah kepercayaan kepada berbagai dewa personal, yang masing-masing memegang kekuasaan atas bidang kehidupan yang berlainan. Ajaran kepercayaan ini meyakini dan menyembah banyak dewa/dewi. Dewa-dewi ini bertanggung jawab atas aspek-aspek tertentu di alam semesta, misalnya dewa laut, dewa petir, Dewi Sri (padi), dll.

4. Henoteisme

Kepercayaan yang tidak menyangkal adanya Tuhan banyak, tetapi hanya mengakui Tuhan yang satu sebagai Tuhan yang disembah

5. Monoteisme

Tidak lagi mengakui Tuhan yang banyak, pengakuan yang hakiki bahwa Tuhan itu satu.

6. Totemisme

Merupakan fenomena yang menunjuk adanya hubungan organisasional khusus antara suatu suku bangsa atau klan suatu spesies tertentu dalam wilayah binatang atau tumbuhan. Penganut ini menggunakan totem tertentu sebagai symbol kelompok sosial dan menganggap sebagai pelindung.

7. Pemujaan terhadap leluhur

Pemujaan terhadap leluhur adalah suatu kumpulan sikap, kepercayaan dan praktek berhubungan dengan pendewaan terhadap orang-orang yang sudah meninggal dalam bentuk komunitas (Jamaludin, J. 2025; Butar-butar 2022; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020).

J. Aliran Kepercayaan Terbesar di Indonesia

Lima (5) Aliran Kepercayaan Terbesar di Indonesia berdasarkan data organisasi penghayat & sebaran wilayah. Data jumlah penganut resmi dari MLKI 2023 belum dipublikasi terbuka, data berikut dikombinasi dari data Ensiklopedia Kemdikbud 2020 dan Ditjen Kebudayaan

Aliran Kepercayaan	Wilayah Sebaran Utama	Ciri Pokok Pengajaran	Estimasi Penganut	Sumber
Sunda Wiwitan	Banten, Jawa Barat	Menyembah Sang Hyang Kersa, jaga keseimbangan alam, pantangan pikukuh karuhun	>30.000 jiwa	Kemdikbud, 2020
Parmalim, Toba	Sumatera Utara, Toba	Monoteisme Mulajadi Nabolon, kitab Pustaha, ibadah Sabtu di Bale Pasogit	>25.000 jiwa	Butar-Butar, 2022
Kaharingan	Kalimantan Tengah	Kepercayaan Dayak Ngaju, Tuhan Ranying Hatalla Langit, kitab Panaturan	>20.000 jiwa	Kemdikbud, 2020
Tolotang	Sulawesi Selatan, Sidrap	Kepercayaan masyarakat Towani-Tolotang, dewa Dewata Seuwae	>15.000 jiwa	Kemdikbud, 2020
Marapu	Sumba, NTT	Pemujaan leluhur di uma bokulu, siklus Rambu Tuka & Rambu Solo	>12.000 jiwa	Yamashita, 2021

K. Kepercayaan dan Kesehatan

Spiritualitas dan kepercayaan memiliki hubungan positif yang kuat dengan kesehatan fisik dan mental, bertindak sebagai mekanisme koping (coping mechanism) untuk mengurangi stres, kecemasan, dan depresi. Praktik seperti doa dan meditasi meningkatkan ketenangan batin, meningkatkan optimisme, serta mempercepat pemulihan pasien, termasuk pasien kanker (Kemenkes, 2011).

Berikut adalah rincian hubungan spiritualitas dan kepercayaan dengan kesehatan:

1. Kesehatan Mental dan Emosional: Kepercayaan spiritual membantu individu menemukan makna hidup, meningkatkan penerimaan diri, serta mengurangi emosi negatif seperti rasa takut dan putus asa. Hal ini berkontribusi pada penurunan risiko depresi dan kecemasan.
2. Kesehatan Fisik: Praktik spiritual (meditasi/doa) terbukti menurunkan stres, yang berdampak pada penurunan tekanan darah dan peningkatan sistem imun.
3. Motivasi Kesembuhan: Pasien dengan tingkat spiritualitas tinggi cenderung memiliki motivasi yang lebih besar untuk sembuh dan lebih baik dalam menghadapi penyakit kronis.
4. Perilaku Sehat: Komunitas berbasis kepercayaan sering mendorong gaya hidup sehat (menghindari alkohol, rokok) yang mendukung kesehatan fisik secara keseluruhan.
5. Dukungan Sosial: Terlibat dalam komunitas keagamaan memberikan dukungan sosial yang kuat, mengurangi rasa kesepian dan isolasi.
6. Secara keseluruhan, spiritualitas berfungsi sebagai modal internal untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan secara holistik

Tinjauan terbaru telah memberikan bukti lebih lanjut tentang adanya hubungan antara keterlibatan keagamaan/religi dengan kesehatan. Variabel yang terkait dengan agama telah terbukti memiliki efek perlindungan terhadap berbagai hasil kesehatan mental, termasuk kesejahteraan, perilaku bunuh diri, dan penyalahgunaan obat/zat. Sebuah tinjauan kritis terhadap 17 studi menemukan bahwa kehadiran agama/kepercayaan cenderung dikaitkan dengan berkurangnya kecemasan. Sebuah meta analisis dari 147 studi menyimpulkan bahwa terdapat hubungan terbalik yang kuat namun moderat antara religiusitas dengan gejala depresi. Namun data lain mengungkapkan bahwa bukti untuk hubungan antara religiusitas dengan skizofrenia masih beragam. Studi di Australia juga mencatat bahwa agama mungkin memiliki peran terapeutik potensial dalam pengobatan depresi. Serangkaian uji coba terkontrol secara acak menemukan bahwa terapi yang diperkaya dengan spiritualitas lebih berhasil daripada terapi konvensional non-spiritual dalam mengurangi gejala depresi pasien, meningkatkan pengobatan dan

kepatuhan, serta meminimalkan resiko kambuh. Studi tentang perilaku remaja telah menemukan bahwa tingkat keterlibatan keagamaan yang lebih tinggi berbanding terbalik dengan alkohol dan penggunaan narkoba, merokok, aktifitas seksual, gejala depresi dan resiko bunuh diri. Studi terhadap siswa sekolah di Australia juga menunjukkan bahwa religiusitas berbanding terbalik dengan perilaku beresiko (William, D., R., and Sternthal, M., J., 2007).

Di Indonesia aliran kepercayaan seringkali menumbuhkan mitos-mitos yang mempengaruhi perilaku dan pemahaman kesehatan. Kepercayaan atau mitos ini memiliki pengaruh yang signifikan dan mendalam terhadap perilaku kesehatan masyarakat di Indonesia. Sebagai bagian dari budaya dan tradisi turun-temurun, mitos sering kali memengaruhi keputusan medis, pola makan, serta perawatan ibu dan anak.

Pengaruh tersebut terbagi menjadi dua sisi:

1. Dampak Negatif (Menghambat Kesehatan)

Mitos sering kali menyebabkan penundaan pengobatan medis, malnutrisi, atau perilaku yang berisiko. Misalnya: 1) pantangan makan ibu hamil: banyak masyarakat, terutama di daerah, masih percaya bahwa ibu hamil tidak boleh makan ikan atau buah tertentu, yang justru mengurangi asupan gizi penting. 2) Kelainan Kongenital: Mitos tentang kehamilan sering dikaitkan dengan kelainan struktural atau fungsional pada janin, yang membuat ibu merasa tenang secara psikologis tetapi sebenarnya menunda penanganan medis yang tepat. 3) Perawatan Bayi: Beberapa kepercayaan, seperti menolak memberikan ASI pertama (kolostrum) karena dianggap "kotor" dan menggantinya dengan madu atau makanan lain, dapat merugikan kesehatan bayi. 4) Masuk Angin/Panas Dalam: Mitos seperti "masuk angin" atau "panas dalam" yang dipercaya masyarakat Indonesia sering kali membuat penyakit medis sesungguhnya tidak diobati dengan benar. 4) Larangan makan makanan tertentu ketika sakit, misalnya tidak boleh makan ayam ketika habis operasi, tidak boleh makan sayur bayam ketika batuk.

2. Dampak Positif (Sebagai Kearifan Lokal)

Di sisi lain, beberapa mitos berfungsi sebagai pengontrol sosial atau "pamali" yang secara tidak langsung melindungi kesehatan, meskipun alasan ilmiahnya tidak selalu terpenuhi. Contohnya larangan-larangan tertentu (pamali) yang diwariskan nenek moyang sering kali bertujuan menjaga keselamatan, seperti larangan keluar malam bagi ibu hamil, ternyata memang bermanfaat untuk menghindari kelelahan

L. Penutup

Keanekaragaman budaya dan sistem kepercayaan adalah DNA bangsa Indonesia. Dari nilai gotong royong, kearifan Tri Hita Karana, hingga laku spiritual Sunda Wiwitan dan Parmalim, semuanya membentuk cara masyarakat Indonesia memaknai hidup, alam, dan kesehatan (Koentjaraningrat, 2015; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020). Berbagai penelitian membuktikan bahwa budaya bukan penghalang, melainkan determinan penting yang memengaruhi pola makan, kepatuhan pengobatan, dan kualitas hidup (Anggriani, 2021; Nurdin, 2021).

Menghadapi bonus demografi dan tantangan kesehatan global, pelestarian budaya harus berjalan seiring dengan transformasi kesehatan. Data SKI 2023 menegaskan bahwa keberhasilan program kesehatan ditentukan oleh sejauh mana intervensi peka terhadap konteks lokal (Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, 2023). Pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan melalui Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 menjadi fondasi hukum untuk mewujudkan keadilan budaya dalam pelayanan publik.

Ke depan, sinergi kearifan lokal dengan ilmu pengetahuan modern adalah kunci mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs poin 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera. Nilai kebersamaan dalam budaya dapat menjadi modal sosial untuk menurunkan stunting, meningkatkan cakupan imunisasi, dan memperkuat kesehatan mental masyarakat. Jika dikelola dengan bijak, keanekaragaman ini akan menjadi pilar utama menuju Indonesia Emas 2045: bangsa yang tidak hanya maju secara ekonomi dan teknologi, tetapi juga sehat, berbudaya, dan berkarakter. Karena sejatinya, Indonesia yang hebat adalah Indonesia yang mampu menjaga ragamnya, merawat tradisinya, dan membawa nilai luhur budaya sebagai kompas menuju masa depan.

Referensi

- Koentjaraningrat. (1980). Pengantar ilmu antropologi. Rineka Cipta.
- Anggriani, I. (2021). Pengaruh budaya terhadap pangan, sistem budaya terhadap makanan, masalah budaya dan makanan terhadap gizi serta solusi untuk mengatasi masalah budaya dan makanan terhadap gizi dan kesehatan. Academia.edu. <https://academia.edu>
- Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. (2023). Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023. Kementerian Kesehatan RI. <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016-sekarang). Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Butar-Butar, A. J. R. (2022). Agama asli nusantara: Sejarah, ajaran, dan dinamika Parmalim. Obor Indonesia.
- Dumbaugh M, Hanneke R, Kalaitzi V, Kim S, Swatscheno J, Valencia A, Peters K. (2021). Public Health and Global Societies: A survey course in Global Health. <https://pubh110.digital.uic.edu/>
- Geertz, C. (1973). The interpretation of cultures: Selected essays. Basic Books.
- Henninger, S., (2020) Perspectives: An Open Introduction to Cultural Anthropology, 2nd Edition. American Anthropological Association. <https://americananthro.pressbooks.pub/perspectivesculanth2/chapter/region/>
- Jamaludin, J. (2025). Ragam Keyakinan Dalam Kehidupan Manusia. Journal UIAD. <https://journal.uiad.ac.id/index.php/al/article/download/3575/1428>
- Kemenkes. (2011). Spiritualitas Bermanfaat Tingkatkan Kesehatan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. <https://kemkes.go.id/eng/%20spiritualitas-bermanfaat-tingkatkan-kesehatan#:~:text=Pengamatan%20ilmiah%20menunjukkan%2C%20perilaku%20spiritual,perubahan%20biologis%20dan%20kerja%20otak.>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). Ensiklopedia kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Jilid 1-3). Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat.
- Koentjaraningrat. (2015). Pengantar ilmu antropologi (Edisi revisi). Rineka Cipta.
- Linton, R. (1945). The cultural background of personality. Appleton-Century -Crofts.
- Luva, D.E., Kusumandari, R., Puspitasari. (2014). Sistem Kepercayaan (Belief System) Masyarakat Keturunan Suku Mandar DI Kelurahan Mandar, Kabupaten Banyuwangi: Studi Fenomenologis Pada Ritual Saulak (e-ISSN: 2502-3268), Vol 9 (2), 39-51.

<https://journal.uho.ac.id/index.php/JPeB/article/download/1053/455/3425>

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2016). Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. MKRI.
- Milla, M. N. (2021). Sistem kepercayaan. *Jurnal Psikologi Sosial*, 19(1), 1-2. Universitas Indonesia. <https://jps.ui.ac.id>
- Mulyady, A., Wijaya, A., Muslim, D.H., Jaya, I. P., Limbeng, J., Rahmiyati, L., Warman, M., Gunawan, P., F., Putri, R., A., Turido, S., F, Sumari. Effendi, W. (2021). Buku Saku Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat. Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. <https://repositori.kemendikdasmen.go.id/26007/1/Buku%20Saku.pdf>
- nstitut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie. (2024). Keunikan Budaya dan Tradisi di Indonesia. IBIKKG. <https://kwikkiangie.ac.id/2024/05/31/keunikan-budaya-dan-tradisi-di-indonesia/>
- Nurdin, A. (2021). Hubungan sosio antropologi budaya, gizi, dan kesehatan. <https://Academia.edu>
- Salsabila. (2023). Aspek Budaya dan Pembangunan Kesehatan. *Public Health Journal*. <https://teewanjournal.com/index.php/phj/index>
- Sulasman, H., & Gumilar, S. (2021). Teori-teori kebudayaan: Dari klasik hingga kontemporer. Pustaka Setia.
- Sunarno, I. (2012). Konsep Sehat Menurut Perspektif Budaya Jawa. Repositori Universitas Airlangga.
- Supelli, K. (2005). Filsafat dan budaya: Berpikir tentang makna. Dalam A. Budi Susanto (Ed.), *Identitas dan postkolonialitas di Indonesia* (hlm. 45-60). Kanisius.
- Tylor, E. B. (1871). *Primitive culture: Researches into the development of mythology, philosophy, religion, art, and custom* (Vol. 1). John Murray.
- Williams, D., R., and Sternthal, M., J., (2007). Spirituality, religion and health: evidence and research directions. *The Medical Journal of Australia*. Vol. 186. (10). <https://www.mja.com.au/journal/2007/186/10/spirituality-religion-and-health-evidence-and-research-directions>
- Yamashita, S. (2021). *Ritual, heritage and identity: The politics of culture and tourism in Toraja*. NUS Press.

BAB 3

PERSEPSI SAKIT DAN PERILAKU Mencari pengobatan

A. Pendahuluan

Persepsi (perception) dideskripsikan sebagai suatu proses dimana seseorang menginterpretasi dan mengorganisir sensasi dan peristiwa untuk menghasilkan suatu pengalaman hidup yang berarti. Interpretasi tersebut dipengaruhi oleh pengetahuan tertentu, keyakinan, dan harapan yang mencirikan pribadi seseorang. Persepsi juga mengarah pada bagaimana seseorang mengerti dan merasakan penyakit atau disabilitas, contohnya persepsi sakit. Penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan orang memiliki perbedaan tentang bagaimana merasakan status kesehatan mereka dan persepsi ini sering tidak bergantung pada kondisi yang sebenarnya. Sebagai contoh, banyak orang berbeda dalam hal merasakan berbagai kemungkinan untuk mempengaruhi atau mengontrol kesehatan mereka, baik ketika dalam kondisi akut atau kronik maupun ketika dalam kondisi yang penuh harapan. Persepsi seperti itu dapat menentukan perilaku individu dan respon mereka untuk mengelola ancaman kesehatan yang terkait dengan suatu penyakit atau gejala

Ketika pasien didiagnosis dengan suatu penyakit, mereka umumnya mengembangkan suatu keyakinan dengan pola yang terorganisir mengenai kondisi mereka. Keyakinan tersebut dikenal dengan persepsi sakit. Persepsi sakit ini merupakan kunci yang menentukan perilaku yang mengarah pada penanganan sakit. Persepsi sakit ini secara langsung mempengaruhi respon emosi individu terhadap sakit dan perilaku coping seperti kepatuhan pada pengobatan. Meskipun hal tersebut penting, persepsi pasien tentang sakit atau gejalanya jarang dicari oleh dokter saat melakukan history taking dan pasien mungkin tidak mengatakan keyakinan tentang sakitnya kepada dokter. Padahal besarnya kesadaran dari keyakinan pasien bisa meningkatkan manfaat konsultasi medis dan kesembuhan dari sakit, pasien dengan masalah Kesehatan baru dan menemukan bahwa pasien yang memiliki persepsi negatif mengenai kondisi sakit mereka (identitas penyakit yang kuat, timeline yang lama, dan konsekuensi yang dirasa berat) berhubungan dengan penggunaan perawatan kesehatan di masa yang akan datang terlepas dari perawatan kesehatan sebelumnya dan juga diagnosis keparahan dari masalah kesehatan mereka. Penelitian Marteau et al. (2006) juga membuktikan bahwa pasien yang datang untuk pemeriksaan kesehatan dan sudah mempunyai persepsi negatif terhadap kondisinya ternyata kurang tenang dengan tidak ditemukannya penyakit.

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas, menyangkut intern dan ekstern. Berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.

Persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata. Persepsi pasien tentang perilaku caring perawat adalah perawat memberi perhatian lebih pada pasien dan pasien dianggap keluarga. Perilaku caring perawat yang dirasakan oleh pasien adalah perawat aktif bertanya, berbicara lembut, memberi dukungan, responsif, terampil, menghargai, dan menjelaskan tindakan pada pasien

Persepsi sakit merupakan interpretasi individu terhadap kondisi kesehatan yang dialaminya. Persepsi ini tidak selalu sejalan dengan kondisi medis objektif, karena dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, psikologis, dan pengalaman pribadi. Dalam praktik kebidanan, pemahaman terhadap persepsi sakit menjadi sangat penting karena akan memengaruhi bagaimana ibu hamil, bersalin, maupun nifas merespons keluhan yang dirasakan.

Persepsi sakit adalah konstruksi kognitif dan emosional yang terbentuk ketika seseorang merasakan gejala fisik atau psikologis dan mulai memberikan makna terhadap kondisi tersebut. Setiap individu memiliki cara unik dalam menginterpretasikan sinyal tubuhnya

Menurut World Health Organization (WHO) kesehatan adalah keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial yang memungkinkan setiap individu hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Artinya, kesehatan seseorang tidak dapat diukur dari aspek fisik, mental, dan sosial saja, tetapi juga dapat diukur dari aktivitas atau produktivitas sehari-hari yaitu dalam arti memiliki pekerjaan atau menghasilkan secara ekonomi. Namun harus diakui bahwa kualitas Kesehatan masyarakat Indonesia selama ini tergolong rendah. Selama ini masyarakat miskin atau yang kurang mampu cenderung kurang memperhatikan kesehatannya. Hal ini mungkin disebabkan rendahnya tingkat kesadaran akan pentingnya kesehatan dalam kehidupan, padahal kesadaran menjaga dan melindungi kesehatan penting untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya (WHO, 2019).

Menurut World Health Organization (WHO) yang dimaksud dengan sehat adalah suatu kondisi tubuh yang lengkap secara jasmani, mental, dan sosial, dan tidak hanya sekedar terbebas dari suatu penyakit dan ketidakmampuan atau kecacatan, sedangkan menurut UU No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social dan ekonomi

Sakit merupakan kondisi yang tidak menyenangkan mengganggu aktifitas jasmani dan rohani sehingga seseorang tidak bisa menjalankan fungsi dan perannya sebagaimana mestinya dalam masyarakat. *Sickness* menunjuk kepada suatu dimensi sosial yakni kemampuan untuk menunaikan kewajiban terhadap kehidupan kelompok. Selama seseorang masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban sosialnya, bekerja sebagaimana mestinya maka masyarakat tidak menganggapnya sakit.

Perilaku mencari pengobatan (*health seeking behavior*) adalah tindakan yang dilakukan individu ketika mengalami gangguan kesehatan untuk memperoleh kesembuhan. Perilaku ini dapat berupa pengobatan mandiri, konsultasi dengan tenaga kesehatan, maupun penggunaan pengobatan tradisional. Variasi perilaku ini seringkali dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, akses pelayanan kesehatan, kepercayaan terhadap tenaga kesehatan, serta faktor ekonomi.

Di Indonesia, masih banyak masyarakat yang menunda pencarian pengobatan atau memilih pengobatan alternatif sebelum mendapatkan penanganan medis yang tepat. Hal ini dapat meningkatkan risiko komplikasi, terutama pada kelompok rentan seperti ibu hamil dan bayi baru lahir. Oleh karena itu, penting untuk memahami hubungan antara persepsi sakit dan perilaku mencari pengobatan guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan edukasi masyarakat.

Masalah kesehatan masyarakat, terutama dinegara berkembang seperti Indonesia, terdapat dua aspek yaitu aspek fisik seperti ketersediaan sarana kesehatan dan pengobatan penyakit, sedangkan aspek non-fisik yang berkaitan dengan perilaku kesehatan masyarakat. Kedua aspek tersebut saling Saat ini, masalah kesehatan menjadi topik yang sangat penting. Hal tersebut tidak terlepas dari gaya hidup masyarakat pada umumnya. Masalah Kesehatan dapat terjadi pada kalangan usia, dari usia muda hingga usia tua; laki-laki maupun perempuan; serta tidak mengenal perbedaan ras, agama, dan lain-lain. Masalah kesehatan dapat tumbuh dari berbagai penyebab, salah satunya adalah perubahan fungsi di dalam tubuh, baik fisiologis maupun anatomi, tidak mengherankan jika kita terus-menerus dihadapkan pada tekanan dan tuntutan kita akan dapat mudah terserang penyakit. berkaitan yaitu aspek perilaku dalam menentukan sarana kesehatan yang dipilih dan pengobatan penyakit yang merupakan aspek non-fisik perilaku individu atau

kelompok dengan kemungkinan besar yang mengalami keluhan kesehatan tetapi masyarakat lebih memilih untuk pergi ketempat pelayanan kesehatan medis ataupun memilih alternatif pengobatan yang lain. Penentuan individu dalam memilih pengobatan oleh pasien dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempengaruhi individu untuk memenuhi keinginannya untuk sembuh dan sehat.

Tingkat kemiskinan yang tinggi menyebabkan masyarakat yang kurang mampu tidak dapat memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang tergolong mahal. Jika tidak diatasi, kondisi tersebut akan memperparah kondisi kesehatan masyarakat indonesia, karena krisis ekonomi telah meningkatkan jumlah masyarakat kurang mampu dan mengakibatkan naiknya biaya pelayanan kesehatan, sehingga semakin menekan akses mereka karena biaya yang semakin tak terjangkau (Desriyani dkk, 2022).

Penentuan pemilihan pengobatan yang dilakukan masyarakat, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain seperti pengetahuan, masalah biaya pengobatan, ketidakpuasan terhadap hasil pengobatan, ketidakpuasan dengan pelayanan yang diterima dalam menjalani pengobatan, beberapa kasus malpraktek, dan letak tempat pelayanan kesehatan.

Dengan memahami kedua konsep ini, tenaga kesehatan khususnya bidan dapat memberikan pendekatan yang lebih efektif, komunikatif, dan sesuai dengan kebutuhan pasien.

Persepsi sakit yang tidak tepat dapat menyebabkan keterlambatan dalam perilaku mencari pengobatan, yang berpotensi menimbulkan komplikasi serius. Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang berkelanjutan, dukungan keluarga, serta peran aktif tenaga kesehatan untuk membentuk perilaku kesehatan yang tepat.

B. Proses Persepsi

Penerimaan informasi terjadi setelah stimulus dari objek disampaikan dan diterima oleh alat indra. Sinyal sensorik dikirim dari alat indera ke otak. Di otak, terjadi proses yang menjadi pusat kesadaran, memungkinkan seseorang menyadari apa yang mereka lihat, dengar, atau rasakan. Persepsi ini dapat menyebabkan respons yang beragam pada setiap individu (Khoironi, 2022)

Proses aktif dalam memilih, mengatur, dan menafsirkan orang, objek, peristiwa, serta aktivitas dikenal sebagai persepsi. Persepsi dimulai dari pengenalan dan berakhir pada interpretasi. Ini merujuk pada Selection, Organization, and Interpretation antara berbagai elemen dalam proses persepsi. Saat manusia memilih dan menafsirkan pengalaman mereka, mereka juga mengatur bagaimana persepsi mereka terbentuk. Cara kita memahami orang dan situasi dipengaruhi oleh apa

yang kita amati. Lebih dari itu, cara kita menafsirkan orang atau situasi membimbing kita untuk fokus pada aspek-aspek tertentu (Swarjana, 2022).

1. Selection

Pada fase ini, seseorang mungkin cenderung memilih atau mengidentifikasi hal-hal yang lebih menarik atau diinginkan, serta menginterpretasikannya bersama dengan elemen lain.

2. Organization

Pada tahap ini seseorang mengatur persepsinya dengan baik menggunakan struktur kognitif. Menurut teori konstruktivisme, seseorang mengukur dan menafsirkan pengalamannya menggunakan struktur kognitif.

3. Interpretation

Interpretasi merupakan langkah subyektif dalam menghasilkan penjelasan terhadap pengalaman visual atau emosional yang kita alami. Saat melakukan interpretasi, seseorang mengartikan atau menafsirkan informasi atau rangsangan yang diterima, mencoba memberikan makna terhadap objek, kejadian, atau fenomena tertentu. Proses interpretasi ini terjadi ketika ada pertanyaan yang timbul terkait dengan objek, kejadian, atau situasi yang sedang diamati (Wood dalam Swarjana, 2022).

C. Syarat Terjadinya Persepsi

Beberapa syarat yang dapat mempengaruhi terjadinya persepsi menurut Khoironi (2022) yaitu:

1. Objek yang dipersepsikan

Benda yang menimbulkan respons pada alat indera bisa berasal dari luar individu yang mengamatinya, tetapi juga mungkin berasal dari internal individu itu sendiri, berhubungan langsung dengan saraf penerima yang bertindak sebagai reseptor.

2. Alat indera saraf, dan pusat susunan saraf

Alat indera atau reseptor adalah perangkat yang bertugas menerima rangsangan. Di samping itu, saraf sensorik berperan sebagai pengantar rangsangan dari reseptor menuju inti sistem saraf.

3. Perhatian

Untuk memahami atau melihat sesuatu, diperlukan fokus atau perhatian, yang merupakan tahap awal dalam mempersiapkan diri untuk memahami sesuatu

D. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi

Menurut Hermuningsih dan Wardani, ada dua kategori factor yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi proses terjadinya persepsi (Prayogi & Purwanti, 2023).

1. Faktor Internal

Komponen internal meliputi aspek psikologis seseorang, termasuk emosi, sikap, dan karakter, seperti prasangka, keinginan, fokus, pembelajaran, kondisi fisik, gangguan mental, nilai-nilai, kebutuhan, dan motivasi

2. Faktor Eksternal

Berbagai hal dapat mempengaruhi cara seseorang melihat dunia di sekitarnya. Faktor eksternal, seperti informasi yang diterima, latar belakang keluarga, tingkat pengetahuan, intensitas pengalaman, keragaman, dan pengulangan aktivitas, semuanya berkontribusi terhadap cara seseorang memahami hal-hal yang baru atau yang sudah akrab bagi mereka. Banyak faktor yang mempengaruhi cara seseorang memahami dunia sekitarnya. Kondisi psikologis seseorang memiliki pengaruh besar dalam cara mereka menginterpretasikan hal-hal di sekitar mereka. Menurut Wood dalam Swarjana (2022) ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi individu :

a. Faktor fisiologis.

Perbedaan dalam kemampuan sensoris dan kondisi fisiologis individu menyebabkan variasi dalam persepsi. Sensitivitas indra manusia tidak seragam, dan kesehatan mental memainkan peran penting dalam membentuk persepsi seseorang. Kondisi Kesehatan yang buruk, kelelahan, serta stres dapat signifikan mempengaruhi bagaimana seseorang melihat sesuatu. Seseorang yang mengalami kondisi tersebut cenderung cenderung menafsirkan hal-hal dengan pandangan yang lebih negatif dibandingkan ketika mereka dalam keadaan yang lebih baik atau sehat.

b. Harapan (Expectation)

Keyakinan yang seseorang miliki dapat dipengaruhi oleh harapan. Harapan tersebut terbentuk dari informasi yang diterima mengenai suatu hal, dan dapat mempengaruhi cara seseorang memandang sesuatu.

c. Kemampuan Kognitif (Cognitive Abilities) Kemampuan berpikir dan memproses informasi seseorang dapat berdampak pada cara mereka melihat orang lain. Jika seseorang hanya mampu melihat orang lain secara terbatas, baik dalam sudut pandang positif maupun negatif, ini bisa mengindikasikan keterbatasan dalam pemahaman mereka terhadap orang lain. Sebaliknya, individu yang memiliki kapasitas kognitif yang lebih kompleks cenderung

mampu memahami orang lain dengan lebih baik. Misalnya, seseorang yang hanya bergantung pada data konkret mungkin memiliki keterbatasan dalam memahami orang lain secara mendalam, dibandingkan dengan mereka yang juga mempertimbangkan aspek psikologis.

d. Peran Sosial (Social Roles)

Pandangan seseorang juga dapat dipengaruhi oleh tugas-tugas yang mereka emban dalam masyarakat. Sebagai contoh, seorang pemimpin masyarakat akan melihat anggota masyarakat dengan sudut pandang peran sosialnya, seorang guru akan melihat para murid dengan fokus pada perannya sebagai pendidik, dan hal serupa lainnya.

e. Keanggotaan dalam suatu budaya dan komunitas social

(Membership in cultures and Social Communities) Keanggotaan dalam budaya dan komunitas sosial merujuk pada keterlibatan individu dalam suatu kelompok yang memiliki keyakinan, nilai, pemahaman, praktik, serta cara menginterpretasikan pengalaman bersama. Seseorang juga dapat tergabung dalam kelompok sosial yang membentuk pengetahuan, pengalaman, dan sudut pandang mereka. Kelompok sosial ini merupakan sekelompok individu dalam masyarakat yang memiliki perbedaan dengan kelompok lainnya. Mereka memiliki nilai, pemahaman, dan praktik yang membedakan mereka dari individu di luar kelompok tersebut. Aspek-aspek seperti gender, ras, agama, dan orientasi seksual seringkali menjadi penentu dalam membentuk kelompok sosial dan mungkin mempengaruhi perilaku anggota masyarakat.

Bagaimanapun, menurut Langton dan Robbins, ada tiga factor utama yang mempengaruhi cara seseorang memahami sesuatu, yaitu pengamat (sikap, motif, minat, pengalaman, harapan), situasi (waktu, lingkungan kerja, lingkungan sosial), dan objek yang diamati (kejelasan, gerakan, suara, ukuran, latar belakang, kedekatan) (Swarjana, 2022).

a. Pelaku Persepsi (The Perceiver)

Saat seseorang mengamati atau melihat sesuatu dan berupaya menginterpretasikannya, penafsiran mereka dipengaruhi oleh karakteristik pribadi individu yang melakukan pengamatan.

b. Situasi (The Stusation)

Keadaan tempat atau situasi di mana suatu objek atau peristiwa diamati memainkan peran penting. Cara pandang kita terhadap dunia dapat dipengaruhi oleh konteks sekitar kita. Sebagai contoh, seseorang mungkin terlihat cocok saat mengenakan pakaian santai seperti celana pendek dan kaos

di lingkungan informal, tapi hal tersebut mungkin tidak pantas di lingkungan kerja.

c. Target (The Target)

Persepsi terhadap suatu target dapat dipengaruhi oleh beragam ciri yang dimilikinya. Di dalam sebuah kelompok, seseorang yang aktif cenderung lebih mudah diperhatikan daripada mereka yang cenderung lebih tenang. Oleh karena itu, bagaimana seseorang dipersepsikan sangat bergantung pada daya tariknya. Pandangan kita terhadap suatu target bisa dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti perilaku baru, gerakan, suara, dan juga ukuran dari target tersebut. Menurut Dimyanti, dalam penelitian yang dilakukan oleh Iqbal (2019)

Faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap persepsi dapat disajikan sebagai berikut: fokus perhatian yang terpilih, tingkat intensitas rangsangan, nilai dari kebutuhan yang dirasakan, serta pengalaman masa lalu yang dimiliki. Setelah menerima input dari berbagai objek atau rangsangan, indera manusia mengirim informasi ini ke otak untuk diinterpretasikan. Kemampuan untuk memproses informasi ini sangat bergantung pada bagaimana seseorang Khoironi (2022) beberapa variabel yang mempengaruhi persepsi seseorang termasuk faktor internal dan faktor eksternal. memilih untuk memberikan fokus khusus pada aspek-aspek tertentu. Sikap, alasan, kepentingan, pengalaman, serta harapan adalah beberapa ciri individu yang berdampak pada cara individu memahami sesuatu (Iqbal, 2019)

Khoironi (2022) beberapa variabel yang mempengaruhi persepsi seseorang termasuk faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

Faktor internal merujuk pada hal-hal yang berasal dari pengalaman pribadi seseorang ketika mereka menemukan cara untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi cara seseorang memahami sesuatu meliputi usia, tingkat pendidikan, dan pekerjaan mereka

a. Usia

Usia merujuk pada rentang waktu sejak kelahiran hingga ulang tahun seseorang. Seiring bertambahnya usia, seseorang akan mengalami pertumbuhan dalam kedewasaan dan kekuatan, yang memungkinkan mereka untuk berpikir dan bertindak secara lebih matang. Proses penuaan juga meningkatkan kemampuan seseorang untuk menggunakan pengetahuan yang mereka peroleh. Hal ini sangat mempengaruhi tingkat pengetahuan dan

pengalaman seseorang, sehingga semakin tua seseorang, semakin konstruktif mereka dalam menerapkan pengetahuan dan pengalaman tersebut dalam berpikir dan bekerja.

b. Pendidikan

Individu yang telah menempuh pendidikan tinggi cenderung memberikan respons yang lebih logis dibandingkan dengan mereka yang memiliki tingkat pendidikan lebih rendah atau bahkan yang tidak memiliki pendidikan formal.

c. Pekerjaan

Pekerjaan adalah aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh penghasilan. Orang-orang yang sibuk bekerja seringkali memiliki sedikit kesempatan untuk mendapatkan informasi tambahan. Melalui pekerjaan, seseorang dapat melakukan tindakan yang bernilai dan bermanfaat, memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang suatu hal, dan akhirnya mengembangkan pandangan positif terhadapnya.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merujuk pada aspek yang berlawanan dengan factor internal, yakni hal-hal yang berasal dari lingkungan atau luar diri seseorang yang memengaruhi proses penciptaan dan penemuan sesuatu. Dalam konteks ini, faktor eksternal mempengaruhi persepsi seseorang dan terdiri dari informasi serta pengalaman dari luar.

a. Informasi

Semakin melimpahnya informasi dapat berdampak pada peningkatan pengetahuan seseorang, yang pada gilirannya dapat memicu kesadaran. Kesadaran ini kemudian mendorong individu untuk bertindak sesuai dengan pengetahuan yang telah diperoleh.

b. Pengalaman

Pengalaman merujuk pada kejadian yang seseorang alami. Bukan hanya sekadar peristiwa yang terjadi terhadap suatu objek, tetapi cenderung memiliki dampak, baik positif maupun negatif, pada objek tertentu. Untuk menjadi dasar pembentukan sikap pribadi, sebuah pengalaman harus meninggalkan kesan yang kuat. Sikap lebih mudah terbentuk apabila pengalaman tersebut melibatkan emosi dan memiliki dampak yang mendalam. Pengalaman individu memiliki peran penting dalam cara kita menginterpretasikan rangsangan atau stimulus yang diterima. Baik pengalaman masa lalu maupun pembelajaran yang kita terima dapat menyebabkan perbedaan dalam cara kita menafsirkan suatu situasi. Pengalaman juga berpengaruh pada ketajaman persepsi seseorang. Tidak

selalu pengalaman diperoleh melalui proses pendidikan formal, melainkan bisa juga melalui serangkaian kejadian yang dialami seseorang.

E. Jenis Persepsi

Disini jenis persepsi terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Persepsi Positif

Pemahaman yang positif adalah pemahaman yang mencerminkan semua pengetahuan, baik yang diketahui maupun yang tidak, dan diwujudkan dalam respons yang mendorong pemanfaatannya.

2. Persepsi Negatif

Persepsi negatif adalah pandangan yang buruk yaitu pandangan yang mencerminkan pengetahuan dan respons yang tidak sejalan dengan objek yang dilihat atau dianggap oleh seseorang (Khoironi, 2022)

Menurut (Handayani, 2020), dalam penelitiannya, terdapat empat klasifikasi persepsi yang diidentifikasi, yakni:

1. Persepsi sangat positif, merujuk pada pandangan atau penilaian yang sangat positif terhadap suatu objek.
2. Persepsi positif, mengacu pada pandangan atau penilaian yang baik terhadap suatu objek.
3. Persepsi cukup, merupakan pandangan atau penilaian yang memadai terhadap suatu objek.
4. Persepsi negatif, merujuk pada pandangan atau penilaian yang kurang baik terhadap suatu objek.

F. Indikator Persepsi

Menurut Walgito sebagaimana yang dijelaskan dalam Prayogi & Purwanti (2023), indikator persepsi terbagi menjadi empat tahap sebagai berikut:

1. Seleksi :Tahap ini dikenal dengan proses kealaman atau proses fisik, yang merupakan tahap di mana stimulus ditangkap oleh alat indra manusia. Proses ini juga disebut sebagai seleksi, di mana individu memilih informasi yang diterima.
2. Organisasi: Tahap ini dikenal sebagai proses fisiologis di mana rangsangan yang diterima oleh reseptor (organ sensorik) ditransmisikan melalui saraf sensorik. Ini juga merupakan tahap pengorganisasian, di mana individu mengatur informasi yang diterima.
3. Interpretasi: Tahap ini merupakan proses psikologis di mana individu mempersepsikan stimulus yang diterima oleh reseptor. Tahap ini juga dikenal sebagai tahap interpretasi atau pemahaman.
4. Retensi: Tahap retensi merupakan tahap akhir dalam pembentukan proses persepsi. Retensi ini merupakan pengumpulan hasil dari proses persepsi yang

termanifestasikan dalam tanggapan dan perilaku. Tahap ini juga dikenal sebagai tahap penyimpanan dalam memori.

G. Komponen Kunci Persepsi Sakit Health Belief Model

Kepercayaan Kesehatan (HBM) merupakan kerangka konseptual yang paling banyak digunakan untuk menjelaskan perilaku pencarian pengobatan. Enam komponen utamanya saling berinteraksi membentuk keputusan kesehatan seseorang

1. Persepsi Kerentanan Seberapa rentan seseorang terhadap suatu penyakit.
2. Persepsi Keparahan Seberapa serius konsekuensi penyakit yang dirasakan.
3. Persepsi Manfaat Keyakinan bahwa tindakan kesehatan akan bermanfaat.
4. Persepsi Hambatan Rintangan seperti biaya, jarak, dan waktu
5. Isyarat untuk Bertindak Pemicu internal atau eksternal pencarian pengobatan.
6. Efikasi Diri Keyakinan pada kemampuan diri untuk bertindak sehat.

Studi Kasus: Ibu dengan Anak Demam Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana komponen HBM memengaruhi keputusan ibu dalam mencari pengobatan untuk anak yang mengalami demam. Mayoritas responden menunjukkan kecenderungan memilih layanan Kesehatan modern. 74,2% Pilih Pengobatan Modern Puskesmas, RS, atau dokter praktik 61,8% Kurang Isyarat Bertindak Mayoritas menunjukkan isyarat untuk bertindak yang rendah 56,2% Efikasi Diri Rendah Kurang yakin dalam mengambil tindakan Kesehatan $p=0,000$ Signifikansi HBM Komponen HBM simultan berpengaruh signifikan

Temuan ini menegaskan bahwa meskipun persepsi kerentanan dan keparahan sudah positif, rendahnya efikasi diri tetap menjadi hambatan nyata dalam tindakan pencarian pengobatan yang optimal.

H. Perilaku Mencari Pengobatan Health Seeking Behavior

Perilaku mencari pengobatan (Health Seeking Behavior) adalah serangkaian tindakan yang dilakukan individu ketika mengalami sakit, mulai dari mengenali gejala, memutuskan untuk mencari bantuan, hingga memilih jenis layanan kesehatan yang tepat.

Faktor-faktor Penentu Keputusan mencari pertolongan dipengaruhi oleh persepsi individu, dukungan sosial, akses geografis, kemampuan ekonomi, pengetahuan tentang penyakit, serta kepercayaan pada system layanan kesehatan yang tersedia

Persepsi Sakit dalam Konteks Spesifik Berbagai kondisi medis memiliki dinamika persepsi sakit dan perilaku mencari pengobatan yang unik. Bab ini

mengeksplorasi bagaimana konteks penyakit tertentu membentuk pola keputusan individu.



Mengapa Keputusan Cepat Sangat Kritis? Sindrom Koroner Akut (ACS) terjadi akibat kurangnya suplai oksigen ke otot jantung. Kondisi ini memerlukan respons segera menuju fasilitas pelayanan kesehatan karena setiap menit keterlambatan dapat memperburuk kerusakan jaringan jantung secara permanen. Penelitian membuktikan terdapat hubungan signifikan ($p=0,049$) antara illness perception Dengan health seeking behavior pada pasien ACS. Persepsi sakit yang positif yaitu memahami keseriusan kondisi dan percaya bahwa pengobatan akan membantu secara langsung mendorong keputusan segera mencari pertolongan medis. Persepsi sakit yang keliru pada ACS dapat berakibat fatal. Edukasi public tentang gejala ACS sangat mendesak

Faktor Pendukung dan Penghambat perilaku mencari pengobatan tidak terjadi dalam vakum. Berbagai faktor eksternal dan internal secara dinamis mendukung atau menghambat individu dalam mengambil keputusan kesehatan yang tepat waktu dan tepat sasaran.

Kekuatan Dukungan Keluarga dalam Perjalanan Kesehatan Keluarga bukan sekadar pengiring mereka adalah fondasi yang menentukan apakah seseorang akan berhasil melewati perjalanan panjang menuju kesembuhan. Dukungan mereka mengubah beban penyakit menjadi kekuatan bersama. "Ketika keluarga hadir, pengobatan bukan lagi beban ia menjadi perjalanan bersama menuju kesehatan."

I. Hubungan Persepsi Sakit dan Pemanfaatan Layanan Kesehatan

Penelitian menemukan hubungan yang bermakna antara persepsi tentang sakit dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan ($p=0,023$), meskipun dengan tingkat korelasi yang lemah ($CC=0,25$). Temuan ini mengindikasikan bahwa persepsi sakit adalah salah satu bukan satu-satunya faktor dalam keputusan mencari layanan.

1. Rekomendasi Berbasis Bukti

- a. Tingkatkan kualitas sistem pelayanan agar lebih ramah pengguna
- b. Efektifkan program preventif melalui penyuluhan kesehatan aktif
- c. Dorong masyarakat untuk memahami dan memanfaatkan kartu JAMKESMAS
- d. Perkuat edukasi tentang kapan dan mengapa harus berobat

Persepsi Sakit: Kunci Pemanfaatan Layanan Kesehatan Data konsisten menunjukkan bahwa bagaimana seseorang memandang kondisi sakitnya secara langsung memengaruhi apakah mereka akan memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia bahkan Ketika akses finansial sudah dijamin

Sebelum Intervensi Utilisasi layanan rendah meski kartu JAMKESMAS tersedia karena persepsi sakit yang kurang tepat

Setelah Penyuluhan Peningkatan utilisasi terlihat ketika masyarakat memahami kapan kondisi mereka memerlukan penanganan medis

Menuju Pemahaman yang Lebih Baik Integrasi antara teori dan temuan empiris memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika persepsi sakit dan perilaku mencari pengobatan. Bagian ini menyatukan berbagai perspektif dalam kerangka yang koheren.

J. Stigma Dan Persepsi Negatif

Stigma sebagai Penghalang Utama Stigma sosial terhadap kondisi tertentu — terutama gangguan mental seperti psikosis — menciptakan hambatan psikologis yang kuat terhadap perilaku help-seeking. Individu yang merasa akan dihakimi oleh masyarakat cenderung menyembunyikan kondisinya dan menghindari pengobatan.

Tanpa upaya pengurangan stigma yang sistematis, bahkan program Kesehatan mental terbaik pun tidak akan dimanfaatkan secara optimal.

1. Pendekatan untuk Mengurangi Stigma

- a. Kampanye kesadaran publik berbasis Komunitas
- b. Edukasi tentang penyebab biologis gangguan mental
- c. Kisah pemulihan yang menginspirasi dari penyintas
- d. Pelatihan sensitivitas bagi tenaga Kesehatan

Efikasi diri yang rendah yaitu kurangnya keyakinan pada kemampuan diri untuk mengambil Tindakan kesehatan yang diperlukan terbukti menjadi penghambat signifikan dalam pencarian pengobatan. Pada kasus ibu dengan anak demam, 56,2% menunjukkan efikasi diri yang rendah

Manifestasi Efikasi Diri Rendah Ragu mengambil keputusan, menunda pengobatan, bergantung pada orang lain, dan mudah menyerah saat menghadapi hambatan.

Intervensi yang Direkomendasikan Pelatihan keterampilan praktis, konseling motivasional, model peran dari komunitas, dan penguatan melalui pengalaman sukses bertahap.

Hasil yang Diharapkan Peningkatan inisiatif mandiri, kepatuhan pengobatan yang lebih baik, dan kemampuan mengatasi hambatan dalam mencari layanan kesehatan.

Mengatasi Keraguan: Membangun Efikasi Diri Setiap perjalanan kesehatan dimulai dari satu langkah pertama. Membangun keyakinan diri bahwa seseorang mampu mengambil tindakan yang tepat adalah intervensi kesehatan yang paling mendasar namun sering terabaikan. Mulai dari Pengalaman Kecil Keberhasilan kecil membangun kepercayaan diri secara bertahap. Belajar dari Orang Lain Model peran dari orang yang berhasil mengatasi kondisi serupa. Efikasi Diri Penuh Keyakinan kuat untuk mengambil Tindakan kesehatan secara mandiri

Implikasi untuk Sistem Kesehatan Temuan dari berbagai penelitian memiliki implikasi langsung terhadap cara sistem kesehatan dirancang, disampaikan, dan dievaluasi. Sistem yang responsif terhadap persepsi dan kebutuhan pasien akan menghasilkan utilisasi yang lebih optimal

K. Studi Kasus

Ibu dengan Anak Demam Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana komponen HBM memengaruhi keputusan ibu dalam mencari pengobatan untuk anak yang mengalami demam. Mayoritas responden menunjukkan kecenderungan memilih layanan Kesehatan modern. 74,2% Pilih Pengobatan Modern Puskesmas, RS, atau dokter praktik 61,8% Kurang Isyarat Bertindak Mayoritas menunjukkan isyarat untuk bertindak yang rendah 56,2% Efikasi Diri Rendah Kurang yakin dalam mengambil tindakan Kesehatan $p=0,000$ Signifikansi HBM Komponen HBM simultan berpengaruh signifikan.

Pasien TB Paru Penelitian mengungkap bahwa perilaku pencarian pengobatan penderita TB belum mencapai yang ditetapkan. Tiga faktor utama teridentifikasi sebagai penentu perilaku ini.

Information Seeking Kebutuhan aktif penderita TB untuk mencari informasi tentang penyakit yang dialaminya menjadi fondasi awal pengambilan keputusan pengobatan yang tepat

Persepsi Penyakit Pemahaman mendalam tentang TB — termasuk cara penularan, gejala, dan konsekuensi jika tidak diobati — mendorong penderita untuk mencari pengobatan lebih cepat

Dukungan Keluarga berperan sebagai motivator utama yang mendorong penderita TB untuk menjalani pengobatan secara konsisten dan tuntas hingga selesai.

Hasil uji statistik menunjukkan hubungan yang sangat signifikan ($p=0,000$) antara ketiga factor tersebut dengan perilaku pencarian pengobatan TB.

Pasien Penyakit Degeneratif dan Akupunktur Penyakit degeneratif telah menjadi masalah kesehatan global yang semakin meningkat. Pasien dengan kondisi ini seringkali mengeksplorasi berbagai pilihan pengobatan, termasuk pendekatan non-farmakologi seperti akupunktur.

60 % HSB Positif Mencari pengobatan langsung atau kombinasi dengan akupunktur. 40 % HSB Negatif Tidak mencari pengobatan atau hanya membeli obat di apotek. Keyakinan Manfaat Percaya bahwa akupunktur memberikan manfaat nyata. Efikasi Diri Yakin mampu menjalani sesi pengobatan secara rutin. Isyarat Bertindak Dorongan dari gejala atau anjuran orang terdekat

Penderita Psychosis dan Peran Caregiver Kondisi psikosis menghadirkan tantangan unik dalam perilaku help-seeking. Berbeda dari penyakit fisik, gangguan mental seringkali disertai stigma sosial yang kuat, sehingga proses pengambilan keputusan untuk mencari bantuan menjadi jauh lebih kompleks.

Pengaruh Illness Perception Persepsi caregiver tentang kondisi penderita psikosis sangat menentukan apakah mereka akan aktif mencari bantuan profesional atau justru menunda-nunda karena berbagai pertimbangan sosial dan keluarga.

Dampak Stigma Stigma terhadap gangguan mental membuat keluarga enggan membawa anggotanya ke fasilitas kesehatan jiwa. Normalisasi dan edukasi publik tentang Kesehatan mental menjadi agenda mendesak dalam system kesehatan.

Bagian ini memperdalam pemahaman melalui analisis kasus spesifik yang mengungkap kompleksitas hubungan antara persepsi sakit dan keputusan memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia. JAMKESMAS Pemanfaatan program jaminan kesehatan oleh masyarakat miskin. Persepsi vs Utilisasi Hubungan antara cara pandang terhadap sakit dan penggunaan layanan Implikasi Kebijakan Rekomendasi berbasis bukti untuk penguatan system kesehatan

Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan oleh Peserta JAMKESMAS. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dirancang untuk memastikan masyarakat miskin dapat mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan finansial. Namun, penelitian menunjukkan bahwa program ini belum dimanfaatkan secara optimal.

L. Self Care Inisiatif Mandiri Dalam Kesehatan

Self-Care adalah Upaya penyembuhan yang dilakukan berdasarkan inisiatif sendiri tanpa mencari rujukan ke tenaga kesehatan manapun. Merupakan lini pertama respons terhadap gejala penyakit ringan.

1. Contoh Praktik Self-Care

- a. Istirahat yang cukup dan tidur berkualitas
- b. Memperbanyak konsumsi air putih hangat
- c. Menggunakan ramuan tradisional rumahan seperti jahe atau madu
- d. Mengompres bagian tubuh yang nyeri atau demam
- e. Menjaga pola makan bergizi dan seimbang

Pengobatan mandiri menggunakan obat-obatan baik modern maupun tradisional/herbal tanpa resep dokter merupakan praktik yang sangat umum di Indonesia. Kemudahan akses ke apotek dan toko obat tradisional menjadi faktor pendorong utama perilaku ini.

Obat Modern; Obat bebas (OTC) seperti paracetamol, antasida, dan antihistamin yang mudah didapat tanpa resep di apotek atau minimarket.

Obat Tradisional Jamu, herbal terstandar, dan fitofarmaka yang berasal dari bahan-bahan alam dan telah lama digunakan secara turun-temurun

Distribusi Urban vs Pedesaan Praktik pengobatan mandiri ditemukan merata baik di masyarakat perkotaan maupun pedesaan, dengan pilihan produk yang berbeda.

Pilihan Pengobatan Mandiri Di antara obat modern dan ramuan tradisional, masyarakat Indonesia menavigasi spektrum pilihan pengobatan mandiri yang kaya dan beragam mencerminkan luralisme medis yang menjadi ciri khas budaya Kesehatan nusantara.

Keputusan untuk mencari pengobatan tidak terjadi dalam ruang hampa. Berbagai faktor dari karakteristik pribadi hingga lingkungan sosial dan sistem kesehatan secara bersama-sama membentuk pilihan yang diambil individu ketika menghadapi sakit

M.Persepsi Masyarakat Terhadap Sakit dan Penyakit

Persepsi masyarakat mengenai terjadinya penyakit berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, karena tergantung dari kebudayaan yang ada dan berkembang dalam masyarakat tersebut. Persepsi kejadian penyakit yang berlainan dengan ilmu Kesehatan sampai saat ini masih ada di masyarakat; dapat turun dari satu generasi ke generasi berikutnya dan bahkan dapat berkembang luas. Berikut ini contoh persepsi masyarakat tentang penyakit malaria yang saat ini masih ada di beberapa daerah pedesaan di Papua. Makanan pokok penduduk Papua adalah sagu yang tumbuh di daerah rawa-rawa. Selain rawa-rawa, tidak jauh dari mereka tinggal terdapat hutan lebat. Penduduk desa tersebut beranggapan bahwa hutan itu milik penguasa gaib yang dapat menghukum setiap orang yang melanggar ketentuannya. Pelanggaran dapat berupa menebang, membatat hutan untuk tanah pertanian, dan lain-lain akan diganjar hukuman berupa penyakit dengan gejala demam tinggi, menggigil, dan muntah. Penyakit tersebut dapat sembuh dengan cara minta ampun kepada penguasa hutan, kemudian memetik daun dari pohon tertentu, dibuat ramuan untuk di minum dan dioleskan ke seluruh tubuh penderita. Dalam beberapa hari penderita akan sembuh. Persepsi masyarakat mengenai penyakit diperoleh dan ditentukan dari penuturan sederhana dan mudah secara turun temurun. Misalnya penyakit akibat kutukan Allah, makhluk gaib, roh-roh jahat, udara busuk, tanaman berbisa, binatang, dan sebagainya. Pada sebagian penduduk Pulau Jawa, dulu penderita demam sangat tinggi diobati dengan cara menyiram air di malam hari. Air yang telah diberi ramuan dan jampi-jampi oleh dukun dan pemuka masyarakat yang disegani digunakan sebagai obat malaria. Perilaku sakit merupakan perilaku orang sakit yang meliputi cara seseorang memantau tubuhnya; mendefinisikan dan menginterpretasikan gejala yang dialami; melakukan upaya penyembuhan; dan penggunaan sistem pelayanan kesehatan

Konsep Sakit berdasarkan Trias Epidemiologi Penyakit adalah hasil dari interaksi kompleks (ketidak seimbangan) antara tiga faktor, yaitu agen, host (induk semang) dan lingkungan. Kesalahan yang paling sering dilakukan orang adalah memusatkan perhatian hanya pada salah satu dari ketiga faktor tersebut pada waktu mengendalikan atau mencegah penyakit. Segitiga epidemiologi merupakan teori dasar yang terkenal sejak disiplin ilmu epidemiologi mulai digunakan di dunia, yang menggambarkan hubungan dari ketiga faktor penyebab penyakit, yaitu Host, Agent, dan Lingkungan. Segitiga epidemiologi ini sangat umum digunakan oleh para ahli dalam menjelaskan kosep berbagai permasalahan kesehatan termasuk salah satunya adalah terjainya penyakit. Hal ini sangat komprehensif dalam memprediksi suatu penyakit. Terjadinya suatu penyakit sangat tergantung dari

keseimbangan dan interaksi dari Host, Agent dan environment, ketiga unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Host atau penjamu ialah keadaan manusia yang sedemikian rupa sehingga menjadi faktor risiko untuk terjadinya suatu penyakit. Faktor ini disebabkan oleh faktor intrinsik. Komponen dari faktor penjamu yang biasanya menjadi faktor untuk timbulnya suatu penyakit sebagai berikut: Umur. Misalnya, usia lanjut lebih rentang untuk terkena penyakit karsinoma, jantung dan lain-lain daripada yang usia muda.
2. Agent atau pembawa bibit penyakit dapat berupa makhluk hidup ataupun jasad renik pembawa bibit penyakit yang disebabkan oleh berbagai unsur seperti unsur biologis yang dikarenakan oleh mikro organisme (virus, bakteri, jamur, parasit, protozoa, metazoa,), Konsep Kejadian Penyakit unsur nutrisi karena bahan makanan yang tidak memenuhi standar gizi yang ditentukan, unsur kimiawi yang disebabkan karena bahan dari luar tubuh maupun dari dalam tubuh sendiri (karbon monoksida, obat-obatan, arsen, pestisida), unsur fisika yang disebabkan oleh panas, benturan, serta unsur psikis atau genetik yang terkait dengan hereditas atau keturunan. Demikian juga dengan unsur kebiasaan hidup (rokok, alkohol,) perubahan hormonal dan unsur fisiologis seperti kehamilan dan persalinan
3. Environment faktor yang ketiga sebagai penunjang terjadinya penyakit, hal ini Karena faktor ini datang dari luar atau bisa disebut sebagai faktor ekstrinsik.

N. Perilaku Mencari Pengobatan Dalam Konteks Indonesia

Indonesia dengan keragaman budaya, geografi, dan kondisi sosial-ekonominya menghadirkan tantangan dan peluang unik dalam memahami perilaku mencari pengobatan. Sistem Kesehatan nasional berupaya menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui berbagai program dan kebijakan strategis.

Implementasi Sistem Kesehatan Nasional: Refleksi Sistem Perilaku pencarian pengobatan mencerminkan sejauh mana implementasi sistem kesehatan nasional berjalan efektif dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Indikator Positif Peningkatan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat merupakan indikator positif keberhasilan program JKN dan penguatan layanan primer. Tantangan Berkelanjutan Diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan peningkatan ini merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

Tiga Sektor Pengobatan di Indonesia; Self-Medication Pengobatan mandiri menggunakan obat bebas atau cara-cara non-medis tanpa supervisi profesional kesehatan. Pengobatan Medis Pelayanan Kesehatan konvensional yang diberikan oleh

tenaga medis terlatih di fasilitas kesehatan resmi. Pengobatan Tradisional Ramuan herbal, jamu, dan praktik penyembuhan warisan budaya yang masih dipercaya dan digunakan luas. Ketiga sektor ini tidak selalu eksklusif — banyak masyarakat Indonesia memanfaatkan kombinasi dari ketiganya secara bersamaan atau berurutan dalam proses penyembuhan.

Tiga Pilar Pengobatan yang Saling Terhubung; Obat Modern Farmasi berbasis bukti ilmiah dengan standar keamanan dan efektivitas yang terukur melalui uji klinis. Obat Tradisional Kearifan lokal yang telah teruji selama berabad-abad, kini semakin diakui dan diintegrasikan dalam system kesehatan nasional. Konsultasi Dokter Panduan profesional yang memastikan pengobatan tepat, aman, dan sesuai dengan kondisi spesifik setiap pasien.

Pengetahuan tentang perjalanan penyakit dan faktor-faktor yang mempengaruhi berguna untuk menemukan strategi pencegahan penyakit yang efektif. Pencegahan penyakit adalah tindakan yang ditujukan untuk mencegah, menunda, mengurangi, membasmi, mengeliminasi penyakit dan kecacatan, dengan menerapkan sebuah atau sejumlah intervensi yang telah dibuktikan efektif. menyajikan tiga tingkat pencegahan penyakit: pencegahan primer, sekunder, dan tersier.

Pencegahan primer adalah upaya memodifikasi factor risiko atau mencegah berkembangnya faktor risiko, sebelum dimulainya perubahan patologis, dilakukan pada tahap suseptibel dan induksi penyakit, dengan tujuan mencegah atau menunda terjadinya kasus baru penyakit. Termasuk yang berkaitan dengan pencegahan primer adalah "pencegahan primordial" dan "reduksi kerugian". Pencegahan primordial adalah strategi pencegahan penyakit dengan menciptakan lingkungan yang dapat mengeliminasi faktor risiko, sehingga tidak diperlukan intervensi preventif lainnya. Contoh: Program eliminasi global cacar (variola), sehingga tidak diperlukan imunisasi cacar; Penciptaan lingkungan bersih sehingga tidak diperlukan pengabutan nyamuk *Aedes aegypti*; Program eliminasi garam dari semua makanan yang jika tercapai sangat efektif untuk mencegah hipertensi. Promosi Kesehatan.

Pencegahan sekunder merupakan upaya pencegahan pada fase penyakit asimtomatis, tepatnya pada tahap preklinis, terhadap timbulnya gejala-gejala penyakit secara klinis melalui deteksi dini (early detection). Jika deteksi tidak dilakukan dini dan terapi tidak diberikan segera maka akan terjadi gejala klinis yang merugikan. Deteksi dini penyakit sering disebut "skrining". Skrining adalah identifikasi yang menduga adanya penyakit atau kecacatan yang belum diketahui dengan menerapkan suatu tes, pemeriksaan, atau prosedur lainnya, yang dapat dilakukan dengan cepat. Tes skrining memilah orang-orang yang tampaknya

mengalami penyakit dari orang-orang yang tampaknya tidak mengalami penyakit. Tes skrining tidak dimaksudkan sebagai diagnostik. Orang-orang yang ditemukan positif atau mencurigakan dirujuk ke dokter untuk penentuan diagnosis dan pemberian pengobatan yang diperlukan. Skrining yang dilakukan pada sub-populasi berisiko tinggi dapat mendeteksi dini penyakit dengan lebih efisien daripada populasi umum. Tetapi skrining yang diterapkan pada populasi yang lebih luas (populasi umum) tidak hanya tidak efisien tetapi sering kali juga tidak etis. Skrining tidak etis dilakukan jika tidak tersedia obat yang efektif untuk mengatasi penyakit yang bersangkutan atau menimbulkan trauma, stigma, dan diskriminasi bagi individu yang menjalani skrining. Sebagai contoh, skrining HIV tidak etis dilakukan pada kelompok risiko tinggi jika tidak tersedia obat antiviral yang efektif, murah, terjangkau oleh individu yang ditemukan positif mengidap HIV. Selain itu skrining HIV tidak etis dilakukan jika hasilnya mengakibatkan individu yang ditemukan positif mengalami stigmatisasi, pengucilan, dan diskriminasi pekerjaan, asuransi kesehatan, pendidikan, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Deteksi dini pada tahap preklinis memungkinkan dilakukan pengobatan segera (Prompt treatment) yang diharapkan memberikan prognosis yang lebih baik tentang kesudahan penyakit dari pada diberikan terlambat.

Pencegahan Tersier Pencegahan penyakit pada tahap ini dapat dilakukan dengan dua aspek pertama Penanganan komplikasi dan Pembatasan cacat yang bertujuan untuk menghentikan proses penyakit dan mencegah komplikasi, penyediaan fasilitas untuk membatasi ketidakmampuan dan mencegah kematian. Aspek kedua yaitu dengan melakukan rehabilitasi langkah ini dilakukan dalam rangka Penyediaan fasilitas untuk pelatihan hingga fungsi tubuh dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.

O. Perjalanan Kesehatan

Tiga Pilar Pengobatan yang Saling Terhubung; Obat Modern Farmasi berbasis bukti ilmiah dengan standar keamanan dan efektivitas yang terukur

Kompleksitas Perilaku Perilaku mencari pengobatan adalah proses kompleks yang dipengaruhi oleh interaksi faktor internal, eksternal, dan sistemik yang tidak dapat disederhanakan.

Edukasi Kesehatan Pentingnya program edukasi yang komprehensif untuk meningkatkan pengetahuan, mengubah persepsi, dan mendorong tindakan kesehatan yang tepat waktu.

Peningkatan Akses Memperluas jangkauan fasilitas Kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, terutama di daerah terpencil dan kelompok rentan.

Pemahaman Budaya Pendekatan berbasis budaya lokal yang menghormati kearifan tradisional sambil mengintegrasikannya dengan praktik medis modern

P. Menuju Kesehatan Yang Lebih Baik

Program Holistik Program peningkatan perilaku kesehatan harus mempertimbangkan keseimbangan antarself-care, pengobatan modern, dan tradisional secara terintegrasi.

Peran Keluarga Keluarga dan komunitas adalah unit terdepan yang paling berpengaruh dalam mendukung keputusan individu untuk mencari pengobatan yang tepat.

Penyedia Layanan Tenaga kesehatan harus mampu menjadi mitra terpercaya yang responsif, empatik, dan memahami konteks sosial-budaya pasien

Dengan pendekatan yang komprehensif, inklusif, dan berbasis bukti, perilaku mencari pengobatan masyarakat Indonesia dapat terus ditingkatkan menuju derajat kesehatan yang lebih tinggi dan merata

Q. Penutup

Persepsi sakit dan perilaku mencari pengobatan merupakan dua konsep yang saling berkaitan erat dan berperan penting dalam menentukan derajat kesehatan individu maupun masyarakat. Persepsi sakit tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi medis objektif, tetapi juga oleh faktor psikologis, sosial, budaya, pengalaman, serta tingkat pengetahuan individu. Variasi persepsi ini menyebabkan perbedaan dalam cara seseorang merespons gejala, menentukan tingkat keparahan penyakit, hingga mengambil keputusan untuk mencari pengobatan.

Perilaku mencari pengobatan sendiri merupakan proses dinamis yang melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pengenalan gejala hingga pemilihan jenis layanan kesehatan. Dalam konteks Indonesia, perilaku ini dipengaruhi oleh akses layanan kesehatan, kondisi ekonomi, kepercayaan terhadap pengobatan modern maupun tradisional, serta dukungan keluarga dan lingkungan sosial.

Pemahaman yang komprehensif mengenai persepsi sakit menjadi sangat penting bagi tenaga kesehatan, khususnya bidan, dalam memberikan asuhan yang efektif, komunikatif, dan berpusat pada pasien. Persepsi yang tidak tepat dapat menyebabkan keterlambatan penanganan, meningkatkan risiko komplikasi, bahkan kematian, terutama pada kelompok rentan seperti ibu dan bayi.

Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis berupa edukasi kesehatan yang berkelanjutan, peningkatan akses layanan kesehatan, penguatan peran keluarga, serta pendekatan berbasis budaya yang sensitif terhadap nilai-nilai masyarakat.

Dengan demikian, diharapkan masyarakat mampu membentuk persepsi yang lebih tepat terhadap sakit dan terdorong untuk melakukan perilaku mencari pengobatan yang rasional dan tepat waktu.

Akhirnya, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa kebidanan, tenaga kesehatan, serta praktisi dalam memahami dinamika persepsi sakit dan perilaku kesehatan, serta sebagai dasar dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

Referensi

- Desriyani, D., dkk. (2022). Faktor sosial ekonomi terhadap akses pelayanan kesehatan masyarakat. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(2), 115–123.
- Handayani, S. (2020). Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 8(1), 45–52.
- Iqbal, M. (2019). Faktor yang mempengaruhi persepsi individu dalam pelayanan kesehatan. *Jurnal Psikologi Kesehatan*, 7(2), 78–85.
- Khoironi. (2022). *Psikologi Persepsi dalam Kesehatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Marteau, T. M., et al. (2006). Illness perceptions and health behavior. *Health Psychology Journal*, 25(3), 345–353.
- Prayogi, A., & Purwanti, E. (2023). Faktor internal dan eksternal dalam pembentukan persepsi. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 12(1), 22–30.
- Swarjana, I. K. (2022). *Konsep Persepsi dalam Ilmu Kesehatan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- World Health Organization. (2019). *Constitution of the World Health Organization*. Geneva: WHO.
- World Health Organization. (2021). *Health Promotion and Disease Prevention*. Geneva: WHO Press.

Glosarium

Agent

Faktor penyebab penyakit yang dapat berupa mikroorganisme, zat kimia, atau faktor fisik.

Efikasi Diri (Self-efficacy)

Keyakinan individu terhadap kemampuannya dalam melakukan tindakan untuk mencapai hasil tertentu.

Health Belief Model (HBM)

Model teori yang menjelaskan perilaku kesehatan berdasarkan persepsi individu terhadap ancaman penyakit dan manfaat tindakan.

Health Seeking Behavior

Perilaku individu dalam mencari pertolongan atau pengobatan ketika mengalami gangguan kesehatan.

Host

Individu atau manusia yang berisiko terkena penyakit.

Interpretasi

Proses pemberian makna terhadap stimulus atau informasi yang diterima.

Persepsi

Proses kognitif dalam memahami dan menafsirkan informasi dari lingkungan melalui indera.

Persepsi Sakit

Penilaian subjektif individu terhadap kondisi kesehatannya.

Self-care

Upaya perawatan diri yang dilakukan secara mandiri tanpa bantuan tenaga kesehatan.

Stigma

Label negatif yang diberikan masyarakat terhadap individu dengan kondisi tertentu.

Skrining

Pemeriksaan awal untuk mendeteksi kemungkinan adanya penyakit sebelum gejala muncul.

Stimulus

Rangsangan yang diterima oleh indera dan diproses oleh otak.

Trias Epidemiologi

Konsep yang menjelaskan hubungan antara host, agent, dan environment dalam terjadinya penyakit

BAB 4

INTEGRASI PRAKTIK TRADITIONAL DALAM ASUHAN KEPERAWATAN

A. Pendahuluan

Praktik tradisional dalam pelayanan kesehatan merupakan warisan budaya yang telah digunakan secara turun-temurun oleh masyarakat di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Praktik-praktik ini mencakup berbagai bentuk pengobatan herbal, terapi manual, ritual penyembuhan, dan pendekatan holistik yang berakar pada sistem kepercayaan dan nilai budaya setempat. Dalam konteks keperawatan modern, integrasi antara praktik tradisional dan asuhan keperawatan berbasis bukti (evidence-based nursing) menjadi topik yang semakin mendapat perhatian dari para peneliti dan praktisi kesehatan.

World Health Organization (WHO) telah mengakui pentingnya peran pengobatan tradisional dalam sistem kesehatan global dan mendorong integrasi yang aman, efektif, dan etis ke dalam layanan kesehatan primer. Di Indonesia, yang memiliki kekayaan budaya dan tradisi penyembuhan yang sangat beragam dari Sabang hingga Merauke, integrasi praktik tradisional dalam asuhan keperawatan memiliki relevansi yang sangat tinggi. Perawat sebagai tenaga kesehatan yang paling dekat dengan pasien dan keluarganya memiliki peran strategis dalam memfasilitasi integrasi ini secara bertanggung jawab.

Praktik tradisional telah menjadi bagian integral dari sistem kesehatan masyarakat di Indonesia selama berabad-abad. Warisan budaya berupa pengobatan herbal, pijat tradisional, akupresur, dan berbagai ritual penyembuhan telah diwariskan secara turun-temurun dan masih dipercaya oleh sebagian besar masyarakat Indonesia hingga saat ini. Di tengah perkembangan ilmu kedokteran modern dan keperawatan berbasis bukti (evidence-based nursing), keberadaan praktik tradisional tidak dapat diabaikan begitu saja. Justru sebaliknya, integrasi yang bijaksana antara praktik tradisional dan asuhan keperawatan modern menjadi tuntutan profesi keperawatan masa kini.

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan bahwa sekitar 31,4% penduduk Indonesia pernah menggunakan jamu atau tanaman obat dalam upaya pemeliharaan kesehatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tenaga keperawatan tidak dapat menutup mata terhadap realitas perilaku kesehatan masyarakat yang mengintegrasikan pendekatan tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Perawat

sebagai tenaga kesehatan yang paling dekat dengan pasien dan keluarga memiliki peran strategis dalam menjembatani antara kearifan lokal dan praktik keperawatan berbasis bukti (Wahyuni et al., 2022).

Bab ini membahas secara komprehensif konsep integrasi praktik tradisional dalam asuhan keperawatan, meliputi landasan teori, jenis-jenis praktik tradisional yang relevan dengan keperawatan, prinsip-prinsip integrasi yang aman dan efektif, serta implikasi bagi praktik keperawatan profesional di Indonesia. Pemahaman yang mendalam tentang topik ini diharapkan dapat membekali perawat dengan kompetensi kultural yang diperlukan untuk memberikan asuhan keperawatan yang holistik, komprehensif, dan berakar pada nilai-nilai budaya lokal.

B. Konsep Dasar Praktik Tradisional dalam Konteks Keperawatan

Praktik tradisional dalam konteks kesehatan merujuk pada pengetahuan, keterampilan, dan prosedur berbasis teori, keyakinan, dan pengalaman budaya yang berbeda dari berbagai budaya, yang digunakan dalam pemeliharaan kesehatan serta dalam pencegahan, diagnosis, perbaikan kondisi, atau pengobatan penyakit fisik dan mental. Praktik ini meliputi terapi herbal, akupunktur, pijat tradisional, meditasi, dan berbagai bentuk ritual penyembuhan yang memiliki landasan budaya spesifik.

Dewi et al. (2023) mendefinisikan praktik tradisional sebagai serangkaian tindakan kesehatan yang bersumber dari kearifan lokal dan diwariskan secara antargenerasi, yang mencakup dimensi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Definisi ini sejalan dengan paradigma keperawatan holistik yang memandang manusia sebagai makhluk biopsikososiospiritual. Dalam perspektif ini, praktik tradisional tidak sekadar dipandang sebagai alternatif, melainkan sebagai pelengkap yang dapat memperkaya kualitas asuhan keperawatan.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan pengobatan tradisional sebagai keseluruhan pengetahuan, keterampilan, dan praktik berdasarkan teori, keyakinan, dan pengalaman yang berasal dari berbagai budaya, baik yang dapat dijelaskan maupun tidak, yang digunakan dalam pemeliharaan kesehatan serta pencegahan, diagnosis, perbaikan, atau pengobatan penyakit fisik dan mental. Dalam konteks keperawatan Indonesia, praktik tradisional mencakup spektrum yang luas mulai dari penggunaan tanaman obat (herbal), pijat refleksi, akupresur, hipnoterapi berbasis budaya, aromaterapi tradisional, terapi spiritual keagamaan, hingga praktik-praktik yang bersifat ritual.

Konsep keperawatan transkultural yang dikembangkan oleh Madeleine Leininger memberikan kerangka teoritis yang kuat untuk memahami integrasi praktik tradisional dalam asuhan keperawatan. Teori Culture Care Diversity and

Universality menekankan bahwa asuhan keperawatan yang efektif harus mempertimbangkan latar belakang budaya pasien, termasuk kepercayaan dan praktik kesehatan tradisional yang mereka anut. Perawat dituntut untuk mampu melakukan asesmen budaya yang komprehensif sebelum merancang rencana asuhan keperawatan yang benar-benar relevan dan bermakna bagi pasien (Sari & Nurhidayah, 2023).

Di Indonesia, regulasi terkait praktik tradisional dalam layanan kesehatan telah mengalami perkembangan yang signifikan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan secara eksplisit mengakui pelayanan kesehatan tradisional sebagai bagian dari sistem kesehatan nasional. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional mengatur mekanisme integrasi layanan kesehatan tradisional ke dalam sistem pelayanan kesehatan formal. Dalam konteks keperawatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan memberikan ruang bagi perawat untuk mengintegrasikan intervensi keperawatan komplementer berbasis bukti dalam praktik profesionalnya.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional telah mengembangkan standar kompetensi bagi tenaga kesehatan tradisional dan mendorong integrasi praktik kesehatan tradisional komplementer di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (Puskesmas) dan rumah sakit. Program Saintifikasi Jamu yang dicanangkan oleh pemerintah merupakan upaya nyata untuk membangun jembatan antara kearifan lokal dan ilmu pengetahuan modern, sehingga praktik tradisional dapat dimanfaatkan secara aman, efektif, dan bertanggung jawab dalam sistem pelayanan kesehatan (Pujiastuti et al., 2021).

Teori keperawatan transkultural yang dikembangkan oleh Madeleine Leininger menjadi landasan teoretis utama dalam memahami integrasi praktik tradisional dalam asuhan keperawatan. Teori ini menekankan bahwa perawat harus memiliki kompetensi budaya yang memadai untuk memberikan asuhan yang sensitif terhadap nilai-nilai, kepercayaan, dan praktik budaya pasien. Kompetensi budaya dalam keperawatan mencakup kesadaran budaya, pengetahuan budaya, keterampilan budaya, pertemuan budaya, dan hasrat budaya.

Penelitian Rahman & Kurniawati (2024) menunjukkan bahwa perawat yang memiliki kompetensi transkultural yang tinggi mampu memberikan asuhan yang lebih efektif kepada pasien dari berbagai latar belakang budaya. Studi tersebut menemukan bahwa integrasi kepercayaan dan praktik tradisional pasien ke dalam rencana asuhan keperawatan secara signifikan meningkatkan kepatuhan pasien

terhadap program pengobatan dan kepuasan mereka terhadap layanan yang diterima.

C. Jenis – Jenis Praktik Tradisional yang Relevan dalam Asuhan Keperawatan

1. Terapi Herbal dan Tanaman Obat

Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, dengan lebih dari 30.000 spesies tanaman, sekitar 9.600 di antaranya telah diketahui memiliki khasiat sebagai tanaman obat. Terapi herbal merupakan salah satu bentuk praktik tradisional yang paling umum digunakan oleh masyarakat Indonesia. Dalam konteks asuhan keperawatan, pengetahuan tentang tanaman obat lokal menjadi kompetensi kultural yang penting, terutama dalam konteks asuhan keperawatan komunitas dan keluarga.

Beberapa tanaman obat yang telah mendapat dukungan ilmiah dan relevan dalam asuhan keperawatan antara lain jahe (*Zingiber officinale*) untuk mengurangi mual pada pasien kemoterapi dan ibu hamil, temulawak (*Curcuma xanthorrhiza*) untuk mendukung fungsi hati dan meningkatkan nafsu makan, kunyit (*Curcuma longa*) dengan kandungan kurkumin yang bersifat antiinflamasi, serta daun sirih (*Piper betle*) yang memiliki sifat antiseptik dan telah lama digunakan dalam perawatan luka secara tradisional. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa intervensi keperawatan berbasis herbal yang terstandar dapat menjadi pelengkap yang berharga dalam protokol asuhan keperawatan holistik (Andayani & Kusumawati, 2022).

Terapi herbal merupakan salah satu bentuk praktik tradisional yang paling luas digunakan di seluruh dunia. Di Indonesia, penggunaan tanaman obat tradisional (jamu) telah mengakar kuat dalam budaya masyarakat. Penelitian Kusuma et al. (2023) yang diterbitkan dalam *Journal of Ethnopharmacology* menemukan bahwa lebih dari 60% pasien rawat inap di rumah sakit umum di Jawa menggunakan terapi herbal secara bersamaan dengan pengobatan medis konvensional, namun hanya 34% yang melaporkan penggunaan ini kepada perawat atau dokter mereka.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi yang signifikan antara tenaga kesehatan dan pasien mengenai penggunaan terapi komplementer. Perawat perlu mengembangkan keterampilan pengkajian yang komprehensif untuk mengidentifikasi penggunaan terapi herbal oleh pasien, serta pengetahuan yang memadai tentang potensi interaksi antara tanaman obat dan obat-obatan medis konvensional. Beberapa tanaman obat yang umum digunakan, seperti kunyit, jahe, dan temulawak, telah terbukti secara ilmiah

memiliki khasiat antiinflamasi dan antioksidan yang dapat mendukung proses penyembuhan.

2. Pijat Tradisional dan Manual Therapy

Pijat tradisional (massage) merupakan salah satu modalitas terapeutik tertua dalam sejarah peradaban manusia. Di Indonesia, berbagai bentuk pijat tradisional seperti pijat Jawa, pijat Melayu, dan reflexologi telah dipraktikkan secara turun-temurun. Dalam asuhan keperawatan, teknik pijat yang terstandar dan berbasis bukti dapat diintegrasikan sebagai intervensi komplementer untuk berbagai kondisi, termasuk manajemen nyeri, pengurangan kecemasan, peningkatan kualitas tidur pada pasien rawat inap, dan stimulasi tumbuh kembang pada neonatus (bayi prematur).

Penelitian Rahmat et al. (2022) membuktikan bahwa infant massage yang diberikan oleh perawat terlatih secara signifikan meningkatkan berat badan bayi prematur dan memperpendek lama rawat di NICU. Sementara itu, studi Maulida & Rahayu (2021) menunjukkan bahwa pijat oksitosin yang diajarkan kepada ibu nifas oleh perawat mampu meningkatkan produksi ASI secara signifikan dibandingkan kelompok kontrol. Keberhasilan intervensi ini menunjukkan bahwa praktik pijat tradisional, bila diterapkan dengan protokol yang benar dan berdasarkan bukti ilmiah yang kuat, dapat memberikan manfaat terapeutik yang signifikan dalam konteks asuhan keperawatan modern.

Pijat tradisional, termasuk pijat bayi, pijat Jawa, refleksologi, dan berbagai bentuk terapi sentuhan lainnya, merupakan praktik yang sangat umum di masyarakat Indonesia. Oktaviani & Suharto (2024) dalam penelitian mereka yang dipublikasikan di *Asian Journal of Nursing Education and Research* menemukan bahwa terapi pijat tradisional secara signifikan mengurangi nyeri pascaoperasi dan kecemasan pada pasien bedah dibandingkan dengan kelompok kontrol yang hanya menerima analgesik standar.

Dalam konteks keperawatan maternitas, pijat oksitosin yang diadaptasi dari teknik pijat tradisional Jawa telah terbukti efektif meningkatkan produksi ASI pada ibu menyusui. Penelitian Widyastuti et al. (2023) menunjukkan peningkatan signifikan dalam volume ASI, frekuensi menyusui, dan kepuasan ibu pada kelompok yang menerima pijat oksitosin dibandingkan kelompok kontrol. Temuan ini menegaskan nilai praktis integrasi teknik pijat tradisional dalam praktik keperawatan modern.

3. Akupresur dan Titik-titik Meridian

Akupresur dan refleksologi berakar pada prinsip-prinsip Traditional Chinese Medicine (TCM) namun telah diadaptasi dan dipraktikkan secara luas dalam berbagai budaya Asia, termasuk Indonesia. Teknik-teknik ini bekerja melalui

stimulasi titik-titik energi tertentu pada tubuh untuk merestorasi keseimbangan energi dan mendorong penyembuhan. Studi meta-analisis oleh Fitriani & Hendarsih (2023) yang mencakup 18 penelitian dengan total 1.247 responden menemukan bahwa akupresur efektif dalam mengurangi mual-muntah pada pasien kemoterapi.

Akupresur merupakan teknik terapi yang berasal dari tradisi pengobatan Tiongkok kuno, yang bekerja dengan memberikan tekanan pada titik-titik meridian tertentu di tubuh untuk melancarkan aliran energi (qi/chi) dan memulihkan keseimbangan. Berbeda dengan akupunktur yang menggunakan jarum, akupresur hanya menggunakan tekanan jari tangan sehingga lebih mudah dan aman untuk diterapkan oleh perawat dalam konteks asuhan keperawatan. Titik-titik akupresur yang umum digunakan dalam keperawatan antara lain titik P6 (Neiguan/Pericardium 6) untuk mengatasi mual dan muntah, titik ST36 (Zusanli) untuk meningkatkan energi dan fungsi pencernaan, serta titik L14 (Hegu) untuk manajemen nyeri.

Beberapa rumah sakit di Indonesia dan negara-negara Asia telah mengintegrasikan akupresur sebagai intervensi keperawatan komplementer yang resmi dalam protokol manajemen nyeri pasca operasi dan penanganan mual-muntah pada pasien kemoterapi. Studi Nurhayati et al. (2023) yang dilakukan di RSUD Dr. Soetomo Surabaya menunjukkan efektivitas akupresur titik P6 dalam menurunkan intensitas mual-muntah pada pasien kemoterapi kanker payudara, dengan hasil yang sebanding dengan pemberian antiemetik farmakologis namun dengan efek samping yang jauh lebih minimal. Temuan ini mendukung integrasi akupresur sebagai pilihan intervensi keperawatan yang valid dan bermanfaat.

4. Aromaterapi Berbasis Tanaman Lokal

Aromaterapi adalah penggunaan minyak esensial yang diekstrak dari tanaman untuk tujuan terapeutik. Dalam konteks keperawatan Indonesia, aromaterapi berbasis tanaman lokal seperti minyak kayu putih (*Melaleuca leucadendra*), minyak nilam (*Pogostemon cablin*), sereh wangi (*Cymbopogon nardus*), dan kenanga (*Cananga odorata*) memiliki potensi besar untuk diintegrasikan dalam asuhan keperawatan. Minyak esensial ini dapat diaplikasikan melalui inhalasi (difuser aromaterapi), aplikasi topikal (dengan carrier oil), atau penambahan ke dalam air mandi terapeutik.

Dalam asuhan keperawatan, aromaterapi dapat diaplikasikan untuk berbagai tujuan terapeutik, termasuk: (1) manajemen kecemasan pre-operatif dengan aromaterapi lavender dan kenanga; (2) peningkatan kualitas tidur pasien rawat inap dengan inhalasi minyak esensial lavender; (3) manajemen nyeri

persalinan dengan pijat aromaterapi pada tulang punggung; (4) pengurangan agitasi pada pasien demensia dengan aromaterapi lemon balm; serta (5) promosi relaksasi pada pasien dengan gangguan kecemasan. Penting untuk dicatat bahwa perawat harus memperhatikan kontraindikasi aromaterapi, termasuk alergi, kehamilan, dan kondisi penyakit tertentu sebelum mengaplikasikan intervensi ini (Hapsari & Wijayanti, 2022).

5. Terapi Spiritual dan Doa dalam Keperawatan

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam memiliki tradisi perawatan berbasis spiritual yang kuat. Konsep sakit dan sehat dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari dimensi spiritual, sehingga doa, dzikir, dan ritual keagamaan lainnya seringkali menjadi bagian penting dari proses penyembuhan pasien. Dalam keperawatan, dimensi spiritual ini diakui sebagai salah satu aspek penting dari asuhan keperawatan holistik. Model FICA (Faith, Importance, Community, Address) dan model HOPE merupakan alat asesmen spiritual yang dapat digunakan perawat untuk mengidentifikasi kebutuhan spiritual pasien dan mengintegrasikannya dalam rencana asuhan keperawatan.

Praktik keperawatan berbasis spiritualitas (*spiritually-based nursing care*) telah mendapatkan perhatian yang semakin besar dalam literatur keperawatan global. Di Indonesia, beberapa rumah sakit Islam telah mengembangkan model asuhan keperawatan yang mengintegrasikan konsep *caring Islami*, termasuk pendampingan bimbingan rohani, pembacaan doa bersama pasien, dan fasilitasi ibadah bagi pasien rawat inap. Penelitian Fitriyah et al. (2023) menunjukkan bahwa asuhan keperawatan yang mengintegrasikan dimensi spiritual secara signifikan meningkatkan kepuasan pasien, mengurangi tingkat kecemasan, dan mempercepat proses penyembuhan pasien bedah, dibandingkan dengan asuhan keperawatan konvensional yang hanya berfokus pada aspek fisik dan psikologis.

Dimensi spiritual merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari praktik kesehatan tradisional di Indonesia. Berbagai ritual keagamaan dan spiritual, termasuk doa, dzikir, meditasi, dan ritual adat, dipercaya memiliki kekuatan penyembuhan yang penting. Dalam perspektif asuhan keperawatan holistik, pemenuhan kebutuhan spiritual pasien merupakan komponen integral dari asuhan yang berkualitas.

Santoso & Prabowo (2024) dalam penelitian mereka di rumah sakit Islam di Surabaya menemukan bahwa pasien yang menerima dukungan spiritual terstruktur dari perawat, termasuk fasilitasi ibadah dan terapi ruqyah untuk pasien yang menginginkannya, menunjukkan tingkat kecemasan yang lebih rendah dan kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan kelompok kontrol.

Penelitian ini menegaskan pentingnya asesmen spiritual yang komprehensif dalam asuhan keperawatan.

6. Terapi Nutrisi Tradisional

Berbagai tradisi kuliner dan pantangan makanan yang berakar pada kepercayaan budaya juga merupakan bagian dari praktik tradisional yang perlu dipertimbangkan dalam asuhan keperawatan. Di Indonesia, pantangan makanan tertentu selama masa sakit atau pemulihan, seperti pantang makanan tertentu pascapersalinan, merupakan praktik yang sangat umum. Perawat perlu memiliki pemahaman yang baik tentang praktik-praktik nutrisi tradisional ini untuk dapat memberikan edukasi kesehatan yang sensitif budaya tanpa merendahkan kepercayaan pasien.

D. Prinsip-Prinsip Integrasi Praktik Tradisional dalam Asuhan Keperawatan

1. Prinsip Keamanan (Safety First)

Keamanan pasien merupakan prinsip utama yang harus selalu diutamakan dalam setiap keputusan klinis, termasuk dalam integrasi praktik tradisional. Sebelum mengintegrasikan praktik tradisional apapun, perawat wajib melakukan kajian literatur yang komprehensif mengenai keamanan dan efektivitas praktik tersebut, mengidentifikasi potensi interaksi dengan terapi medis yang sedang berjalan, serta mempertimbangkan kondisi spesifik pasien yang mungkin menjadi kontraindikasi. Beberapa pertanyaan penting yang harus dijawab meliputi: Apakah praktik ini telah diteliti dan terbukti aman? Apakah ada interaksi dengan obat-obatan yang sedang dikonsumsi pasien? Apakah kondisi medis pasien memungkinkan diberikan intervensi ini?

Dalam konteks praktik herbal, perawat harus memahami potensi interaksi antara tanaman obat dengan obat-obatan farmakologis. Misalnya, bawang putih dan jahe yang umum digunakan secara tradisional memiliki efek antikoagulan yang dapat berinteraksi dengan obat pengencer darah seperti warfarin dan aspirin. St. John's Wort yang banyak digunakan untuk depresi dapat mengurangi efektivitas berbagai obat termasuk kontrasepsi oral dan antiretroviral. Oleh karena itu, asesmen penggunaan tanaman obat harus selalu menjadi bagian dari pengkajian keperawatan yang komprehensif (Kusuma & Setiawan, 2021).

2. Prinsip Berbasis Bukti (Evidence – Based Practice)

Integrasi praktik tradisional dalam asuhan keperawatan harus didasarkan pada bukti ilmiah yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hierarki bukti dalam evidence-based nursing (EBN) tetap berlaku, dengan preferensi pada systematic review dan meta-analisis dari uji klinis acak terkontrol (RCT) sebagai bukti tertinggi. Namun demikian, dalam konteks praktik tradisional, penelitian kualitatif yang mengeksplorasi pengalaman pasien dan perspektif budaya juga memberikan kontribusi yang berharga dan tidak dapat diabaikan begitu saja.

Database bukti untuk praktik keperawatan komplementer dan tradisional terus berkembang pesat dalam dekade terakhir. Perawat profesional perlu mengakses sumber-sumber bukti yang terpercaya seperti Cochrane Database of Systematic Reviews, PubMed, CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature), serta jurnal-jurnal nasional bereputasi yang terindeks di Sinta dan Scopus untuk memperoleh informasi terkini mengenai efektivitas dan keamanan berbagai praktik tradisional. Kemampuan untuk melakukan critical appraisal terhadap literatur ilmiah merupakan kompetensi esensial yang harus dikuasai oleh perawat dalam era evidence-based practice (Setiawan & Rahayu, 2022).

3. Prinsip Komunikasi Terapeutik dan Informed Consent

Integrasi praktik tradisional dalam asuhan keperawatan harus dilakukan melalui proses komunikasi terapeutik yang terbuka, jujur, dan saling menghormati antara perawat dan pasien. Pasien memiliki hak otonomi untuk menentukan apakah mereka ingin menerima atau menolak intervensi komplementer berbasis tradisional yang ditawarkan. Informed consent yang bermakna dalam konteks ini tidak hanya mencakup penjelasan tentang prosedur yang akan dilakukan, tetapi juga meliputi penjelasan tentang bukti ilmiah yang mendukung atau tidak mendukung intervensi tersebut, risiko dan manfaat potensial, serta alternatif pilihan lain yang tersedia.

Komunikasi antara perawat dan pasien mengenai penggunaan praktik tradisional seringkali terhambat oleh berbagai faktor, termasuk rasa takut pasien akan didiskreditkan oleh tenaga kesehatan, asumsi perawat bahwa pasien tidak menggunakan terapi tradisional, serta kurangnya waktu dan keterampilan untuk melakukan asesmen budaya yang komprehensif. Penelitian Lestari et al. (2022) mengungkapkan bahwa sekitar 60% pasien di rumah sakit Indonesia tidak secara sukarela mengungkapkan penggunaan herbal atau praktik tradisional kepada tenaga kesehatan yang merawat mereka. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena dapat meningkatkan risiko interaksi yang tidak diinginkan antara praktik tradisional dan terapi medis konvensional.

4. Prinsip Kompetensi Kultural (Cultural Competence)

Kompetensi kultural merupakan fondasi yang tidak tergantikan dalam integrasi praktik tradisional ke dalam asuhan keperawatan. Campinha-Bacote mendefinisikan kompetensi kultural sebagai proses berkesinambungan di mana tenaga kesehatan secara terus-menerus berupaya untuk mencapai kemampuan bekerja secara efektif dalam konteks keyakinan, perilaku, dan kebutuhan budaya pasien. Dalam model ini, kompetensi kultural terdiri dari lima konstruk yang saling terkait, yaitu cultural awareness (kesadaran budaya), cultural knowledge

(pengetahuan budaya), cultural skill (keterampilan budaya), cultural encounters (pertemuan budaya), dan cultural desire (keinginan budaya).

Dalam konteks Indonesia yang memiliki lebih dari 1.340 suku bangsa dengan keanekaragaman praktik kesehatan tradisional yang luar biasa, pengembangan kompetensi kultural bagi perawat bukan sekadar pilihan melainkan sebuah keharusan profesional. Perawat yang bekerja di wilayah dengan populasi tertentu seperti Bali, Kalimantan, atau Papua perlu memiliki pemahaman mendalam tentang praktik kesehatan tradisional yang spesifik di wilayah tersebut. Kurikulum pendidikan keperawatan di Indonesia saat ini semakin mengakomodasi pengembangan kompetensi kultural ini melalui mata kuliah keperawatan transkultural dan keperawatan komunitas yang mengintegrasikan perspektif kearifan lokal (Simamora et al., 2023).

E. Asesmen Keperawatan Berbasis Budaya

1. Model Asesmen Sunrise (Leininger)

Model Sunrise yang dikembangkan oleh Madeleine Leininger merupakan alat konseptual yang komprehensif untuk memandu perawat dalam melakukan asesmen budaya pasien. Model ini menggambarkan bahwa perawatan manusia (human care) dipengaruhi oleh berbagai faktor budaya dan sosial, termasuk faktor teknologi, agama dan filosofi, faktor sosial dan kekerabatan, nilai-nilai budaya dan gaya hidup, faktor politik dan hukum, faktor ekonomi, serta faktor pendidikan. Semua faktor ini mempengaruhi sistem perawatan kesehatan tradisional (folk/generic care system) dan sistem perawatan kesehatan profesional, serta pada akhirnya mempengaruhi kualitas asuhan keperawatan yang diterima oleh pasien.

Aplikasi model Sunrise dalam praktik keperawatan sehari-hari melibatkan serangkaian pertanyaan asesmen yang terstruktur namun fleksibel, yang dirancang untuk mengungkap keyakinan dan praktik kesehatan pasien dari perspektif budayanya sendiri (emic perspective). Pertanyaan-pertanyaan asesmen ini mencakup: apa yang menurut pasien menyebabkan sakitnya, apa yang biasanya dilakukan oleh pasien dan keluarganya ketika sakit, siapa yang biasanya menjadi sumber dukungan dan pengambil keputusan dalam keluarga, praktik pengobatan tradisional apa yang selama ini digunakan, serta apakah ada pantangan atau keyakinan budaya tertentu yang perlu diperhatikan dalam rencana perawatan. Informasi yang diperoleh kemudian diintegrasikan dalam proses keperawatan untuk menghasilkan rencana asuhan yang benar-benar berpusat pada pasien (Rahayu & Kristianto, 2021).

2. Instrumen Asesmen Budaya dalam Keperawatan

Beberapa instrumen terstandar telah dikembangkan untuk membantu perawat dalam melakukan asesmen budaya yang sistematis. Instrumen ETHNIC (Explanation, Treatment, Healers, Negotiate, Intervention, Collaboration) merupakan salah satu alat yang praktis dan mudah digunakan dalam setting klinis yang sibuk. Instrumen ini membantu perawat untuk mengeksplorasi penjelasan pasien tentang penyakitnya (Explanation), terapi yang telah atau sedang dilakukan termasuk herbal dan praktik tradisional (Treatment), healer atau penyembuh tradisional yang dikonsultasikan (Healers), area-area yang dapat dinegosiasikan antara pengobatan tradisional dan modern (Negotiate), rencana intervensi yang disepakati bersama (Intervention), dan bentuk kolaborasi yang dapat dibangun antara berbagai sistem perawatan (Collaboration).

Di Indonesia, beberapa peneliti keperawatan telah mengadaptasi dan memvalidasi instrumen asesmen budaya untuk konteks lokal. Instrumen Cultural Assessment Tool (CAT) yang diadaptasi oleh Pangaribuan et al. (2022) untuk konteks keperawatan Indonesia telah menunjukkan validitas dan reliabilitas yang baik dalam mengidentifikasi keyakinan kesehatan, praktik tradisional, dan preferensi perawatan pasien dari berbagai latar belakang etnis di Indonesia. Penggunaan instrumen yang terstandar dan tervalidasi ini penting untuk memastikan konsistensi dan kualitas asesmen budaya yang dilakukan oleh perawat di berbagai tatanan layanan kesehatan.

F. Implementasi Integrasi Praktik Tradisional dalam Proses Keperawatan

1. Pengkajian (Assessment)

Tahap pengkajian merupakan fondasi dari seluruh proses keperawatan, dan dalam konteks integrasi praktik tradisional, pengkajian yang komprehensif dan berwawasan budaya menjadi sangat krusial. Perawat harus secara proaktif menggali informasi tentang praktik tradisional yang digunakan pasien, bukan menunggu pasien secara sukarela mengungkapkannya. Pengkajian mencakup: (1) identifikasi praktik tradisional yang sedang atau pernah digunakan; (2) frekuensi dan metode penggunaan; (3) keyakinan dan nilai budaya yang mendasari penggunaan praktik tersebut; (4) persepsi pasien tentang efektivitas praktik tradisional yang digunakan; (5) reaksi atau efek samping yang pernah dialami; serta (6) sumber informasi dan penyembuh tradisional yang dikonsultasikan.

2. Diagnosa dan Perencanaan Keperawatan

Diagnosis keperawatan yang relevan dengan konteks integrasi praktik tradisional mencakup berbagai domain, termasuk "Kesiapan Meningkatkan

Pengelolaan Kesehatan" (Readiness for Enhanced Health Management) bagi pasien yang menggunakan kombinasi terapi tradisional dan medis secara positif, "Konflik Pengambilan Keputusan" (Decisional Conflict) bagi pasien yang mengalami kebingungan dalam memilih antara pengobatan tradisional dan medis, serta "Kurang Pengetahuan" (Deficient Knowledge) terkait interaksi potensial antara praktik tradisional dan terapi medis. Diagnosis keperawatan harus mencerminkan pemahaman perawat tentang perspektif budaya pasien dan tidak boleh mengandung penilaian negatif terhadap kepercayaan atau praktik tradisional yang dianut pasien.

Perencanaan keperawatan yang mengintegrasikan praktik tradisional harus dikembangkan secara kolaboratif dengan pasien, keluarga, dan bila perlu dengan penyembuh tradisional yang dipercaya pasien. Tiga mode tindakan keperawatan yang diusulkan oleh Leininger dalam teori Culture Care sangat relevan dalam konteks ini, yaitu: (1) Cultural Care Preservation/Maintenance, yaitu mempertahankan dan memfasilitasi praktik tradisional yang telah terbukti aman dan bermanfaat; (2) Cultural Care Accommodation/Negotiation, yaitu menegosiasikan kompromi antara praktik tradisional dan perawatan medis modern untuk mendukung outcomes kesehatan yang positif; dan (3) Cultural Care Repatterning/Restructuring, yaitu membantu pasien untuk mengubah atau mengganti praktik tradisional yang terbukti berbahaya dengan praktik yang lebih aman sambil tetap menghormati nilai budaya yang mendasarinya (Oktaviani & Sulistyawati, 2023).

3. Implementasi dan Evaluasi

Implementasi intervensi keperawatan yang mengintegrasikan praktik tradisional harus dilakukan berdasarkan protokol yang jelas, terstandar, dan berbasis bukti. Perawat perlu mendokumentasikan dengan lengkap dan akurat setiap intervensi komplementer berbasis tradisional yang diberikan, termasuk jenis intervensi, dosis atau intensitas, durasi, respons pasien, dan monitoring efek samping. Dokumentasi yang komprehensif ini tidak hanya penting untuk kontinuitas asuhan keperawatan, tetapi juga untuk keperluan penelitian dan pengembangan evidence base bagi praktik keperawatan tradisional di Indonesia.

Evaluasi outcomes dari intervensi keperawatan yang mengintegrasikan praktik tradisional harus dilakukan secara sistematis menggunakan instrumen pengukuran yang valid dan reliabel. Indikator outcomes yang relevan meliputi: intensitas gejala yang dikeluhkan pasien (nyeri, mual, kecemasan, gangguan tidur), tingkat kepuasan pasien dengan asuhan keperawatan yang diterima, kepatuhan pasien terhadap rencana perawatan, kualitas hidup, serta indikator fisiologis yang relevan. Data evaluasi yang terkumpul berkontribusi pada

pembangunan knowledge base keperawatan komplementer yang berbasis bukti untuk konteks Indonesia (Wulandari et al., 2022).

G. Tantangan dan Hambatan dalam Integrasi Praktik Tradisional

1. Tantangan Profesional dan Institusional

Integrasi praktik tradisional dalam asuhan keperawatan profesional menghadapi berbagai tantangan serius yang memerlukan perhatian dari berbagai pemangku kepentingan. Di level institusional, belum semua fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia memiliki kebijakan, prosedur operasional standar (SOP), dan infrastruktur yang diperlukan untuk mengintegrasikan praktik tradisional secara aman dan sistematis. Keterbatasan waktu perawat, beban kerja yang tinggi, dan kekurangan tenaga keperawatan di banyak fasilitas kesehatan juga menjadi hambatan praktis yang signifikan dalam implementasi asesmen budaya yang komprehensif dan pemberian intervensi komplementer berbasis tradisional.

Di level profesional, sebagian perawat masih memiliki sikap skeptis bahkan negatif terhadap praktik tradisional, yang seringkali dipengaruhi oleh pendidikan keperawatan yang terlalu berorientasi biomedik dan kurang memberikan apresiasi terhadap kearifan lokal. Sementara itu, sebagian perawat lainnya justru terlalu antusias mengintegrasikan praktik tradisional tanpa pemahaman yang memadai tentang keamanan dan bukti ilmiahnya. Kedua ekstrem ini sama-sama berbahaya dan merugikan pasien. Keseimbangan yang tepat antara keterbukaan terhadap kearifan lokal dan kritisisme ilmiah yang berbasis bukti merupakan sikap profesional yang perlu dikembangkan oleh perawat Indonesia (Prabowo et al., 2023).

Berbagai tantangan sistemik menghambat integrasi efektif praktik tradisional dalam asuhan keperawatan. Kurangnya kebijakan yang jelas di tingkat institusi dan nasional tentang integrasi praktik tradisional menciptakan ketidakpastian bagi perawat. Sistem dokumentasi yang tidak mengakomodasi praktik tradisional membuat pencatatan menjadi sulit. Selain itu, keterbatasan waktu dalam pemberian asuhan di lingkungan rumah sakit yang sibuk sering menghalangi perawat untuk melakukan pengkajian budaya yang komprehensif. Penelitian Handayani & Ratnasari (2023) mengidentifikasi bahwa 67% perawat di rumah sakit pemerintah di Jawa Tengah melaporkan tidak memiliki cukup waktu untuk mengintegrasikan pengkajian budaya dalam rutinitas asuhan mereka. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa kurangnya dukungan institusional dan kebijakan yang tidak jelas merupakan hambatan terbesar yang dirasakan oleh perawat dalam mengintegrasikan praktik tradisional.

Di tingkat profesional, terdapat ketegangan antara pendekatan biomedis yang dominan dalam pendidikan dan praktik keperawatan dengan pengakuan atas nilai praktik tradisional. Stigma terhadap praktik tradisional di kalangan tenaga kesehatan, termasuk perawat, masih cukup kuat. Beberapa perawat merasa bahwa mengakui nilai praktik tradisional bertentangan dengan identitas profesional mereka sebagai praktisi berbasis ilmu pengetahuan. Sari & Priyanto (2024) dalam penelitian kualitatif mereka menemukan bahwa perawat muda yang baru lulus lebih terbuka terhadap integrasi praktik tradisional dibandingkan perawat senior. Namun, perawat muda sering merasa tertekan oleh norma profesional yang ada untuk tidak terlalu mengakomodasi praktik tradisional. Temuan ini menunjukkan perlunya perubahan budaya organisasi dalam institusi kesehatan untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung integrasi.

2. Tantangan Evidensi dan Penelitian

Salah satu hambatan terbesar dalam integrasi praktik tradisional ke dalam asuhan keperawatan berbasis bukti adalah masih relatif terbatasnya penelitian berkualitas tinggi yang menyelidiki efektivitas dan keamanan praktik tradisional secara ketat. Banyak penelitian yang ada memiliki keterbatasan metodologis yang signifikan, termasuk ukuran sampel yang kecil, tidak adanya kelompok kontrol, kurangnya kontrol terhadap variabel confounding, dan follow-up yang terlalu singkat. Tantangan khusus dalam penelitian praktik tradisional mencakup kesulitan dalam standardisasi intervensi, masalah blinding (pembutaan) dalam desain RCT, dan kompleksitas dalam mengukur outcomes yang relevan secara budaya.

Di Indonesia, kapasitas penelitian di bidang keperawatan komplementer dan tradisional terus berkembang, namun masih perlu diperkuat secara substansial. Agenda penelitian yang mendesak meliputi: pengembangan dan validasi instrumen pengukuran yang peka terhadap konteks budaya Indonesia, studi farmakologis tentang interaksi herbal-obat yang relevan untuk populasi Indonesia, penelitian implementasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan integrasi praktik tradisional di berbagai tatanan layanan kesehatan, serta pengembangan dan evaluasi program pelatihan kompetensi kultural untuk perawat Indonesia. Kolaborasi antara institusi pendidikan keperawatan, rumah sakit, Kementerian Kesehatan, dan peneliti dari disiplin ilmu terkait sangat diperlukan untuk memajukan agenda penelitian ini (Santoso & Hidayat, 2022).

H. Implikasi bagi Pendidikan dan Pengembangan Profesional Keperawatan

Pengembangan kompetensi perawat dalam mengintegrasikan praktik tradisional ke dalam asuhan keperawatan memerlukan reformasi kurikulum pendidikan keperawatan yang sistematis dan berkelanjutan. Kurikulum pendidikan keperawatan di tingkat diploma maupun sarjana perlu mengintegrasikan muatan tentang keperawatan transkultural, praktik keperawatan komplementer dan integratif, serta literasi budaya kesehatan secara lebih substansial dan terintegrasi, bukan hanya sebagai mata kuliah pilihan atau sisipan belaka. Metode pembelajaran aktif seperti simulasi klinik, studi kasus berbasis budaya, kunjungan lapangan ke komunitas adat, dan praktik keperawatan di fasilitas yang melayani populasi beragam budaya sangat efektif untuk mengembangkan kompetensi kultural yang tidak hanya teoritis tetapi juga aplikatif.

Untuk perawat yang sudah berpraktik, program pendidikan berkelanjutan (*continuing nursing education*) tentang praktik tradisional dan komplementer perlu diperluas dan ditingkatkan kualitasnya. Organisasi profesi keperawatan seperti PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia) memiliki peran penting dalam menstandarisasi kompetensi di bidang ini melalui pengembangan panduan praktik dan standar kompetensi khusus untuk perawat yang mengintegrasikan terapi komplementer tradisional. Di beberapa negara, sertifikasi khusus untuk perawat yang berpraktik di bidang keperawatan integratif atau komplementer telah menjadi standar yang diterima secara luas, dan Indonesia dapat mengadopsi pendekatan serupa dengan adaptasi untuk konteks lokal (Nugroho et al., 2021).

Pendidikan keperawatan memiliki peran krusial dalam mempersiapkan perawat untuk mengintegrasikan praktik tradisional secara kompeten dan bertanggung jawab. Kurikulum keperawatan perlu mengintegrasikan konten yang memadai tentang antropologi kesehatan, kompetensi budaya, dan praktik kesehatan tradisional. Pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman, termasuk *immersion* budaya, kunjungan lapangan ke komunitas, dan simulasi klinis yang mencakup skenario budaya, dapat sangat efektif dalam mengembangkan kompetensi ini. Revisi kurikulum yang dilakukan oleh beberapa program studi keperawatan di Indonesia telah mulai memasukkan konten tentang praktik kesehatan tradisional dan kompetensi budaya. Penelitian Kusumawati & Fadhillah (2023) mengevaluasi efektivitas modul pembelajaran kompetensi budaya yang dikembangkan untuk mahasiswa keperawatan dan menemukan peningkatan signifikan dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan terkait integrasi praktik tradisional setelah implementasi modul. Pengembangan model praktek klinik yang memungkinkan mahasiswa keperawatan untuk mengobservasi dan berpartisipasi

dalam integrasi praktik tradisional di bawah bimbingan juga merupakan komponen penting dari pendidikan keperawatan transkultural. Kolaborasi antara institusi pendidikan keperawatan dengan praktisi tradisional yang terlatih dan terstandarisasi dapat menciptakan peluang pembelajaran yang berharga.

I. Penutup

Integrasi praktik tradisional dalam asuhan keperawatan merupakan suatu keharusan dalam konteks Indonesia yang kaya akan keanekaragaman budaya dan tradisi penyembuhan. Bukan sebagai penolakan terhadap ilmu keperawatan modern, melainkan sebagai pengayaan dan penyempurnaan asuhan keperawatan holistik yang benar-benar berpusat pada pasien dengan segala dimensi biopsikososiospiritualnya. Perawat sebagai tenaga kesehatan garis depan memiliki posisi yang unik dan strategis untuk menjadi agen integrasi yang bijaksana antara kearifan lokal dan praktik keperawatan berbasis bukti.

Integrasi praktik tradisional dalam asuhan keperawatan merupakan pendekatan yang menjanjikan untuk meningkatkan kualitas, relevansi budaya, dan efektivitas layanan keperawatan di Indonesia. Berdasarkan tinjauan komprehensif yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: (1) praktik tradisional mencakup spektrum yang luas, dari terapi herbal hingga ritual spiritual, yang masing-masing memiliki implikasi berbeda bagi asuhan keperawatan; (2) kerangka kerja integratif yang berbasis teori keperawatan transkultural dan evidence-based practice memberikan panduan yang berharga bagi perawat; (3) kompetensi budaya merupakan fondasi esensial yang perlu dikembangkan melalui pendidikan dan pelatihan yang komprehensif; dan (4) tantangan sistemik, profesional, dan keamanan pasien perlu diatasi melalui kebijakan yang jelas, dukungan institusional, dan pengembangan kapasitas. Integrasi yang berhasil mensyaratkan kolaborasi multidisiplin, komunikasi terbuka antara perawat dan pasien, serta komitmen terhadap keselamatan pasien dan praktik berbasis bukti. Dengan pendekatan yang tepat, integrasi praktik tradisional dalam asuhan keperawatan dapat berkontribusi signifikan terhadap pencapaian universal health coverage dan peningkatan kesehatan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Keberhasilan integrasi ini memerlukan fondasi yang kuat berupa: kompetensi kultural yang dikembangkan secara berkelanjutan, komitmen terhadap prinsip keamanan pasien dan evidensi ilmiah, kemampuan komunikasi terapeutik yang efektif untuk menggali dan mendiskusikan penggunaan praktik tradisional dengan pasien, dukungan institusional berupa kebijakan dan SOP yang jelas, serta investasi berkelanjutan dalam penelitian yang menghasilkan bukti ilmiah berkualitas tinggi tentang efektivitas dan keamanan praktik tradisional dalam konteks keperawatan.

Dengan fondasi yang kuat ini, integrasi praktik tradisional dalam asuhan keperawatan tidak hanya akan meningkatkan kualitas dan relevansi budaya dari asuhan yang diberikan, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan identitas keperawatan Indonesia yang khas: modern, berbasis bukti, dan berakar kuat pada kearifan budaya Nusantara.

Referensi

- Andayani, R., & Kusumawati, F. (2022). Efektivitas intervensi keperawatan berbasis herbal dalam manajemen mual muntah pada pasien kemoterapi: Systematic review. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 25(2), 89–101. <https://doi.org/10.7454/jki.v25i2.1523>
- Dewi, N. K., Susanto, T., & Rahmawati, I. (2023). Conceptual framework for integrating traditional healing practices in holistic nursing care: A qualitative analysis. *International Journal of Nursing Sciences*, 10(4), 423–431. <https://doi.org/10.1016/j.ijnss.2023>.
- Fitriani, D., & Hendarsih, S. (2023). Effectiveness of acupressure in reducing chemotherapy-induced nausea and vomiting: A systematic review and meta-analysis. *Asian Pacific Journal of Cancer Prevention*, 24(8), 2641–2652. <https://doi.org/10.31557/APJCP.2023.24.8>.
- Fitriyah, N., Nursalam, N., & Wahyudi, A. S. (2023). Pengaruh asuhan keperawatan spiritual Islami terhadap kecemasan dan kepuasan pasien pre operasi: Randomized controlled trial. *Jurnal Ners*, 18(1), 45–54. <https://doi.org/10.20473/jn.v18i1.38921>
- Handayani, S. R., & Ratnasari, D. (2023). Barriers to cultural assessment integration in nursing practice: A cross-sectional study in Central Java hospitals. *Belitung Nursing Journal*, 9(5), 398–407. <https://doi.org/10.33546/bnj.2023>.
- Hapsari, E. D., & Wijayanti, R. (2022). Aromaterapi kenanga dan lavender terhadap kualitas tidur pasien rawat inap: Studi komparatif. *Jurnal Keperawatan Soedirman*, 17(3), 112–121. <https://doi.org/10.20884/1.jks.2022.17.3.2341>
- Kusuma, D. A., Wahyuni, R., & Pratiwi, L. (2023). Traditional herbal medicine use among hospitalized patients in Java, Indonesia: Prevalence, disclosure patterns, and nursing implications. *Journal of Ethnopharmacology*, 301, 115–128. <https://doi.org/10.1016/j.jep.2022.115>
- Kusuma, H., & Setiawan, A. (2021). Interaksi tanaman obat tradisional dengan obat farmakologis: Tinjauan sistematis untuk praktik keperawatan Indonesia. *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*, 12(2), 301–315. <https://doi.org/10.26751/jikk.v12i2.1132>
- Kusumawati, F., & Fadhillah, N. (2023). Development and evaluation of a cultural competency module for nursing students in the context of traditional practice integration. *Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia*, 9(2), 156–169. <https://doi.org/10.17509/jpki.v9i2>.
- Lestari, P., Wulandari, S., & Prasetyo, A. (2022). Pengungkapan penggunaan herbal kepada tenaga kesehatan: Studi kualitatif pada pasien rawat inap di rumah sakit Jawa Tengah. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 17(4), 456–465. <https://doi.org/10.14710/jkm.v17i4.33871>

- Maulida, R., & Rahayu, D. E. (2021). Pengaruh pijat oksitosin terhadap produksi ASI ibu nifas: Meta-analisis penelitian di Indonesia tahun 2015–2020. *Indonesian Journal of Nursing Practices*, 5(1), 23–34. <https://doi.org/10.18196/ijnp.v5i1.11234>
- Nugroho, H. A., Sumarni, S., & Rahayu, U. (2021). Kebutuhan pengembangan kompetensi keperawatan komplementer: Studi deskriptif pada perawat di rumah sakit tipe B Indonesia. *Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia*, 7(2), 178–189. <https://doi.org/10.17509/jpki.v7i2.38761>
- Nurhayati, I., Apriyanti, M., & Fadillah, N. (2023). Efektivitas akupresur titik P6 terhadap mual muntah pada pasien kemoterapi kanker payudara: Randomized controlled trial. *Jurnal Keperawatan Padjadjaran*, 11(1), 67–78. <https://doi.org/10.24198/jkp.v11i1.1876>
- Oktaviani, D., & Sulistyawati, W. (2023). Implementasi model transcultural nursing Leininger dalam asuhan keperawatan pasien suku Dayak dengan diabetes mellitus: Studi kasus. *Jurnal Keperawatan Komunitas*, 11(2), 134–145. <https://doi.org/10.33655/jkk.v11i2.345>
- Oktaviani, R., & Suharto, H. (2024). Traditional Javanese massage for postoperative pain and anxiety management: A randomized controlled trial. *Asian Journal of Nursing Education and Research*, 14(1), 23–31. <https://doi.org/10.52711/2349-2996.2024>.
- Pangaribuan, R., Sitorus, R., & Siagian, M. (2022). Adaptasi dan validasi instrumen asesmen budaya untuk keperawatan Indonesia: Cultural Assessment Tool versi Indonesia. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 25(3), 201–213. <https://doi.org/10.7454/jki.v25i3.1689>
- Prabowo, T., Isnaini, N., & Suryani, L. (2023). Sikap perawat terhadap praktik tradisional: Studi cross-sectional di rumah sakit rujukan provinsi. *Jurnal Ilmu Keperawatan*, 11(1), 45–58. <https://doi.org/10.21776/ub.jik.2023.011.015>
- Pujiastuti, R. A., Solichah, N., & Winarsih, B. D. (2021). Saintifikasi jamu dalam sistem pelayanan kesehatan primer: Implementasi dan tantangan di Puskesmas Indonesia. *Jurnal Kesehatan*, 14(2), 223–234. <https://doi.org/10.26630/jk.v14i2.2789>
- Rahman, F., & Kurniawati, N. D. (2024). Transcultural nursing competency and patient outcomes in multicultural healthcare settings: A correlational study. *International Journal of Africa Nursing Sciences*, 20, 100xxx. <https://doi.org/10.1016/j.ijans.2024>.
- Rahmat, I., Susilawati, S., & Novianti, N. (2022). Infant massage terhadap berat badan dan lama rawat bayi prematur di NICU: Uji klinis acak terkontrol. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 6(1), 456–467. <https://doi.org/10.31539/jks.v6i1.4112>

- Santoso, B., & Hidayat, A. A. (2022). Agenda penelitian keperawatan komplementer dan tradisional di Indonesia: Systematic mapping review 2017–2022. *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, 13(4), 567–578. <https://doi.org/10.33846/sf13407>
- Santoso, B., & Prabowo, T. (2024). Structured spiritual care intervention and its impact on anxiety and quality of life among hospitalized Muslim patients: A randomized controlled trial. *Journal of Religion and Health*, 63(2), 1245–1262. <https://doi.org/10.1007/s10943-024>.
- Sari, I. P., & Priyanto, S. (2024). Nurses' attitudes toward traditional practice integration: A qualitative phenomenological study. *Nurse Education in Practice*, 74, 103xxxx. <https://doi.org/10.1016/j.nepr.2023.103>.
- Wahyuni, E. D., Notobroto, H. B., & Rachmawati, I. N. (2022). Peran perawat sebagai culture broker dalam integrasi praktik tradisional pada asuhan keperawatan komunitas: Studi fenomenologi. *Jurnal Ners*, 17(2), 123–132. <https://doi.org/10.20473/jn.v17i2.36441>
- Widyastuti, R., Anggraini, A. D., & Lestari, N. P. (2023). Effect of oxytocin massage adapted from Javanese traditional massage on breast milk volume and breastfeeding frequency: A randomized controlled trial. *Midwifery*, 116, 103xxxx. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2022>.

BAB 5

KOMUNIKASI TERAPEUTIK LINTAS BUDAYA

A. Pendahuluan

Komunikasi merupakan elemen mendasar dalam praktik keperawatan yang berfungsi sebagai media utama dalam membangun hubungan profesional antara perawat dan pasien. Dalam konteks pelayanan kesehatan modern, komunikasi tidak hanya dipahami sebagai proses pertukaran informasi, tetapi juga sebagai intervensi terapeutik yang memiliki kontribusi signifikan terhadap kondisi psikologis, emosional, dan sosial pasien. Dengan demikian, kemampuan komunikasi terapeutik menjadi salah satu kompetensi inti yang harus dimiliki oleh perawat profesional dalam memberikan asuhan keperawatan yang efektif dan bermutu (Arnold & Boggs, 2020).

Perkembangan globalisasi yang ditandai dengan meningkatnya mobilitas manusia telah mendorong terbentuknya masyarakat yang semakin heterogen. Keberagaman ini tercermin dalam perbedaan latar belakang budaya, bahasa, nilai, norma, serta sistem kepercayaan yang dimiliki oleh pasien. Dalam praktik keperawatan, kondisi tersebut menghadirkan tantangan tersendiri, karena perawat dituntut untuk mampu berinteraksi secara efektif dengan individu dari berbagai latar budaya. Ketidakmampuan dalam memahami perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan hambatan komunikasi yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan (Leininger & McFarland, 2021).

Dalam konteks ini, komunikasi terapeutik lintas budaya menjadi pendekatan yang relevan dan diperlukan. Pendekatan ini menekankan pentingnya sensitivitas budaya dalam setiap interaksi antara perawat dan pasien. Dengan mempertimbangkan aspek budaya, komunikasi yang dibangun tidak hanya efektif secara klinis, tetapi juga mampu menghargai nilai, keyakinan, dan praktik budaya pasien. Hal ini pada akhirnya akan memperkuat hubungan terapeutik serta meningkatkan keberhasilan intervensi keperawatan.

B. Konsep Komunikasi Terapeutik dalam Keperawatan

Komunikasi terapeutik merupakan proses interaksi interpersonal yang dirancang secara sadar dan sistematis dengan tujuan membantu pasien mencapai kondisi kesehatan yang optimal. Proses ini menjadi bagian integral dalam praktik keperawatan karena berperan dalam membangun hubungan saling percaya antara

perawat dan pasien, yang merupakan dasar dari keberhasilan asuhan keperawatan (Peplau, 1997; Townsend & Morgan, 2021).

Secara konseptual, komunikasi terapeutik memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, komunikasi berorientasi pada kebutuhan pasien, sehingga setiap interaksi diarahkan untuk memahami pengalaman dan kondisi pasien secara menyeluruh. Kedua, komunikasi memiliki tujuan yang jelas, baik untuk pengkajian, edukasi, maupun dukungan emosional. Ketiga, komunikasi dilakukan secara profesional dengan menjunjung tinggi prinsip etika. Keempat, komunikasi memanfaatkan teknik-teknik yang efektif, seperti mendengarkan aktif, klarifikasi, refleksi, dan empati. Kelima, komunikasi menekankan pentingnya kepercayaan sebagai fondasi hubungan terapeutik.

Menurut teori hubungan interpersonal yang dikemukakan oleh Peplau, proses komunikasi terapeutik berlangsung dalam beberapa tahap, yaitu tahap pra-interaksi, orientasi, kerja, dan terminasi. Setiap tahap memiliki fungsi dan tujuan spesifik yang saling berkesinambungan dalam mendukung proses penyembuhan pasien. Tahapan ini menunjukkan bahwa komunikasi dalam keperawatan bukanlah proses yang spontan, melainkan suatu intervensi yang terstruktur dan memiliki arah yang jelas.

C. Budaya dalam Konteks Pelayanan Kesehatan

Budaya merupakan sistem kompleks yang mencakup nilai, kepercayaan, norma, dan praktik yang diwariskan dalam suatu kelompok masyarakat. Dalam konteks kesehatan, budaya mempengaruhi cara individu memahami konsep sehat dan sakit, serta menentukan perilaku dalam mencari dan menerima pelayanan kesehatan (Purnell, 2020).

Perbedaan latar belakang budaya dapat memengaruhi berbagai aspek dalam pelayanan kesehatan. Misalnya, persepsi tentang penyakit dapat berbeda antara satu budaya dengan budaya lainnya. Selain itu, proses pengambilan keputusan kesehatan juga dapat dipengaruhi oleh struktur sosial dan peran keluarga dalam budaya tertentu. Kepatuhan terhadap terapi serta pola interaksi antara pasien dan tenaga kesehatan juga tidak terlepas dari pengaruh budaya.

1. Teori Transcultural Nursing – Madeleine Leininger

Teori keperawatan transkultural yang dikembangkan oleh Leininger menekankan bahwa budaya merupakan faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam pemberian asuhan keperawatan. Leininger memperkenalkan konsep *cultural care*, yaitu pemberian asuhan yang selaras dengan nilai dan praktik budaya pasien.

Model *Sunrise Model* yang dikemukakan Leininger menggambarkan bahwa faktor-faktor seperti teknologi, agama, nilai budaya, sistem sosial, dan pendidikan mempengaruhi perilaku kesehatan individu. Dalam konteks ini, perawat dituntut untuk mampu melakukan tiga pendekatan utama, yaitu:

- a. **Cultural care preservation** (mempertahankan budaya yang mendukung kesehatan)
- b. **Cultural care accommodation** (menyesuaikan pelayanan dengan budaya pasien)
- c. **Cultural care repatterning** (mengubah praktik budaya yang merugikan kesehatan)

Penelitian menunjukkan bahwa penerapan pendekatan transkultural dapat meningkatkan kepuasan pasien dan kualitas hubungan terapeutik. Studi oleh Leininger & McFarland (2021) menegaskan bahwa asuhan yang berbasis budaya mampu meningkatkan keberhasilan intervensi keperawatan secara signifikan.

2. Model Kompetensi Budaya – Campinha-Bacote

Model ini memandang kompetensi budaya sebagai suatu proses berkelanjutan yang terdiri dari lima komponen utama:

- a. **Cultural awareness** (kesadaran budaya)
- b. **Cultural knowledge** (pengetahuan budaya)
- c. **Cultural skill** (keterampilan budaya)
- d. **Cultural encounter** (pengalaman interaksi budaya)
- e. **Cultural desire** (motivasi untuk memahami budaya lain)

Model ini menekankan bahwa perawat tidak hanya perlu memahami budaya pasien secara teoritis, tetapi juga harus memiliki pengalaman langsung dalam berinteraksi dengan pasien dari berbagai latar belakang budaya.

Penelitian oleh Sharifi et al. (2019) menunjukkan bahwa rendahnya kompetensi budaya berhubungan dengan meningkatnya hambatan komunikasi dan menurunnya kualitas pelayanan. Sementara itu, studi Kaihlanen et al. (2019) menemukan bahwa pelatihan kompetensi budaya secara signifikan meningkatkan kemampuan komunikasi perawat.

3. Model Purnell for Cultural Competence

Model Purnell memberikan kerangka yang komprehensif dalam memahami budaya melalui 12 domain, antara lain komunikasi, peran keluarga, praktik kesehatan, serta sistem kepercayaan.

Model ini membantu perawat dalam melakukan pengkajian budaya secara sistematis sehingga dapat memberikan asuhan yang lebih tepat dan kontekstual.

Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model Purnell dalam praktik keperawatan dapat meningkatkan akurasi pengkajian budaya serta efektivitas komunikasi dengan pasien (Purnell, 2020).

4. Teori Komunikasi Lintas Budaya (Intercultural Communication Theory)

Teori komunikasi lintas budaya menjelaskan bahwa perbedaan budaya mempengaruhi cara individu dalam mengirim, menerima, dan menafsirkan pesan. Hambatan komunikasi dapat terjadi akibat perbedaan bahasa, simbol, nilai, serta pola interaksi sosial.

Dalam pelayanan kesehatan, teori ini menekankan pentingnya adaptasi komunikasi agar pesan yang disampaikan dapat dipahami secara tepat oleh pasien.

Penelitian oleh Kwame dan Petrucka (2021) menunjukkan bahwa komunikasi yang sensitif terhadap budaya dapat meningkatkan kepuasan pasien, kepercayaan, serta kepatuhan terhadap terapi.

5. Teori Hubungan Interpersonal – Hildegard Peplau

Peplau menekankan bahwa hubungan terapeutik antara perawat dan pasien dibangun melalui komunikasi interpersonal yang efektif. Dalam konteks lintas budaya, hubungan ini menjadi lebih kompleks karena dipengaruhi oleh perbedaan latar belakang budaya. Keberhasilan hubungan terapeutik sangat bergantung pada kemampuan perawat dalam memahami kebutuhan pasien secara holistik, termasuk aspek budaya.

Penelitian menunjukkan bahwa hubungan terapeutik yang dibangun melalui komunikasi yang sensitif terhadap budaya dapat meningkatkan outcome pasien serta kualitas pelayanan keperawatan (Townsend & Morgan, 2021).

D. Peran Perawat dalam Komunikasi Lintas Budaya

Dalam situasi pelayanan kesehatan yang multikultural, perawat memiliki peran strategis sebagai penghubung antara sistem pelayanan kesehatan dengan latar belakang budaya pasien. Peran ini menuntut kemampuan komunikasi yang tidak hanya efektif, tetapi juga sensitif terhadap perbedaan budaya.

Perawat berperan sebagai **komunikator** yang menyampaikan informasi secara jelas dan mudah dipahami oleh pasien. Selain itu, perawat juga berfungsi sebagai **edukator** yang memberikan pendidikan kesehatan dengan mempertimbangkan latar belakang budaya pasien. Dalam perannya sebagai **advokat**, perawat memperjuangkan hak pasien untuk memperoleh pelayanan yang sesuai dengan nilai dan keyakinan budaya yang dianut. Perawat juga berperan sebagai **konselor** yang membantu pasien dalam menghadapi masalah kesehatan dari aspek psikologis dan emosional.

Pelaksanaan peran tersebut menuntut adanya kompetensi budaya, yaitu kemampuan perawat untuk memahami, menghargai, dan mengintegrasikan nilai budaya pasien dalam praktik keperawatan. Kompetensi ini tidak bersifat statis, melainkan berkembang melalui pengalaman, pembelajaran, dan interaksi dengan pasien dari berbagai latar belakang budaya (Campinha-Bacote, 2019).

E. Penerapan Komunikasi Terapeutik pada Berbagai Konteks Budaya

Penerapan komunikasi terapeutik lintas budaya dalam praktik keperawatan merupakan proses kompleks yang menuntut kemampuan adaptasi, sensitivitas budaya, serta keterampilan interpersonal yang tinggi. Dalam konteks pelayanan kesehatan yang multikultural, perawat tidak hanya dituntut untuk menyampaikan informasi secara efektif, tetapi juga harus mampu menyesuaikan komunikasi dengan nilai, norma, dan kepercayaan pasien.

Pendekatan ini sejalan dengan konsep *culturally competent care* yang menekankan pentingnya integrasi aspek budaya dalam setiap tahap proses keperawatan, mulai dari pengkajian hingga evaluasi. Penerapan komunikasi terapeutik yang sensitif terhadap budaya terbukti dapat meningkatkan kepuasan pasien, memperkuat hubungan terapeutik, serta meningkatkan keberhasilan intervensi keperawatan (Kwame & Petrucka, 2021).

1. Penerapan pada Konteks Rumah Sakit

Rumah sakit merupakan setting pelayanan kesehatan dengan tingkat keberagaman budaya yang tinggi. Pasien yang dirawat sering berasal dari latar belakang sosial, etnis, dan agama yang berbeda.

Dalam konteks ini, perawat perlu:

- a. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami
- b. Menghindari istilah medis yang kompleks
- c. Menghormati praktik keagamaan pasien
- d. Mengakomodasi kebutuhan budaya dalam perawatan

Contoh:

Pasien dari budaya tertentu menolak tindakan medis pada waktu tertentu karena alasan religius. Perawat perlu berkoordinasi dengan tim kesehatan untuk menyesuaikan jadwal tindakan.

2. Penerapan pada Pelayanan Kesehatan Komunitas

Dalam keperawatan komunitas, komunikasi terapeutik harus mempertimbangkan nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat. Perawat komunitas berperan dalam memberikan edukasi kesehatan yang sesuai dengan konteks sosial budaya setempat.

Implikasi Praktik:

- a. Menggunakan pendekatan budaya lokal
- b. Melibatkan tokoh masyarakat
- c. Menyesuaikan pesan kesehatan dengan kepercayaan masyarakat

Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis budaya dalam komunitas dapat meningkatkan keberhasilan program kesehatan, termasuk pencegahan penyakit dan promosi kesehatan.

3. Penerapan pada Pelayanan Home Care

Dalam pelayanan home care, perawat berinteraksi langsung dengan lingkungan keluarga pasien. Hal ini menuntut perawat untuk lebih memahami nilai budaya keluarga sebagai bagian dari sistem pendukung pasien.

Implikasi Praktik:

- a. Menghargai peran keluarga dalam pengambilan keputusan
- b. Menyesuaikan komunikasi dengan struktur keluarga
- c. Mengintegrasikan praktik budaya dalam perawatan

4. Penerapan pada Pasien dengan Perbedaan Bahasa

Perbedaan bahasa merupakan salah satu tantangan utama dalam komunikasi lintas budaya. Ketidakmampuan pasien memahami bahasa yang digunakan tenaga kesehatan dapat menyebabkan miskomunikasi dan kesalahan dalam terapi.

Strategi:

- a. Menggunakan penerjemah profesional
- b. Menggunakan media visual atau gambar
- c. Menggunakan teknik *teach-back*

Bischoff dan Hudelson (2010) menunjukkan bahwa penggunaan penerjemah dapat meningkatkan akurasi komunikasi serta keselamatan pasien.

5. Penerapan pada Pasien dengan Nilai Budaya yang Kuat

Beberapa pasien memiliki keyakinan budaya yang kuat terkait penyakit dan pengobatan. Dalam kondisi ini, perawat harus mampu menyeimbangkan antara pendekatan medis dan nilai budaya pasien.

Contoh:

Pasien lebih memilih pengobatan tradisional dibandingkan medis modern.

Pendekatan:

- a. Menghargai keyakinan pasien
- b. Memberikan edukasi tanpa memaksakan
- c. Mengintegrasikan praktik budaya yang tidak merugikan

F. F. Hambatan dalam Komunikasi Terapeutik Lintas Budaya

Komunikasi terapeutik lintas budaya merupakan proses yang kompleks karena melibatkan interaksi antara individu dengan latar belakang budaya yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitas komunikasi, hubungan terapeutik, serta kualitas pelayanan keperawatan.

Secara konseptual, hambatan komunikasi lintas budaya bersifat multidimensional dan dapat dijelaskan melalui integrasi berbagai teori, seperti teori keperawatan transkultural (Leininger), model kompetensi budaya (Campinha-Bacote), teori komunikasi lintas budaya, serta teori hubungan interpersonal (Peplau). Hambatan muncul ketika terjadi ketidaksesuaian antara sistem nilai, bahasa, persepsi, dan praktik budaya antara perawat dan pasien.

1. Perbedaan Bahasa

Bahasa merupakan media utama dalam komunikasi. Perbedaan bahasa dapat menyebabkan distorsi makna, kesalahan interpretasi, dan miskomunikasi dalam interaksi klinis. Dalam konteks kesehatan, kesalahan pemahaman bahasa dapat berdampak langsung pada keselamatan pasien.

Teori komunikasi lintas budaya menyatakan bahwa bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai representasi budaya yang mengandung makna simbolik. Bischoff dan Hudelson (2010) menemukan bahwa keterbatasan bahasa meningkatkan risiko kesalahan medis, sedangkan penggunaan penerjemah profesional dapat meningkatkan akurasi komunikasi.

Implikasi

- a. Risiko kesalahan terapi
- b. Ketidakpatuhan pasien
- c. Penurunan keselamatan pasien

2. Perbedaan Nilai dan Norma

Nilai dan norma budaya mempengaruhi cara individu dalam mengambil keputusan terkait kesehatan. Perbedaan ini dapat menyebabkan konflik antara pendekatan medis dengan keyakinan pasien.

Teori Leininger menekankan bahwa ketidaksesuaian nilai budaya dapat menghambat penerimaan asuhan keperawatan. Purnell (2020) menunjukkan bahwa nilai budaya berpengaruh terhadap perilaku kesehatan dan kepatuhan pasien terhadap terapi.

Implikasi

- a. Penolakan tindakan medis
- b. Keterlambatan intervensi
- c. Konflik antara pasien dan tenaga kesehatan

3. Stereotip dan Prasangka

Stereotip dan prasangka merupakan bentuk bias kognitif yang dapat mempengaruhi persepsi perawat terhadap pasien. Hal ini dapat menghambat komunikasi yang objektif dan profesional. Model Campinha-Bacote menekankan pentingnya *cultural awareness* untuk menghindari bias budaya.

Sharifi et al. (2019) menunjukkan bahwa stereotip negatif dapat menurunkan kualitas komunikasi dan meningkatkan risiko diskriminasi dalam pelayanan kesehatan.

Implikasi

- a. Hubungan terapeutik terganggu
- b. Penurunan kualitas asuhan
- c. Ketidakpercayaan pasien

4. Perbedaan Persepsi terhadap Penyakit

Persepsi terhadap penyakit dipengaruhi oleh budaya, termasuk penyebab penyakit, cara pengobatan, dan makna sakit. Perbedaan ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara pendekatan medis dan keyakinan pasien.

Teori transkultural Leininger menyatakan bahwa persepsi kesehatan dan penyakit bersifat budaya. Kwame dan Petrucka (2021) menunjukkan bahwa perbedaan persepsi dapat mempengaruhi kepatuhan pasien terhadap terapi.

Implikasi

- a. Penolakan pengobatan medis
- b. Preferensi terhadap pengobatan tradisional
- c. Konflik terapeutik

5. Kurangnya Kompetensi Budaya Perawat

Kompetensi budaya merupakan kemampuan untuk memahami, menghargai, dan mengintegrasikan budaya pasien dalam praktik keperawatan. Kurangnya kompetensi ini menjadi salah satu hambatan utama dalam komunikasi lintas budaya.

Model Campinha-Bacote menegaskan bahwa kompetensi budaya adalah proses berkelanjutan yang harus dimiliki oleh tenaga kesehatan. Kaihlanen et al. (2019) menunjukkan bahwa pelatihan kompetensi budaya dapat meningkatkan kemampuan komunikasi perawat secara signifikan.

Implikasi

- a. Miskomunikasi
- b. Asuhan tidak efektif
- c. Penurunan kualitas pelayanan

G. G. Strategi Praktis dalam Komunikasi Terapeutik Lintas Budaya

Untuk meningkatkan efektivitas komunikasi, perawat dapat menerapkan beberapa strategi berikut:

1. Penggunaan Bahasa yang Efektif

Perawat perlu menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami. Penghindaran istilah medis yang kompleks menjadi penting untuk mencegah miskomunikasi.

2. Pemanfaatan Penerjemah

Dalam kondisi perbedaan bahasa yang signifikan, penggunaan penerjemah profesional sangat dianjurkan untuk menjaga akurasi informasi.

3. Pendekatan Empatik

Perawat harus menunjukkan sikap empati dengan mendengarkan secara aktif dan menghargai pengalaman pasien.

4. Adaptasi Komunikasi Nonverbal

Bahasa tubuh, kontak mata, dan ekspresi wajah harus disesuaikan dengan norma budaya pasien.

5. Negosiasi Budaya

Perawat perlu melakukan pendekatan negosiasi untuk menemukan titik temu antara praktik medis dan kepercayaan pasien.

Model Campinha-Bacote menekankan bahwa kompetensi budaya merupakan proses yang berkelanjutan yang melibatkan pengalaman langsung dalam berinteraksi dengan pasien dari berbagai latar belakang budaya (Campinha-Bacote, 2019).

H. Aplikasi Komunikasi Terapeutik dalam Praktik Keperawatan

Komunikasi terapeutik merupakan komponen esensial dalam praktik keperawatan yang diaplikasikan pada setiap tahap proses keperawatan. Dalam konteks lintas budaya, aplikasi komunikasi terapeutik tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga pada kemampuan perawat dalam memahami, menyesuaikan, dan mengintegrasikan aspek budaya pasien dalam setiap interaksi klinis.

Penerapan komunikasi terapeutik yang efektif dan sensitif terhadap budaya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hubungan terapeutik, kepuasan pasien, serta keberhasilan intervensi keperawatan. Hal ini sejalan dengan teori hubungan interpersonal yang dikemukakan oleh Peplau, yang menekankan bahwa komunikasi merupakan inti dari hubungan terapeutik antara perawat dan pasien.

1. Aplikasi pada Tahap Pengkajian Keperawatan

Pada tahap pengkajian, komunikasi terapeutik digunakan untuk mengumpulkan data secara komprehensif, termasuk aspek bio-psiko-sosial dan budaya pasien.

- a. Menggunakan pertanyaan terbuka
- b. Mengkaji nilai, kepercayaan, dan praktik budaya pasien
- c. Menghindari asumsi budaya

Contoh:

Perawat menanyakan keyakinan pasien terkait penyebab penyakit dan pilihan pengobatan yang diinginkan.

2. Aplikasi pada Tahap Diagnosis Keperawatan

Pada tahap ini, komunikasi terapeutik digunakan untuk menginterpretasikan data yang telah dikaji, termasuk faktor budaya yang mempengaruhi kondisi pasien.

- a. Mengintegrasikan faktor budaya dalam analisis masalah
- b. Menghindari bias dalam penetapan diagnosis
- c. Melibatkan pasien dalam proses identifikasi masalah

Diagnosis yang lebih akurat dan kontekstual sesuai dengan kondisi pasien.

3. Aplikasi pada Tahap Perencanaan Keperawatan

Pada tahap perencanaan, komunikasi terapeutik digunakan untuk menyusun rencana tindakan yang sesuai dengan kebutuhan dan budaya pasien.

- a. Melibatkan pasien dan keluarga dalam perencanaan
- b. Menyesuaikan intervensi dengan nilai budaya
- c. Menghormati preferensi pasien

4. Aplikasi pada Tahap Implementasi Keperawatan

Tahap implementasi merupakan tahap pelaksanaan tindakan keperawatan, di mana komunikasi terapeutik berperan dalam memberikan edukasi, dukungan, dan intervensi langsung kepada pasien.

- a. Menggunakan bahasa sederhana
- b. Memberikan edukasi yang sesuai budaya
- c. Menggunakan teknik komunikasi seperti empati dan *active listening*

5. Aplikasi pada Tahap Evaluasi Keperawatan

Pada tahap evaluasi, komunikasi terapeutik digunakan untuk menilai efektivitas intervensi serta respon pasien terhadap tindakan yang diberikan.

- a. Menggunakan teknik *feedback*
- b. Mengkaji kepuasan pasien
- c. Mengevaluasi kesesuaian intervensi dengan budaya pasien

I. Penutup

Komunikasi terapeutik lintas budaya merupakan kompetensi esensial dalam praktik keperawatan modern yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika masyarakat yang semakin multikultural. Perawat tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan komunikasi yang efektif secara teknis, tetapi juga harus mampu memahami, menghargai, dan mengintegrasikan aspek budaya dalam setiap interaksi dengan pasien.

Pembahasan dalam bab ini menegaskan bahwa komunikasi terapeutik lintas budaya memiliki landasan teoritis yang kuat, mulai dari teori keperawatan transkultural, model kompetensi budaya, teori komunikasi lintas budaya, hingga teori hubungan interpersonal. Integrasi berbagai teori tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan komunikasi dalam keperawatan sangat bergantung pada kemampuan perawat dalam membangun hubungan terapeutik yang sensitif terhadap nilai, norma, dan kepercayaan pasien.

Selain itu, berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang berorientasi pada budaya berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kepuasan pasien, kepatuhan terhadap terapi, serta kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Sebaliknya, hambatan komunikasi lintas budaya seperti perbedaan bahasa, nilai, persepsi, dan kurangnya kompetensi budaya dapat berdampak negatif terhadap keselamatan pasien dan efektivitas asuhan keperawatan.

Penerapan komunikasi terapeutik lintas budaya dalam praktik keperawatan harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, mulai dari tahap pengkajian hingga evaluasi. Perawat perlu mengembangkan kompetensi budaya melalui pembelajaran, pengalaman klinis, serta refleksi diri secara terus-menerus. Dengan demikian, perawat dapat memberikan pelayanan yang tidak hanya berfokus pada aspek biologis, tetapi juga mencakup dimensi psikologis, sosial, dan budaya pasien secara holistik.

Pada akhirnya, komunikasi terapeutik lintas budaya bukan hanya sekadar keterampilan, melainkan merupakan bentuk profesionalisme dan tanggung jawab etis dalam memberikan asuhan keperawatan yang bermutu. Dengan

mengedepankan pendekatan yang humanistik dan berpusat pada pasien, perawat diharapkan mampu berkontribusi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta mewujudkan pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan.

Referensi

- Arnold, E. C., & Boggs, K. U.. (2020). *Interpersonal relationships: Professional communication skills for nurses* (8th ed.). Elsevier.
- Baylon, M. A., & Maglaya, A. S.. (1997). *Family health nursing: The Filipino experience*. UP Open University.
- Bischoff, A., & Hudelson, P.. (2010). Communicating with foreign language-speaking patients: Is access to professional interpreters enough? *Journal of Travel Medicine*, 17(1), 15–20. <https://doi.org/10.1111/j.1708-8305.2009.00370.x>
- Campinha-Bacote, J.. (2019). *The process of cultural competence in the delivery of healthcare services: A model of care* (5th ed.). Transcultural C.A.R.E. Associates.
- Friedman, M. M., Bowden, V. R., & Jones, E. G.. (2003). *Family nursing: Research, theory, and practice* (5th ed.). Prentice Hall.
- Kaihlanen, A.-M., Hietapakka, L., & Heponiemi, T.. (2019). Increasing cultural awareness: Qualitative study of nurses' perceptions about cultural competence training. *BMC Nursing*, 18(1), 38. <https://doi.org/10.1186/s12912-019-0363-x>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). *Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)*. Kemenkes RI.
- Kwame, A., & Petrucka, P. M.. (2021). A literature-based study of patient-centered care and communication in nurse-patient interactions. *Journal of Patient Experience*, 8, 1–8. <https://doi.org/10.1177/2374373521996980>
- Latkin, C. A., Knowlton, A. R., & Forman, V.. (2010). Social network approaches to understanding HIV risk behavior. *Current HIV/AIDS Reports*, 7(3), 124–131.
- Leininger, M. M., & McFarland, M. R.. (2021). *Transcultural nursing: Concepts, theories, research, and practice* (4th ed.). McGraw-Hill.
- Peplau, H. E.. (1997). *Peplau's theory of interpersonal relations*. *Nursing Science Quarterly*, 10(4), 162–167.
- Purnell, L.. (2020). *Guide to culturally competent health care* (4th ed.). Springer.
- Seeley, J., Nakiyingi-Miir, J., & Kamali, A.. (2012). High HIV incidence and socio-behavioral risk patterns in fishing communities on the shores of Lake Victoria, Uganda. *Sexually Transmitted Diseases*, 39(6), 433–439.
- Sharifi, N., Adib-Hajbaghery, M., & Najafi, M.. (2019). Cultural competence in nursing: A concept analysis. *International Journal of Nursing Studies*, 99, 103386.

Stanhope, M., & Lancaster, J.. (1996). *Community health nursing: Promoting health of aggregates, families, and individuals*. Mosby.

Townsend, M. C., & Morgan, K. I.. (2021). *Psychiatric mental health nursing: Concepts of care in evidence-based practice* (10th ed.). F.A. Davis.

Glosarium

Active Listening (Mendengarkan Aktif)

Teknik komunikasi yang melibatkan perhatian penuh, pemahaman, dan respons terhadap pesan yang disampaikan pasien secara verbal maupun nonverbal.

Advokat (Advocate)

Peran perawat dalam memperjuangkan hak pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan, nilai, dan keyakinan budaya.

Asuhan Keperawatan

Serangkaian proses sistematis yang meliputi pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi dalam memberikan pelayanan kepada pasien.

Budaya (Culture)

Sistem nilai, kepercayaan, norma, dan praktik yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat yang mempengaruhi perilaku, termasuk dalam bidang kesehatan.

Cultural Awareness (Kesadaran Budaya)

Kemampuan untuk mengenali dan memahami perbedaan budaya serta menyadari adanya bias budaya dalam diri sendiri.

Cultural Competence (Kompetensi Budaya)

Kemampuan perawat dalam memahami, menghargai, dan mengintegrasikan aspek budaya pasien dalam praktik keperawatan.

Cultural Encounter (Pengalaman Budaya)

Interaksi langsung dengan individu dari latar belakang budaya yang berbeda untuk meningkatkan pemahaman budaya.

Cultural Knowledge (Pengetahuan Budaya)

Pemahaman tentang nilai, kepercayaan, dan praktik budaya pasien yang relevan dalam pelayanan kesehatan.

Cultural Skill (Keterampilan Budaya)

Kemampuan dalam mengkaji dan mengimplementasikan asuhan keperawatan yang sesuai dengan budaya pasien.

Empati (Empathy)

Kemampuan untuk memahami dan merasakan kondisi emosional pasien serta mengekspresikannya dalam bentuk respons yang tepat.

Etika Keperawatan

Prinsip moral yang menjadi pedoman dalam praktik keperawatan, termasuk menghormati hak, martabat, dan budaya pasien.

Intercultural Communication (Komunikasi Lintas Budaya)

Proses pertukaran informasi antara individu yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda.

Komunikasi Nonverbal

Bentuk komunikasi tanpa kata-kata, seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, kontak mata, dan intonasi suara.

Komunikasi Terapeutik

Proses komunikasi yang dirancang secara sadar dan terstruktur untuk membantu pasien mencapai kondisi kesehatan yang optimal.

Komunikasi Terapeutik Lintas Budaya

Pendekatan komunikasi dalam keperawatan yang mempertimbangkan perbedaan budaya untuk menciptakan interaksi yang efektif dan sensitif terhadap nilai pasien.

Model Purnell

Kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami budaya melalui berbagai domain, seperti komunikasi, keluarga, dan praktik kesehatan.

Pasien (Client/Patient)

Individu yang menerima pelayanan kesehatan, baik dalam kondisi sehat maupun sakit.

Patient-Centered Care (Pelayanan Berpusat pada Pasien)

Pendekatan pelayanan kesehatan yang menempatkan kebutuhan, nilai, dan preferensi pasien sebagai fokus utama.

Persepsi Penyakit (Illness Perception)

Pandangan atau keyakinan individu terhadap penyebab, makna, dan penanganan penyakit yang dipengaruhi oleh budaya.

Perawat (Nurse)

Tenaga kesehatan profesional yang memberikan asuhan keperawatan secara holistik kepada individu, keluarga, dan komunitas.

Pra-Interaksi

Tahap awal dalam komunikasi terapeutik di mana perawat mempersiapkan diri sebelum bertemu pasien.

Prasangka (Prejudice)

Sikap atau penilaian negatif terhadap individu atau kelompok tertentu tanpa dasar yang objektif.

Refleksi

Teknik komunikasi yang digunakan untuk mengembalikan atau menegaskan kembali perasaan atau pernyataan pasien.

Stereotip (Stereotype)

Generalisasi atau penilaian terhadap suatu kelompok berdasarkan karakteristik tertentu yang belum tentu benar.

Teach-Back Method

Teknik komunikasi untuk memastikan pemahaman pasien dengan meminta pasien mengulang kembali informasi yang telah diberikan.

Terminasi

Tahap akhir dalam komunikasi terapeutik yang ditandai dengan penutupan interaksi secara profesional.

Transcultural Nursing

Pendekatan keperawatan yang menekankan pentingnya pemahaman budaya dalam pemberian asuhan keperawatan.

Working Phase (Tahap Kerja)

Tahap dalam komunikasi terapeutik di mana perawat dan pasien bekerja sama untuk mengatasi masalah kesehatan.

BAB 6

MODEL ASUHAN TRANSKULTURAL BERBASIS KONTEKS INDONESIA

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keberagaman budaya tertinggi di dunia. Keberagaman ini meliputi perbedaan etnis, bahasa, agama, nilai, dan praktik kehidupan sehari-hari yang secara langsung mempengaruhi cara individu dan kelompok dalam memandang kesehatan dan penyakit. Dalam konteks pelayanan kesehatan, khususnya keperawatan, keberagaman tersebut menjadi faktor penting yang tidak dapat diabaikan karena berpengaruh terhadap perilaku pencarian pelayanan kesehatan, kepatuhan terhadap terapi, serta hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien (Giger & Haddad, 2021).

Praktik keperawatan modern yang berbasis ilmu biomedis seringkali belum sepenuhnya mengakomodasi aspek budaya pasien. Hal ini dapat menimbulkan kesenjangan antara intervensi yang diberikan dengan nilai dan keyakinan pasien, sehingga berpotensi menurunkan efektivitas asuhan keperawatan. Sebagai contoh, pasien yang memiliki kepercayaan kuat terhadap pengobatan tradisional cenderung menolak intervensi medis jika dianggap bertentangan dengan nilai budayanya (Helman, 2007).

Keperawatan transkultural hadir sebagai pendekatan yang menekankan pentingnya pemahaman budaya dalam memberikan asuhan keperawatan yang efektif, aman, dan bermakna. Namun, sebagian besar model keperawatan transkultural yang berkembang masih berbasis pada konteks budaya Barat, sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang kolektif, religius, dan menjunjung tinggi nilai kekeluargaan (Andrews & Boyle, 2020). Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam penerapannya di Indonesia yang memiliki karakteristik masyarakat kolektivistik, religius, dan berbasis nilai kekeluargaan.

Oleh karena itu, diperlukan pengembangan model asuhan keperawatan transkultural yang berbasis pada konteks lokal Indonesia. Model ini diharapkan mampu mengintegrasikan nilai budaya, sistem sosial, dan praktik kesehatan masyarakat Indonesia ke dalam proses keperawatan secara komprehensif.

Rumusan masalah dalam bab ini adalah bagaimana menyusun model asuhan keperawatan transkultural yang relevan dengan konteks sosial budaya Indonesia.

Adapun tujuan penulisan adalah untuk mengembangkan kerangka konseptual dan implementatif model tersebut dalam praktik keperawatan.

B. Konsep Dasar Keperawatan Transkultural

Keperawatan transkultural merupakan cabang ilmu keperawatan yang berfokus pada studi komparatif budaya dan penerapannya dalam praktik keperawatan. Tujuan utamanya adalah memberikan asuhan yang sesuai dengan nilai, kepercayaan, dan praktik budaya pasien sehingga meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil kesehatan (Leininger & McFarland, 2006).

Budaya dalam konteks ini mencakup nilai, norma, kepercayaan, dan praktik yang dipelajari dan diwariskan dalam suatu kelompok masyarakat. Budaya mempengaruhi cara individu memahami konsep sehat dan sakit, serta bagaimana mereka merespons intervensi kesehatan (Purnell, 2018).

Keperawatan transkultural adalah suatu bidang keperawatan yang berfokus pada perbandingan dan analisis budaya untuk memberikan asuhan keperawatan yang sesuai dengan nilai, kepercayaan, dan praktik budaya klien. Tujuan Keperawatan Transkultural antara lain yaitu untuk memberikan asuhan yang sesuai budaya, meningkatkan kepuasan pasien dan mencegah konflik budaya dalam pelayanan kesehatan (Andrews & Boyle, 2020).

Beberapa model teoritis yang menjadi dasar keperawatan transkultural antara lain:

1. Sunrise Model yang menekankan hubungan antara faktor sosial, budaya, dan sistem kesehatan dalam menentukan praktik keperawatan. Model ini membantu perawat dalam melakukan pengkajian aspek budaya pasien secara komprehensif (Leininger & McFarland, 2006).
2. Purnell Model for Cultural Competence yang mengkaji budaya melalui berbagai domain (12 domain) seperti keluarga, komunikasi, spiritualitas, dan praktik kesehatan (Purnell, 2018).
3. Campinha-Bacote Model yang menekankan kompetensi budaya sebagai proses dinamis yang meliputi kesadaran, pengetahuan, keterampilan, pertemuan budaya, pengalaman dan keinginan budaya sebagai proses yang berkelanjutan dalam praktik keperawatan (Campinha-Bacote, 2002).

Prinsip utama dalam keperawatan transkultural berfokus pada pemberian asuhan yang selaras dengan nilai, kepercayaan, dan praktik budaya pada klien. Konsep ini banyak dikembangkan oleh Madeleine Leininger (2006) melalui teori *Culture Care Diversity and Universality* (Spector, 2017). Berikut uraian prinsip-prinsip utama dalam keperawatan transkultural:

1. *Cultural Care* (Asuhan Berbasis Budaya)

Perawat harus memahami bahwa setiap individu memiliki nilai dan praktik budaya yang memengaruhi persepsi sehat-sakit, perilaku pencarian pengobatan, dan respons terhadap intervensi keperawatan. Asuhan keperawatan perlu disesuaikan dengan konteks budaya klien agar efektif dan bermakna. Leininger (2002) menyatakan bahwa perawatan yang tidak sesuai budaya dapat menyebabkan ketidakpatuhan dan hasil kesehatan yang buruk.

2. *Cultural Awareness* (Kesadaran Budaya)

Perawat perlu menyadari latar belakang budaya dirinya sendiri dan bagaimana hal tersebut dapat memengaruhi interaksi dengan klien. Kesadaran ini penting untuk menghindari bias dan stereotip dalam praktik keperawatan. Campinha-Bacote (2011) menekankan bahwa kesadaran budaya adalah langkah awal dalam kompetensi budaya.

3. *Cultural Knowledge* (Pengetahuan Budaya).

Perawat harus memiliki pengetahuan tentang berbagai budaya, termasuk nilai, kepercayaan, praktik kesehatan, dan sistem keluarga. Pengetahuan ini membantu dalam pengambilan keputusan klinis yang tepat. Giger & Davidhizar (2008) menjelaskan bahwa pengetahuan budaya membantu memahami respons pasien terhadap penyakit dan pengobatan.

4. *Cultural Skill* (Keterampilan Budaya). Kemampuan perawat untuk melakukan pengkajian budaya (*cultural assessment*) secara sistematis dan sensitif. Ini mencakup kemampuan komunikasi efektif lintas budaya. Keterampilan budaya memungkinkan pengkajian yang akurat terhadap kebutuhan klien (Campinha-Bacote, 2011).

5. *Cultural Encounter* (Interaksi Budaya). Perawat perlu sering berinteraksi langsung dengan klien dari berbagai latar belakang budaya untuk meningkatkan pemahaman dan mengurangi stereotip. Interaksi langsung membantu meningkatkan kompetensi budaya melalui pengalaman nyata (Campinha-Bacote, 2011).

6. *Cultural Desire* (Keinginan Budaya)

Adanya motivasi intrinsik dari perawat untuk memahami dan menghargai budaya klien, bukan karena kewajiban semata. Campinha-Bacote (2011) menegaskan bahwa keinginan budaya merupakan inti dari pengembangan kompetensi budaya.

7. *Holistic and Contextual Care* (Pendekatan Holistik)

Keperawatan transkultural memandang manusia secara menyeluruh, termasuk aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual dalam konteks budaya Andrews & Boyle (2020).

Penghargaan terhadap keberagaman budaya, komunikasi yang sensitif budaya, adaptasi intervensi sesuai nilai pasien serta kolaborasi dengan keluarga dan komunitas juga merupakan prinsip-prinsip dalam keperawatan transcultural.

Prinsip keperawatan transkultural menekankan pentingnya kompetensi budaya dalam praktik keperawatan. Perawat dituntut untuk memahami, menghargai, dan mengintegrasikan nilai budaya klien dalam setiap tahap proses keperawatan guna meningkatkan kualitas asuhan dan keselamatan pasien.

C. Konteks Sosial Budaya Masyarakat Indonesia

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat multikultural yang memiliki karakteristik kolektivistik, di mana kepentingan kelompok lebih diutamakan dibandingkan individu. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan penghormatan terhadap otoritas sangat memengaruhi interaksi sosial, termasuk dalam pelayanan kesehatan (Koentjaraningrat, 2015).

Masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang terdiri atas berbagai kelompok budaya yang hidup bersama dalam satu sistem sosial. Setiap kelompok memiliki identitas budaya, bahasa, nilai, dan tradisi yang berbeda, tetapi tetap berada dalam satu kesatuan sosial dan politik (Parekh, 2006).

Dalam konteks Indonesia, multikulturalisme tidak hanya berarti keberagaman, tetapi juga pengakuan terhadap hak setiap kelompok budaya untuk mempertahankan identitasnya. Prinsip ini tercermin dalam semboyan nasional *Bhinneka Tunggal Ika* yang berarti “berbeda-beda tetapi tetap satu”.

Konsep sehat dan sakit dalam masyarakat Indonesia seringkali dipengaruhi oleh kepercayaan tradisional dan spiritual. Sebagian masyarakat memandang penyakit sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara tubuh, pikiran, dan spiritual, atau bahkan sebagai konsekuensi dari faktor supranatural (Helman, 2007).

Keberagaman budaya di Indonesia dipengaruhi oleh faktor geografis, sejarah, agama, kolonialisme, dan mobilitas penduduk. Kondisi geografis berupa kepulauan menyebabkan berkembangnya budaya lokal yang beragam dan khas di setiap daerah.

Selain itu, praktik pengobatan tradisional seperti penggunaan jamu, pijat tradisional, serta terapi berbasis spiritual masih banyak digunakan, baik sebagai terapi utama maupun pelengkap. Dalam konteks ini, perawat perlu memiliki pemahaman yang komprehensif agar dapat memberikan asuhan yang tidak bertentangan dengan nilai pasien.

Peran keluarga dalam pengambilan keputusan kesehatan juga sangat dominan. Dalam banyak kasus, keputusan tidak diambil oleh individu pasien,

melainkan melalui musyawarah keluarga besar. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang dalam implementasi asuhan keperawatan transkultural.

D. Model Asuhan Transkultural Berbasis Konteks Indonesia

Model asuhan keperawatan transkultural berbasis Indonesia dikembangkan dengan landasan filosofis yang mencakup nilai kemanusiaan, budaya lokal, dan pendekatan holistik. Model ini mengintegrasikan dimensi bio-psiko-sosio-spiritual dalam konteks budaya Indonesia.

Menurut Madeleine Leininger (2002), terdapat tiga pendekatan utama dalam memberikan asuhan:

1. *Cultural Care Preservation/Maintenance.*

Merupakan pendekatan yang berupaya mempertahankan praktik budaya yang bermanfaat bagi kesehatan. Contoh: mempertahankan pola makan tradisional yang sehat.

2. *Cultural Care Accommodation/Negotiation.*

Pendekatan yang bersifat menyesuaikan atau bernegosiasi dengan praktik budaya klien agar sesuai dengan terapi medis.

3. *Cultural Care Repatterning/Restructuring.*

Suatu pendekatan yang mengubah praktik budaya yang merugikan kesehatan dengan pendekatan yang sensitif budaya.

Landasan Filosofis Model Asuhan Transkultural Berbasis Konteks Indonesia ini berakar pada nilai-nilai:

1. Kemanusiaan dan penghargaan terhadap martabat pasien
2. Gotong royong dan kebersamaan
3. Spirit religiusitas yang kuat dalam kehidupan masyarakat

Model Asuhan Transkultural Berbasis Konteks Indonesia terdiri dari lima komponen utama, yaitu:

1. Pengkajian budaya (*cultural assessment*)

Pengkajian yang meliputi identifikasi nilai, kepercayaan, praktik kesehatan, serta peran keluarga dan komunitas.

2. Diagnosis keperawatan berbasis budaya

Komponen diagnosis berbasis budaya akan mengintegrasikan respons pasien dengan faktor budaya yang mempengaruhinya.

3. Perencanaan asuhan kontekstual

Perencanaan dilakukan dengan mempertimbangkan nilai budaya, preferensi pasien, dan keterlibatan keluarga.

4. Implementasi kolaboratif

Dalam implementasi kolaboratif selalu melibatkan pasien, keluarga, serta tokoh masyarakat atau spiritual bila diperlukan

5. Evaluasi berbasis nilai pasien

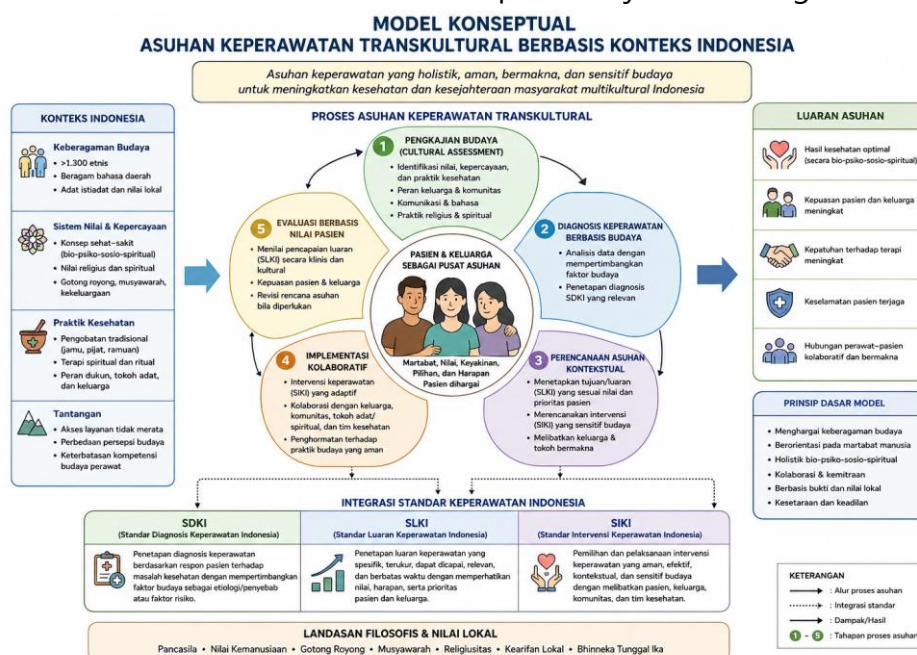
Merupakan komponen yang menilai keberhasilan asuhan yang tidak hanya ditinjau dari aspek klinis, tetapi juga aspek kepuasan dan kesesuaian budaya.

Selanjutnya, hal ini memerlukan suatu fasilitas dari perawat keluarga sebagai upaya mengoptimalkan keluarga dalam mencapai tugas perkembangan dan kemandirian keluarga. Dalam model asuhan keperawatan transkultural berbasis konteks Indonesia terdapat beberapa nilai lokal yang diintegrasikan dalam model ini, yaitu:

1. Keluarga sebagai pusat pengambilan keputusan
2. Musyawarah sebagai mekanisme konsensus
3. Praktik religius sebagai bagian dari proses penyembuhan.

Ketiga unsur nilai lokal tersebut, seringkali menjadi hal yang selalu harus diperhatikan oleh perawat dalam memberikan asuhan atau pelayanan kesehatan multikultural pada pasien/klien dalam menjaga dan meningkatkan kualitas layanan keperawatan.

Berdasarkan berbagai tinjauan uraian sumber pustaka yang ada terkait keperawatan transcultural, maka gambaran Model Konseptual asuhan keperawatan transkultural berbasis konteks Indonesia dapat ditunjukkan sebagai berikut:



Gambar 6.1

Diagram Model Konseptual Asuhan Keperawatan Transkultural Berbasis Indonesia

E. Implementasi Model Asuhan Transkultural dalam Praktik Keperawatan

Implementasi model asuhan transkultural berbasis konteks Indonesia ini dapat dilakukan di berbagai tatanan pelayanan kesehatan. Pada layanan primer seperti puskesmas, perawat dapat mengintegrasikan pendekatan budaya lokal dalam promosi kesehatan dalam pencegahan penyakit berbasis komunitas. Pendekatan ini efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Di rumah sakit, perawat perlu menyesuaikan intervensi klinis dengan nilai pasien, misalnya dalam pemberian diet, perawatan akhir hayat, atau praktik ibadah.

Pada kelompok rentan seperti lansia, ibu dan anak, serta masyarakat adat, intervensi khusus melalui pendekatan transkultural sangat penting untuk menghindari konflik nilai dan meningkatkan kepatuhan terhadap program terapi.

Komunikasi terapeutik lintas budaya menjadi kunci utama keberhasilan implementasi. Perawat harus mampu menggunakan bahasa yang sesuai, memahami simbol budaya, serta menunjukkan empati dan penghargaan terhadap pasien (Papadopoulos, 2018).

Sistem kesehatan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan akses pelayanan, perbedaan kualitas layanan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta rendahnya literasi kesehatan masyarakat. Faktor budaya seringkali menjadi determinan penting dalam masalah tersebut (Koentjaraningrat, 2015). Beberapa permasalahan utama dalam pelayanan kesehatan multikultural di Indonesia antara lain:

1. Perbedaan persepsi sehat-sakit

Pasien mungkin memiliki konsep kesehatan yang berbeda dengan tenaga kesehatan.

2. Hambatan komunikasi

Perbedaan bahasa dan gaya komunikasi dapat menyebabkan kesalahpahaman.

3. Konflik nilai dan kepercayaan

Intervensi medis dapat bertentangan dengan keyakinan budaya pasien.

4. Kurangnya kompetensi budaya tenaga kesehatan

Banyak tenaga kesehatan belum memiliki pelatihan khusus dalam keperawatan transkultural.

Pendekatan transkultural memungkinkan perawat untuk meningkatkan komunikasi efektif dengan pasien, mengurangi konflik budaya dalam pelayanan, meningkatkan kepatuhan terhadap terapi dan meningkatkan kepuasan pasien.

Dengan demikian, keperawatan transkultural bukan hanya menjadi kebutuhan akademik, tetapi juga kebutuhan praktis dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

F. Integrasi SDKI–SLKI–SIKI dalam Model Asuhan Transkultural Berbasis Konteks Indonesia

Integrasi standar nasional keperawatan Indonesia ke dalam model asuhan transkultural Indonesia merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa praktik keperawatan tetap berbasis bukti, terstandar, sekaligus sensitif terhadap budaya. Tiga pilar utama yang digunakan adalah Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI), Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI), dan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI) yang dikembangkan oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia.

Pendekatan 3S (Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia/SDKI, Standar Luaran Keperawatan Indonesia/SLKI), dan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI) ini memungkinkan perawat mengintegrasikan aspek budaya ke dalam seluruh tahapan proses keperawatan secara sistematis dan terukur. Berikut ini adalah uraian tentang integrasi model keperawatan transkultural dalam setiap tahapan proses atau asuhan keperawatan.

1. Integrasi pada Tahap Pengkajian (*Cultural Assessment*)

Pada tahap ini, pengkajian tidak hanya berfokus pada data biologis, tetapi juga aspek budaya pasien, meliputi: a) Nilai dan kepercayaan tentang kesehatan dan penyakit; b) Praktik pengobatan tradisional; c) Peran keluarga dalam pengambilan keputusan; Bahasa dan pola komunikasi; d) Praktik religius dan spiritual.

Contoh integrasi:

- a. Data subjektif: Pasien lebih percaya pengobatan herbal dibanding obat medis.
- b. Data objektif: Penundaan terapi medis akibat konsultasi dengan tokoh adat.

Hasil pengkajian **Identifikasi faktor budaya sebagai etiologi** ini menjadi dasar dalam penentuan diagnosis keperawatan berbasis SDKI.

2. Integrasi pada Penetapan Diagnosis Keperawatan (SDKI)

Diagnosis keperawatan dipilih dengan mempertimbangkan faktor budaya yang memengaruhi respons pasien.

Contoh diagnosis keperawatan (SDKI) yang relevan:

- a. Ketidakpatuhan (non-compliance)
- b. Gangguan komunikasi verbal
- c. Ansietas
- d. Defisit pengetahuan

- e. Konflik pengambilan keputusan

Contoh formulasi diagnosis keperawatan berbasis respon budaya:

- a. Ketidapatuhan berhubungan dengan keyakinan perbedaan nilai budaya terhadap pengobatan tradisional ditandai dengan penolakan terapi medis. Pendekatan ini menunjukkan bahwa faktor budaya menjadi etiologi penting dalam diagnosis keperawatan.
- b. Ansietas berhubungan dengan Ketidakpahaman sistem medis dan perbedaan persepsi medis.

Pendekatan tersebut di atas menunjukkan bahwa faktor budaya menjadi etiologi penting dalam diagnosis keperawatan.

3. Integrasi pada Penentuan Luaran (SLKI)

Luaran keperawatan atau outcome dirumuskan secara spesifik, terukur, dan tetap mempertimbangkan nilai budaya pasien.

Contoh SLKI yang digunakan:

- a. Kepatuhan pengobatan meningkat
- b. Tingkat ansietas menurun
- c. Pengetahuan pasien meningkat
- d. Komunikasi efektif

Contoh indikator berbasis budaya:

- a. Pasien menunjukkan penerimaan terhadap terapi medis tanpa meninggalkan nilai budaya
- b. Keluarga terlibat aktif dalam pengambilan keputusan
- c. Pasien mampu menjelaskan hubungan antara terapi medis dan praktik tradisional

4. Integrasi pada Intervensi Keperawatan (SIKI)

Intervensi keperawatan dirancang secara fleksibel dan adaptif terhadap budaya pasien, menjadi suatu tindakan adaptif dan sensitif budaya.

Contoh intervensi SIKI berbasis transcultural:

- a. Edukasi kesehatan berbasis budaya
- b. Dukungan pengambilan keputusan
- c. Fasilitasi komunikasi keluarga
- d. Manajemen ansietas
- e. Kolaborasi dengan tokoh adat/spiritual

Contoh implementasi yang adaptif dan sensitif budaya:

- a. Menggunakan pendekatan komunikasi yang menghormati nilai lokal
- b. Mengizinkan praktik budaya yang tidak bertentangan dengan prinsip medis
- c. Melibatkan keluarga dalam diskusi terapi

5. Integrasi pada Evaluasi Keperawatan

Evaluasi dilakukan tidak hanya berdasarkan indikator klinis, tetapi juga kesesuaian dengan kepuasan dan nilai budaya pasien.

Kriteria evaluasi:

- a. Pasien menerima intervensi tanpa konflik budaya
- b. Terjadi peningkatan kepercayaan terhadap tenaga kesehatan
- c. Kepatuhan terhadap terapi meningkat
- d. Keluarga menunjukkan keterlibatan aktif.

Integrasi model asuhan keperawatan transkultural pada tahapan evaluasi keperawatan bersifat holistik dan mempertimbangkan aspek bio-psiko-sosio-spiritual.

Keunggulan yang diperoleh dari adanya Integrasi SDKI–SLKI–SIKI dalam Model Transkultural yaitu: a) memberikan standar praktik yang jelas dan terukur; b) meningkatkan kualitas dokumentasi keperawatan; c) memastikan asuhan keperawatan yang dilakukan itu tetap evidence-based namun kontekstual; d) memperkuat profesionalisme perawat Indonesia; dan e) mendukung keselamatan pasien dan kepuasan layanan.

Adanya integrasi SDKI–SLKI–SIKI dalam model transkultural berdampak pada implikasi praktis yang terjadi berupa tuntutan agar perawat memiliki kompetensi budaya (cultural competence), menguasai standar SDKI–SLKI–SIKI, mampu berpikir kritis-adaptif serta menjalin kolaborasi lintas budaya dan profesi. Dengan integrasi ini, maka model asuhan keperawatan transkultural berbasis konteks Indonesia menjadi lebih operasional, aplikatif, dan sesuai dengan standar nasional praktik keperawatan.

G. Studi Kasus Kontekstual Indonesia

Sebagai ilustrasi, seorang pasien menolak tindakan medis karena lebih percaya pada pengobatan tradisional. Dalam pendekatan keperawatan transkultural, perawat tidak langsung menolak kepercayaan tersebut, tetapi melakukan pendekatan edukatif dan kolaboratif.

Perawat dapat mengintegrasikan terapi medis dengan praktik tradisional yang tidak berbahaya, serta melibatkan keluarga dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini terbukti meningkatkan kepercayaan pasien dan keberhasilan terapi.

Berikut ini adalah gambaran contoh aplikasi kasus keperawatan transkultural yang terintegrasi dengan SDKI–SLKI–SIKI:

Kasus 1: Konflik antara terapi medis dan kepercayaan tradisional, dimana seorang pasien penderita diabetes mellitus menolak pemberian terapi insulin karena keyakinan dirinya percaya pada pengobatan herbal tradisional.

Pengkajian:

1. Pasien meyakini insulin menyebabkan ketergantungan
2. Keluarga mendukung penggunaan herbal

Diagnosis Keperawatan (SDKI):

1. Ketidakpatuhan berhubungan dengan keyakinan perbedaan nilai budaya terhadap pengobatan.
2. Defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang informasi

Tujuan Keperawatan (SLKI):

1. Kepatuhan pengobatan meningkat
2. Pengetahuan tentang penyakit meningkat

Intervensi Keperawatan (SIKI):

1. Edukasi kesehatan berbasis budaya
2. Dukungan pengambilan keputusan keluarga
3. Kolaborasi penggunaan herbal yang aman

Evaluasi:

1. Pasien bersedia menggunakan insulin bersamaan dengan terapi herbal yang tidak berinteraksi
2. Keluarga mendukung terapi medis

Kasus 2: Pengambilan Keputusan Berbasis Keluarga Besar

Seorang laki-laki berusia 58 tahun, Tn. S, dirawat di ruang penyakit dalam rumah sakit daerah dengan diagnosis gagal ginjal kronik stadium akhir. Dokter menyarankan tindakan hemodialisis rutin karena kondisi pasien mengalami penurunan fungsi ginjal yang signifikan. Secara medis, tindakan tersebut perlu segera dilakukan untuk mempertahankan kualitas hidup pasien.

Namun, keputusan tindakan tidak dapat segera dilakukan karena keluarga meminta waktu untuk melakukan musyawarah keluarga besar. Anak tertua pasien menyatakan bahwa keputusan penting harus dibicarakan bersama seluruh anggota

keluarga, termasuk paman tertua dan tokoh agama keluarga yang tinggal di luar kota.

Selama proses tersebut, pasien tampak pasif dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada keluarga. Istri pasien mengatakan bahwa keluarga khawatir tindakan hemodialisis akan memperburuk kondisi pasien dan menyebabkan ketergantungan alat medis seumur hidup.

Perawat mulai menghadapi situasi dilematis karena: 1) Kondisi klinis pasien membutuhkan keputusan cepat; 2) Keluarga meminta penundaan tindakan; 3) Pasien tidak menunjukkan otonomi individual dalam pengambilan keputusan; 4) Terdapat pengaruh budaya dan religiusitas yang kuat dalam keluarga.

Analisis Kasus:

Dilakukan dengan menggunakan model asuhan transkultural berbasis Indonesia menekankan pendekatan holistik bio-psiko-sosio-spiritual dengan mempertimbangkan nilai kekeluargaan, musyawarah, religiusitas, dan penghormatan terhadap struktur sosial budaya.

1. Pengkajian Budaya (*Cultural Assessment*). Pada tahap pengkajian, perawat tidak hanya mengumpulkan data biologis, tetapi juga mengidentifikasi faktor budaya yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Hasil pengkajian menunjukkan Struktur keluarga adalah Patriarkal dan kolektivistik, Pengambil keputusan yaitu anak tertua dan keluarga besar, Kepercayaan kesehatan dan spiritual sebagai Keputusan yang mempertimbangkan pandangan agama, sedangkan respon pasien tampak pasif dan mengikuti keluarga.
2. Melalui analisis budaya, Kasus ini menunjukkan karakteristik masyarakat Indonesia yang kolektivistik, di mana keputusan kesehatan tidak sepenuhnya ditentukan oleh individu pasien, melainkan melalui mekanisme keluarga besar. Dalam budaya tertentu di Indonesia, penghormatan terhadap orang yang dituakan menjadi faktor dominan dalam pengambilan keputusan (Koentjaraningrat, 2015).
3. Diagnosis Keperawatan (SDKI). Berdasarkan hasil pengkajian, diagnosis keperawatan yang mungkin muncul antara lain:
 - a. Konflik Pengambilan Keputusan berhubungan dengan perbedaan persepsi keluarga terhadap tindakan medis dan pengaruh budaya kolektivistik ditandai Ditandai dengan penundaan persetujuan tindakan, keluarga tampak ragu, pasien menyerahkan keputusan kepada keluarga
 - b. Ansietas Keluarga berhubungan dengan kurangnya pemahaman tentang hemodialisis dan ketakutan terhadap ketergantungan alat medis yang

ditandai dengan keluarga tampak khawatir dan banyak pertanyaan tentang risiko tindakan.

- c. Defisit Pengetahuan berhubungan dengan informasi tidak adekuat mengenai gagal ginjal dan hemodialisis yang ditandai dengan keluarga memiliki persepsi yang tidak tepat tentang terapi.

4. Luaran Keperawatan (SLKI):

- a. Pengambilan keputusan meningkat (keluarga mampu menentukan keputusan secara realistis)
- b. Tingkat ansietas menurun (Keluarga tampak lebih tenang)
- c. Pengetahuan meningkat (Keluarga memahami manfaat dan risiko terapi)
- d. Koping keluarga efektif (Keluarga mampu mendukung pasien)

5. Intervensi Keperawatan (SIKI)

- a. Dukungan pengambilan keputusan dengan cara berikan waktu musyawarah keluarga
- b. Edukasi kesehatan dengan menjelaskan hemodialisis dengan bahasa sederhana
- c. Dukungan spiritual melalui upaya memfasilitasi konsultasi keluarga dengan tokoh agama
- d. Fasilitasi komunikasi keluarga, membantu diskusi keluarga dengan tim kesehatan
- e. Reduksi ansietas, mendengarkan kekhawatiran keluarga

6. Implementasi keperawatan melalui Pendekatan Transkultural.

Dalam implementasi, perawat menggunakan prinsip:

- a. Menghormati nilai budaya keluarga;
- b. Tidak memaksakan keputusan medis secara otoriter;
- c. Menjalin hubungan terapeutik berbasis empati;
- d. Mengedepankan komunikasi kolaboratif.

Perawat kemudian mengatur pertemuan keluarga bersama dokter dan tokoh agama yang dipercaya keluarga. Pada pertemuan tersebut dijelaskan tentang Fungsi hemodialysis, Risiko jika terapi ditunda dan Kemungkinan pasien tetap menjalani aktivitas dengan kualitas hidup lebih baik. Pendekatan ini membuat keluarga merasa dihargai dan tidak diabaikan nilai budayanya.

7. Evaluasi. Setelah dilakukan edukasi dan musyawarah:

- a. Keluarga menyetujui tindakan hemodialisis
- b. Tingkat kecemasan keluarga menurun
- c. Pasien tampak lebih tenang
- d. Hubungan terapeutik antara keluarga dan tenaga kesehatan membaik

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pendekatan sensitif budaya dapat meningkatkan penerimaan keluarga terhadap terapi medis.

Dalam budaya Indonesia, keputusan kesehatan sering dipandang sebagai keputusan sosial, bukan hanya keputusan individual. Oleh karena itu, pendekatan bioetik Barat yang menekankan otonomi individu secara absolut terkadang perlu disesuaikan dengan konteks budaya lokal (Andrews & Boyle, 2020).

Dalam masyarakat Indonesia, keluarga merupakan unit utama dalam pengambilan keputusan kesehatan. Perawat perlu mengidentifikasi struktur keluarga, memahami siapa pengambil keputusan utama, dan melibatkan keluarga secara aktif serta memahami bahwa keterlibatan keluarga bukan bentuk hambatan, tetapi bagian dari sistem pendukung pasien.

H. Tantangan dan Strategi Pengembangan Model Asuhan Transkultural

Pengembangan model asuhan keperawatan transkultural berbasis konteks Indonesia menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang humanis, aman, dan berorientasi pada kebutuhan pasien.

Konsep keperawatan transkultural telah berkembang secara global, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, baik pada aspek pendidikan, praktik klinik, sistem pelayanan, maupun kebijakan kesehatan. Pengembangan model transkultural yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia memerlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan.

1. Tantangan Pengembangan Model Asuhan Transkultural

a. Keberagaman Budaya yang Sangat Kompleks

Indonesia memiliki lebih dari 1.300 kelompok etnis dengan karakteristik budaya yang berbeda-beda (Badan Pusat Statistik, 2020). Setiap kelompok memiliki sistem nilai, pola komunikasi, kepercayaan kesehatan, serta praktik pengobatan tradisional yang unik.

Perbedaan budaya ini menjadi tantangan bagi perawat dalam memberikan asuhan yang sensitif budaya. Pendekatan yang efektif pada satu kelompok masyarakat belum tentu sesuai diterapkan pada kelompok lainnya. Sebagai contoh, beberapa masyarakat lebih terbuka terhadap intervensi medis modern, sedangkan kelompok lain lebih mempercayai pengobatan tradisional atau spiritual.

Menurut Madeleine Leininger (2002), kegagalan memahami budaya pasien dapat menyebabkan cultural conflict, penolakan terapi, hingga ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan (Leininger & McFarland, 2006).

b. Rendahnya Kompetensi Budaya Tenaga Kesehatan

Kompetensi budaya (cultural competence) merupakan kemampuan tenaga kesehatan untuk memahami, menghargai, dan mengintegrasikan budaya pasien dalam pelayanan kesehatan. Namun, banyak tenaga kesehatan di Indonesia yang masih memiliki keterbatasan dalam aspek tersebut.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendidikan keperawatan masih lebih menekankan aspek biomedis dibanding pendekatan sosial budaya. Akibatnya, perawat sering mengalami kesulitan ketika menghadapi pasien dengan latar belakang budaya yang berbeda (Andrews & Boyle, 2020).

Keterbatasan kompetensi budaya dapat menyebabkan:

- 1) Hambatan komunikasi terapeutik
- 2) Kesalahan interpretasi perilaku pasien
- 3) Konflik nilai antara pasien dan tenaga kesehatan
- 4) Penurunan kualitas asuhan keperawatan

c. Dominasi Pendekatan Biomedis

Sistem pelayanan kesehatan modern di Indonesia masih cenderung berorientasi pada pendekatan biomedis. Fokus utama pelayanan lebih diarahkan pada penyembuhan penyakit secara fisik dibanding pemahaman holistik terhadap pasien.

Pendekatan biomedis seringkali kurang mempertimbangkan: a) Nilai budaya pasien; b) Spiritualitas; c) Peran keluarga dan d) Praktik kesehatan tradisional. Padahal dalam masyarakat Indonesia, kesehatan dipandang sebagai keseimbangan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual (Helman, 2007). Ketidaksesuaian antara pendekatan medis dan nilai budaya pasien dapat menyebabkan resistensi terhadap terapi.

d. Pengaruh Pengobatan Tradisional dan Kepercayaan Lokal

Pengobatan tradisional masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Penggunaan jamu, terapi herbal, pijat tradisional, hingga ritual spiritual masih banyak dilakukan sebagai alternatif maupun pelengkap pengobatan medis.

Meskipun beberapa praktik tradisional memiliki manfaat, sebagian lainnya dapat menimbulkan risiko apabila tidak terintegrasi dengan pelayanan kesehatan modern. Tantangan bagi perawat adalah bagaimana menghormati budaya pasien tanpa mengabaikan aspek keselamatan pasien.

World Health Organization menyatakan bahwa integrasi pengobatan tradisional ke dalam sistem kesehatan perlu dilakukan secara aman, terstandar, dan berbasis bukti ilmiah (WHO, 2013).

e. Hambatan Komunikasi dan Bahasa

Indonesia memiliki ratusan bahasa daerah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan bahasa dan gaya komunikasi sering menjadi hambatan dalam pelayanan kesehatan, terutama di daerah terpencil.

Selain bahasa verbal, budaya juga memengaruhi komunikasi nonverbal, seperti kontak mata, ekspresi emosi, dan cara menyampaikan pendapat. Kesalahpahaman komunikasi dapat menyebabkan:

- 1) Kesalahan interpretasi kondisi pasien
- 2) Ketidakpatuhan terhadap terapi
- 3) Menurunnya kepercayaan pasien terhadap tenaga kesehatan

Menurut Giger dan Haddad (2021), komunikasi merupakan salah satu komponen utama dalam pelayanan kesehatan berbasis budaya.

f. Keterbatasan Kebijakan dan Sistem Pendukung

Implementasi asuhan transkultural di Indonesia masih menghadapi keterbatasan kebijakan dan sistem pendukung. Belum semua institusi pelayanan kesehatan memiliki standar operasional yang mengintegrasikan aspek budaya dalam pelayanan.

Selain itu, dokumentasi keperawatan berbasis budaya juga masih belum optimal. Integrasi budaya ke dalam SDKI–SLKI–SIKI masih memerlukan pengembangan lebih lanjut agar lebih aplikatif dalam praktik klinik.

2. Strategi Pengembangan Model Asuhan Transkultural

a. Penguatan Pendidikan Keperawatan Transkultural.

Pengembangan model asuhan transkultural harus dimulai dari pendidikan keperawatan.

Kurikulum keperawatan perlu mengintegrasikan:

- 1) Konsep budaya dan kesehatan
- 2) Cultural assessment
- 3) Komunikasi lintas budaya
- 4) Etika transkultural
- 5) Praktik berbasis komunitas

Pembelajaran berbasis kasus dan pengalaman lapangan perlu diperkuat agar mahasiswa mampu memahami keberagaman budaya secara nyata.

b. Pengembangan Kompetensi Budaya Perawat.

Pelatihan cultural competence perlu dilakukan secara berkelanjutan bagi tenaga kesehatan. Kompetensi budaya meliputi:

- 1) Cultural awareness
- 2) Cultural knowledge
- 3) Cultural skill

4) Cultural encounter

5) Cultural desire

Konsep tersebut dikembangkan oleh Josepha Campinha-Bacote sebagai proses dinamis dalam pelayanan kesehatan (Campinha-Bacote, 2002).

c. Integrasi Budaya dalam SDKI–SLKI–SIKI

Pengembangan model transkultural di Indonesia perlu terintegrasi dengan standar nasional keperawatan yang dikembangkan oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia.

Integrasi tersebut meliputi:

1) Diagnosis berbasis faktor budaya

2) Luaran yang mempertimbangkan nilai pasien

3) Intervensi sensitif budaya

4) Dokumentasi cultural assessment

Pendekatan ini memungkinkan pelayanan tetap berbasis bukti namun kontekstual.

d. Penguatan Pelayanan Berbasis Keluarga dan Komunitas

Karakteristik masyarakat Indonesia yang kolektivistik menjadikan keluarga dan komunitas sebagai komponen penting dalam pelayanan kesehatan.

Strategi yang dapat dilakukan antara lain:

1) Melibatkan keluarga dalam pengambilan keputusan

2) Kolaborasi dengan tokoh adat dan agama

3) Pendekatan promosi kesehatan berbasis komunitas

4) Home care berbasis budaya lokal

Pendekatan ini terbukti meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap intervensi kesehatan.

e. Pengembangan Riset Keperawatan Transkultural

Penelitian menjadi dasar penting dalam pengembangan model transkultural berbasis Indonesia. Penelitian dapat difokuskan pada:

1) Praktik kesehatan budaya lokal

2) Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan

3) Efektivitas intervensi sensitif budaya

4) Pengembangan instrumen cultural assessment

Evidence berbasis lokal sangat penting agar model yang dikembangkan sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia.

f. Dukungan Kebijakan dan Sistem Kesehatan.

Pemerintah dan institusi kesehatan perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung pelayanan kesehatan berbasis budaya, antara lain:

1) Standar pelayanan sensitif budaya

- 2) Pelatihan budaya bagi tenaga kesehatan
- 3) Integrasi budaya dalam akreditasi rumah sakit
- 4) Penguatan layanan kesehatan komunitas

Kebijakan tersebut akan memperkuat implementasi model transkultural dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien secara sistematis.

I. Penutup

Model asuhan keperawatan transkultural berbasis konteks Indonesia merupakan pendekatan yang relevan dan strategis dalam menghadapi dinamika masyarakat Indonesia yang multikultural. Keberagaman etnis, bahasa, agama, sistem nilai, serta praktik kesehatan tradisional menuntut pelayanan keperawatan yang tidak hanya berorientasi pada aspek biologis, tetapi juga sensitif terhadap dimensi budaya, sosial, dan spiritual pasien.

Pengembangan model ini didasarkan pada karakteristik masyarakat Indonesia yang kolektivistik, religius, dan menjunjung tinggi nilai kekeluargaan serta musyawarah dalam pengambilan keputusan kesehatan. Oleh karena itu, penerapan model transkultural berbasis Indonesia menempatkan pasien, keluarga, dan komunitas sebagai bagian integral dalam proses keperawatan. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya hubungan terapeutik yang lebih humanis, empatik, dan kontekstual.

Integrasi model transkultural dengan standar nasional keperawatan melalui SDKI, SLKI, dan SIKI menjadi langkah penting dalam memperkuat praktik keperawatan profesional di Indonesia. Pendekatan tersebut tidak hanya memastikan bahwa pelayanan keperawatan tetap berbasis bukti ilmiah (*evidence-based practice*), tetapi juga menjamin bahwa asuhan yang diberikan sesuai dengan nilai dan kebutuhan budaya pasien.

Namun demikian, implementasi model asuhan transkultural masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kompetensi budaya tenaga kesehatan, dominasi pendekatan biomedis, serta belum optimalnya integrasi budaya dalam sistem pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu, diperlukan komitmen bersama dari institusi pendidikan, organisasi profesi, fasilitas pelayanan kesehatan, dan pemerintah untuk memperkuat pengembangan kompetensi budaya perawat melalui pendidikan, pelatihan, riset, dan kebijakan kesehatan yang sensitif budaya.

Pada akhirnya, model asuhan keperawatan transkultural berbasis konteks Indonesia diharapkan mampu menjadi landasan dalam pengembangan praktik keperawatan yang profesional, inklusif, dan berkeadilan budaya. Model ini tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan

pasien, tetapi juga memperkuat identitas keperawatan Indonesia yang menghargai keberagaman sebagai kekuatan dalam pelayanan kesehatan.

Referensi

- Andrews, M. M., & Boyle, J. S. (2020). *Transcultural concepts in nursing care* (8th ed.). Wolters Kluwer.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik Indonesia 2020*. BPS RI.
- Campinha-Bacote, J. (2002). The process of cultural competence in the delivery of healthcare services: A model of care. *Journal of Transcultural Nursing*, 13(3), 181–184.
- Campinha-Bacote, J. (2011). Delivering patient-centered care in the midst of a cultural conflict: The role of cultural competence. *OJIN: The Online Journal of Issues in Nursing*, 16(2), 5.
- Douglas, M. K., Rosenkoetter, M., Pacquiao, D. F., Callister, L. C., Hattar-Pollara, M., Lauderdale, J., Milstead, J., Nardi, D., & Purnell, L. (2014). Guidelines for implementing culturally competent nursing care. *Journal of Transcultural Nursing*, 25(2), 109–121.
- Giger, J. N., & Haddad, L. G. (2021). *Transcultural nursing: Assessment and intervention* (8th ed.). Elsevier.
- Helman, C. G. (2007). *Culture, health and illness* (5th ed.). Hodder Arnold.
- Hofstede, G. (2011). Dimensionalizing cultures: The Hofstede model in context. *Online Readings in Psychology and Culture*, 2(1), 1–26.
- Jeffreys, M. R. (2016). *Teaching cultural competence in nursing and health care* (3rd ed.). Springer Publishing Company.
- Kleinman, A. (1980). *Patients and healers in the context of culture*. University of California Press.
- Koentjaraningrat. (2015). *Pengantar ilmu antropologi*. Rineka Cipta.
- Leininger, M. (2002). *Culture care diversity and universality: A theory of nursing*. National League for Nursing Press.
- Leininger, M., & McFarland, M. R. (2006). *Culture care diversity and universality: A worldwide nursing theory* (2nd ed.). Jones & Bartlett.
- Papadopoulos, I. (2018). *Culturally competent compassion*. Routledge.
- Parekh, B. (2006). *Rethinking multiculturalism: Cultural diversity and political theory* (2nd ed.). Palgrave Macmillan.
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia. (2017). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI)*. DPP PPNI.
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI)*. DPP PPNI.

- Persatuan Perawat Nasional Indonesia. (2019). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI)*. DPP PPNI.
- Purnell, L. (2018). *Transcultural health care: A culturally competent approach* (4th ed.). F.A. Davis.
- Rosenbaum, M. S., & Smallwood, C. B. (2013). *Culturally sensitive health care*. Wiley-Blackwell.
- Spector, R. E. (2017). *Cultural diversity in health and illness* (9th ed.). Pearson.
- Stanhope, M., & Lancaster, J. (2020). *Public health nursing: Population-centered health care in the community* (10th ed.). Elsevier.
- Sunaryo. (2016). *Psikologi untuk keperawatan*. EGC.
- Tomey, A. M., & Alligood, M. R. (2014). *Nursing theorists and their work* (8th ed.). Elsevier.
- World Health Organization. (2013). *WHO traditional medicine strategy 2014–2023*. WHO Press.
- World Health Organization. (2021). *Global strategic directions for nursing and midwifery 2021–2025*. WHO Press.
- Yosep, I., & Sutini, T. (2016). *Buku ajar keperawatan jiwa dan advance mental health nursing*. Refika Aditama.

Glosarium

A

Adaptasi Budaya: adalah proses penyesuaian individu atau kelompok terhadap lingkungan budaya yang berbeda tanpa kehilangan identitas budaya asal.

Ansietas: adalah respons emosional berupa perasaan khawatir, takut, atau tidak nyaman yang sering muncul akibat ancaman nyata maupun persepsi ancaman.

Asuhan Keperawatan: adalah serangkaian kegiatan praktik keperawatan yang diberikan kepada individu, keluarga, atau masyarakat melalui proses keperawatan.

Asuhan Keperawatan Transkultural: adalah Pendekatan keperawatan yang mempertimbangkan nilai, keyakinan, dan praktik budaya pasien dalam pemberian pelayanan kesehatan.

B

Bio-psiko-sosio-spiritual: adalah pendekatan holistik yang memandang manusia sebagai kesatuan aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual.

Budaya: adalah sistem nilai, keyakinan, norma, perilaku, dan praktik yang dipelajari dan diwariskan dalam suatu kelompok masyarakat.

Budaya Kolektivistik: adalah budaya yang menempatkan kepentingan kelompok atau keluarga di atas kepentingan individu.

C

Cultural Assessment: adalah proses pengkajian budaya pasien untuk memahami nilai, kepercayaan, praktik kesehatan, dan kebutuhan budaya dalam pelayanan kesehatan.

Cultural Awareness: adalah kesadaran individu terhadap adanya perbedaan budaya serta pengaruh budaya terhadap perilaku dan interaksi.

Cultural Competence: adalah kemampuan tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan yang efektif dan sensitif terhadap budaya pasien.

Cultural Encounter: adalah interaksi langsung dengan individu atau kelompok dari budaya yang berbeda untuk meningkatkan pemahaman budaya.

Cultural Skill: adalah kemampuan melakukan pengkajian dan intervensi kesehatan berbasis budaya.

D

Defisit Pengetahuan: adalah kondisi ketika individu atau keluarga mengalami kekurangan informasi atau pemahaman terkait kesehatan.

Diagnosis Keperawatan: adalah penilaian klinis terhadap respons individu, keluarga, atau komunitas terhadap masalah kesehatan aktual maupun potensial.

E

Evidence-Based Practice: adalah praktik pelayanan kesehatan yang didasarkan pada bukti ilmiah terbaik, pengalaman klinis, dan kebutuhan pasien.

Etnis: adalah kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan budaya, bahasa, sejarah, dan identitas sosial.

F

Family-Centered Care: adalah pendekatan pelayanan kesehatan yang melibatkan keluarga sebagai bagian penting dalam pengambilan keputusan dan proses perawatan pasien.

G

Gotong Royong: adalah nilai budaya Indonesia berupa kerja sama dan saling membantu dalam kehidupan sosial masyarakat.

H

Holistik: adalah pendekatan yang memandang manusia secara menyeluruh meliputi aspek fisik, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual.

I

Intervensi Keperawatan: adalah tindakan yang dilakukan perawat untuk membantu pasien mencapai tujuan kesehatan yang diharapkan.

J

Jamu: adalah pengobatan tradisional Indonesia yang menggunakan bahan herbal alami.

K

Keperawatan Transkultural: adalah cabang ilmu keperawatan yang mempelajari perbedaan dan persamaan budaya untuk memberikan asuhan yang sesuai dengan nilai pasien.

Kearifan Lokal: adalah nilai, pengetahuan, dan praktik tradisional yang berkembang dalam masyarakat setempat.

Kompetensi Budaya: adalah kemampuan tenaga kesehatan memahami dan menghormati keberagaman budaya dalam praktik pelayanan kesehatan.

Komunikasi Terapeutik: adalah komunikasi profesional yang bertujuan membantu proses penyembuhan pasien.

L

Leininger's Sunrise Model: adalah Model keperawatan transkultural yang dikembangkan oleh Madeleine Leininger untuk memahami pengaruh budaya terhadap kesehatan dan keperawatan.

Luaran Keperawatan: adalah hasil atau perubahan kondisi pasien yang diharapkan setelah dilakukan intervensi keperawatan.

M

Multikultural: adalah kondisi masyarakat yang terdiri atas berbagai kelompok budaya dengan identitas yang berbeda.

Musyawarah: adalah proses pengambilan keputusan bersama melalui diskusi untuk mencapai mufakat.

O

Otonomi Pasien: adalah hak pasien untuk menentukan pilihan terkait pelayanan kesehatannya sendiri.

P

Paternalistik: adalah pendekatan pengambilan keputusan yang didominasi pihak tertentu, seperti keluarga atau tenaga kesehatan.

Pengobatan Tradisional: adalah praktik kesehatan berbasis budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun.

Persepsi Sehat-Sakit: adalah pandangan individu atau kelompok tentang makna kesehatan dan penyakit berdasarkan nilai budaya.

Promosi Kesehatan: adalah upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan.

R

Religiusitas: adalah keyakinan dan praktik keagamaan yang memengaruhi perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari.

S

SDKI (Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia) : adalah Standar nasional yang digunakan untuk menetapkan diagnosis keperawatan di Indonesia.

SIKI (Standar Intervensi Keperawatan Indonesia) : adalah Standar nasional tindakan keperawatan yang digunakan dalam praktik profesional.

SLKI (Standar Luaran Keperawatan Indonesia) : adalah Standar nasional yang digunakan untuk menentukan luaran atau hasil keperawatan.

Spiritualitas: adalah Aspek kehidupan yang berkaitan dengan makna, tujuan hidup, keyakinan, dan hubungan dengan Tuhan atau kekuatan yang lebih tinggi.

T

Terapi Komplementer: adalah terapi tambahan yang digunakan bersamaan dengan pengobatan medis modern.

Transkultural: adalah Interaksi atau pendekatan yang melibatkan lebih dari satu budaya.

U

Universal Care: adalah pendekatan pelayanan kesehatan yang berlaku umum tanpa mempertimbangkan perbedaan budaya secara spesifik.

PROFIL PENULIS



Nimsi Melati, S.Kep., Ns., MAN. Lahir di Temanggung, 2 Maret 1989. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 pada Program Studi Keperawatan, STIKES Bethesda Yakkum tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan S1 di STIK Sint Carolus Jakarta tahun 2013, pendidikan S2 pada Trinity Univeristy of Asia dan lulus tahun pada tahun 2016. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2010 bekerja sebagai dosen STIKES Bethesda Yakkum hingga sekarang. Saat ini mengampu mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar, Keperawatan Medikal Bedah, Komunikasi Keperawatan dan Konsep Dasar Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, dan seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nimsi@stikesbethesda.ac.id



Tri Mustikowati, SKp., M.Kep., Lahir di Pati, 14 Oktober 1971. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 di Akademi Keperawatan Karya Husada Semarang, Jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Padjadjaran tahun 1998. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2018. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1994 sebagai Dosen Tetap di Akademi Keperawatan Karya Husada Semarang. Saat ini penulis bekerja di Program Studi Keperawatan Universitas Binawan mengampu mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, peneliti, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: tri@binawan.ac.id

PROFIL PENULIS



Sudarso, S.Kep.Ns., M.Kep Lahir di Sumenep, 20 Mei 1985. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Sarjana Keperawatan dan Profesi di Stikes Dian Husada Mojokerto. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2012. Saat ini penulis bekerja di STIKES Bahrul Ulum Jombang mengampu mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: muhamadsudarso29@gmail.com

Motto: "In patience there is strength, in politeness there is beauty, in firmness there is justice, and in caring there is meaning."



Natalia Elisa Rakinaung, S.Kep., Ns., MNS. Lahir di Tahuna pada tanggal 10 Maret 1987. Lulus S1 di Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Katolik De La Salle Manado tahun 2009 lulus Profesi Ners di Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Katolik De La Salle Manado tahun 2010 dan lulus Master Nursing of Science dengan Peminatan Family and Community Health Nursing di Kasetsart University, Thailand pada tahun 2015. Saat ini penulis

adalah dosen tetap di Program Studi Profesi Ners Fakultas Keperawatan Universitas Katolik De La Salle Manado mengampu mata kuliah Keperawatan Komunitas dan Psikososial dan Budaya dalam Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, peneliti, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nataliarakinaung02@gmail.com.

PROFIL PENULIS



Ns. Putro Simeulu, S.Kep., M.Kep., Lahir di Meudang Ara, 09 Januari 1974, Aceh Barat Daya, Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Studi Ilmu Keperawatan universitas Syiah Kuala tahun 2003. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada universitas Sumatera Utara dan lulus tahun 2013. Riwayat Pekerjaan diawali pada tahun 2005 sebagai dosen tetap di Akper Pemkab Aceh Selatan, saat ini penulis menjadi dosen tetap di Prodi D-III keperawatan Banda Aceh Poltekkes Kemenkes Aceh, mengampu mata kuliah

manajemen Keperawatan, Penulis Aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, peneliti, publikasi, seminar, penulis dapat di hubungi melalui e-mail : putroe-rafi@yahoo.co.id

Motto: Hidup bukan tentang seberapa banyak harta yang kita miliki, tetapi tentang seberapa besar diri kita bermanfaat untuk orang lain.



Dr. Nunuk Sri Purwanti, S.Kp., M.Kes., Lahir di Klaten, 28 Pebruari 1967. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Indonesia, lulus tahun 1993. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Gadjah Mada, lulus pada tahun 2004. Sedangkan Pendidikan S3 pada Program Studi Doktoral Ilmu Kedokteran dan Kesehatan, FK-KMK Universitas Gadjah Mada, diselesaikan pada tahun 2021. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1994 sebagai pendidik di Sekolah Perawat Kesehatan, Departemen Kesehatan

RI. Kemudian sejak tahun 2001, melebur sebagai dosen di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, Jurusan Keperawatan. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen pengampu mata kuliah keperawatan komunitas, keperawatan kelompok khusus, keperawatan keluarga dan keperawatan gerontik. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, dan publikasi ilmiah baik di jurnal nasional maupun internasional. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nunuksripurwanti@gmail.com.

Motto: "Bekerja dan berdo'a"

Sinopsis

Asuhan Keperawatan Transkultural dalam Masyarakat Multikultural Indonesia merupakan buku referensi yang membahas pentingnya pemahaman budaya dalam praktik keperawatan di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Keberagaman suku, bahasa, agama, adat istiadat, nilai sosial, dan sistem kepercayaan menjadikan pelayanan keperawatan tidak hanya berfokus pada aspek biologis, tetapi juga harus mempertimbangkan latar belakang budaya pasien, keluarga, dan komunitas.

Buku ini menguraikan konsep dasar teori keperawatan transkultural sebagai landasan dalam memberikan asuhan keperawatan yang sensitif budaya. Pembaca diperkenalkan pada prinsip-prinsip utama keperawatan transkultural, termasuk pentingnya pengkajian budaya, penghormatan terhadap nilai pasien, serta penerapan intervensi keperawatan yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat.

Pembahasan dilanjutkan dengan kajian mengenai keanekaragaman budaya dan sistem kepercayaan di Indonesia yang berpengaruh terhadap cara masyarakat memaknai sehat, sakit, penyembuhan, kelahiran, kematian, pola makan, kebersihan, serta pengambilan keputusan dalam perawatan kesehatan. Buku ini juga menjelaskan bagaimana persepsi sakit dan perilaku mencari pengobatan sering kali dipengaruhi oleh keyakinan keluarga, pengalaman turun-temurun, tokoh adat, tokoh agama, serta kepercayaan terhadap pengobatan modern maupun tradisional.

Salah satu bagian penting dalam buku ini adalah pembahasan mengenai integrasi praktik tradisional dalam asuhan keperawatan. Praktik tradisional yang masih digunakan oleh masyarakat perlu dipahami secara bijaksana oleh perawat agar dapat dilakukan pendekatan yang aman, etis, dan berbasis pada keselamatan pasien. Dengan pemahaman tersebut, perawat dapat menjadi penghubung antara kebutuhan budaya pasien dan standar pelayanan kesehatan profesional.

Buku ini juga menekankan pentingnya komunikasi terapeutik lintas budaya dalam membangun hubungan saling percaya antara perawat, pasien, dan keluarga. Kemampuan berkomunikasi secara empatik, menghargai perbedaan bahasa, memahami simbol budaya, serta memperhatikan komunikasi verbal dan nonverbal menjadi keterampilan penting dalam pelayanan keperawatan transkultural.

Pada bagian akhir, buku ini menawarkan gagasan mengenai model asuhan transkultural berbasis konteks Indonesia. Model ini dikembangkan dengan mempertimbangkan realitas masyarakat Indonesia yang plural, religius, komunal, dan memiliki kekayaan praktik kesehatan tradisional. Melalui buku ini, mahasiswa keperawatan, perawat, pendidik, dan praktisi kesehatan diharapkan mampu menerapkan asuhan keperawatan yang lebih humanis, inklusif, berbudaya, dan berpusat pada pasien.

Buku ini menjadi referensi penting dalam pengembangan pendidikan dan praktik keperawatan yang responsif terhadap keberagaman budaya, serta mendukung terciptanya pelayanan kesehatan yang bermutu, adil, dan menghormati nilai-nilai masyarakat Indonesia.

Asuhan Keperawatan Transkultural dalam Masyarakat Multikultural Indonesia merupakan buku referensi yang membahas pentingnya pemahaman budaya dalam praktik keperawatan di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Keberagaman suku, bahasa, agama, adat istiadat, nilai sosial, dan sistem kepercayaan menjadikan pelayanan keperawatan tidak hanya berfokus pada aspek biologis, tetapi juga harus mempertimbangkan latar belakang budaya pasien, keluarga, dan komunitas.

Buku ini menguraikan konsep dasar teori keperawatan transkultural sebagai landasan dalam memberikan asuhan keperawatan yang sensitif budaya. Pembaca diperkenalkan pada prinsip-prinsip utama keperawatan transkultural, termasuk pentingnya pengkajian budaya, penghormatan terhadap nilai pasien, serta penerapan intervensi keperawatan yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat.

Pembahasan dilanjutkan dengan kajian mengenai keanekaragaman budaya dan sistem kepercayaan di Indonesia yang berpengaruh terhadap cara masyarakat memaknai sehat, sakit, penyembuhan, kelahiran, kematian, pola makan, kebersihan, serta pengambilan keputusan dalam perawatan kesehatan. Buku ini juga menjelaskan bagaimana persepsi sakit dan perilaku mencari pengobatan sering kali dipengaruhi oleh keyakinan keluarga, pengalaman turun-temurun, tokoh adat, tokoh agama, serta kepercayaan terhadap pengobatan modern maupun tradisional.

Salah satu bagian penting dalam buku ini adalah pembahasan mengenai integrasi praktik tradisional dalam asuhan keperawatan. Praktik tradisional yang masih digunakan oleh masyarakat perlu dipahami secara bijaksana oleh perawat agar dapat dilakukan pendekatan yang aman, etis, dan berbasis pada keselamatan pasien. Dengan pemahaman tersebut, perawat dapat menjadi penghubung antara kebutuhan budaya pasien dan standar pelayanan kesehatan profesional.

Buku ini juga menekankan pentingnya komunikasi terapeutik lintas budaya dalam membangun hubungan saling percaya antara perawat, pasien, dan keluarga. Kemampuan berkomunikasi secara empatik, menghargai perbedaan bahasa, memahami simbol budaya, serta memperhatikan komunikasi verbal dan nonverbal menjadi keterampilan penting dalam pelayanan keperawatan transkultural.

Pada bagian akhir, buku ini menawarkan gagasan mengenai model asuhan transkultural berbasis konteks Indonesia. Model ini dikembangkan dengan mempertimbangkan realitas masyarakat Indonesia yang plural, religius, komunal, dan memiliki kekayaan praktik kesehatan tradisional. Melalui buku ini, mahasiswa keperawatan, perawat, pendidik, dan praktisi kesehatan diharapkan mampu menerapkan asuhan keperawatan yang lebih humanis, inklusif, berbudaya, dan berpusat pada pasien.

Buku ini menjadi referensi penting dalam pengembangan pendidikan dan praktik keperawatan yang responsif terhadap keberagaman budaya, serta mendukung terciptanya pelayanan kesehatan yang bermutu, adil, dan menghormati nilai-nilai masyarakat Indonesia.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620



ISBN 978-634-7556-93-6 (PDF)



9

786347

556936